Minas em TRANSIÇÃO

Sistema de Saúde

GOVERNO DE MINAS

MINAS É PRA FRENTE



SUMÁRIO

1. Demonstração do Sistema 3
2. Entregas e Políticas de Saúde 6
2.1. Atenção Primária 7
2.2. Atenção Especializada Ambulatorial 13
2.3. Atenção Hospitalar 21
2.4. Rede de Urgência e Emergência 33
2.5. Regulação do Acesso à Assistência 40
2.6. Transporte Eletivo (Transporta SUS, Veículos de Acesso Eletivo e Tratamento Fora do Domicílio) 46
2.7. Assistência Farmacêutica 49
2.8. Judicialização 54
2.9. Vigilância em Saúde 55
2.10. Consórcios 62
2.11. Gestão 66
2.12. Reparação em Saúde 77
3. Pontos de Atenção no fechamento de Governo 80
4. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo 82
ANEXO I 91
5. Competências da Secretaria 92
6. Organograma da Secretaria 92
ANEXO II 93
7. Competências da Vinculada 94
8. Organograma da Vinculada 94
9. Caderno de Entregas da Vinculada 96
9.1. Entregas Prioritárias 96
9.2. Outras Entregas Relevantes 105
10. Políticas Públicas continuadas do Sistema 106
10.1. Políticas Públicas Prioritárias 106
10.2. Outras Políticas Públicas Relevantes 111
11. Pontos de Atenção no fechamento de Governo 112
12. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo 113
ANEXO III 115

13. Competências da Vinculada 116
14. Caderno de Entregas da Vinculada 117
14.1. Entregas Prioritárias 118
14.2. Outras Entregas Relevantes 118
15. Políticas Públicas continuadas do Sistema 122
15.1. Políticas Públicas Prioritárias 122
15.2. Outras Políticas Públicas Relevantes 124
16. Pontos de Atenção no fechamento de Governo 125
17. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo 126
ANEXO IV 129
18. Competências da Vinculada 130
19. Organograma da Vinculada 130
20. Caderno de Entregas da Vinculada 131
20.1. Entregas Prioritárias 131
20.2. Outras Entregas Relevantes 136
Políticas Públicas continuadas do Sistema 136
20.3. Políticas Públicas Prioritárias 136
21. Pontos de Atenção no fechamento de Governo 137
22. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo 139
ANEXO V 140
23. Competências da Vinculada 141
24. Organograma da Vinculada 141
25. Caderno de Entregas da Vinculada 142
25.1. Entregas Prioritárias 142
25.2. Outras Entregas Relevantes 143
26. Políticas Públicas continuadas do Sistema 146
26.1. Políticas Públicas Prioritárias 146
26.2. Outras Políticas Públicas Relevantes 147
27. Pontos de Atenção no fechamento de Governo 149
28. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo 149

Legenda:

Plano de governo

Entrega e/ou política pública com correspondência identificada nas propostas do plano de governo do governador eleito.

Política avaliada

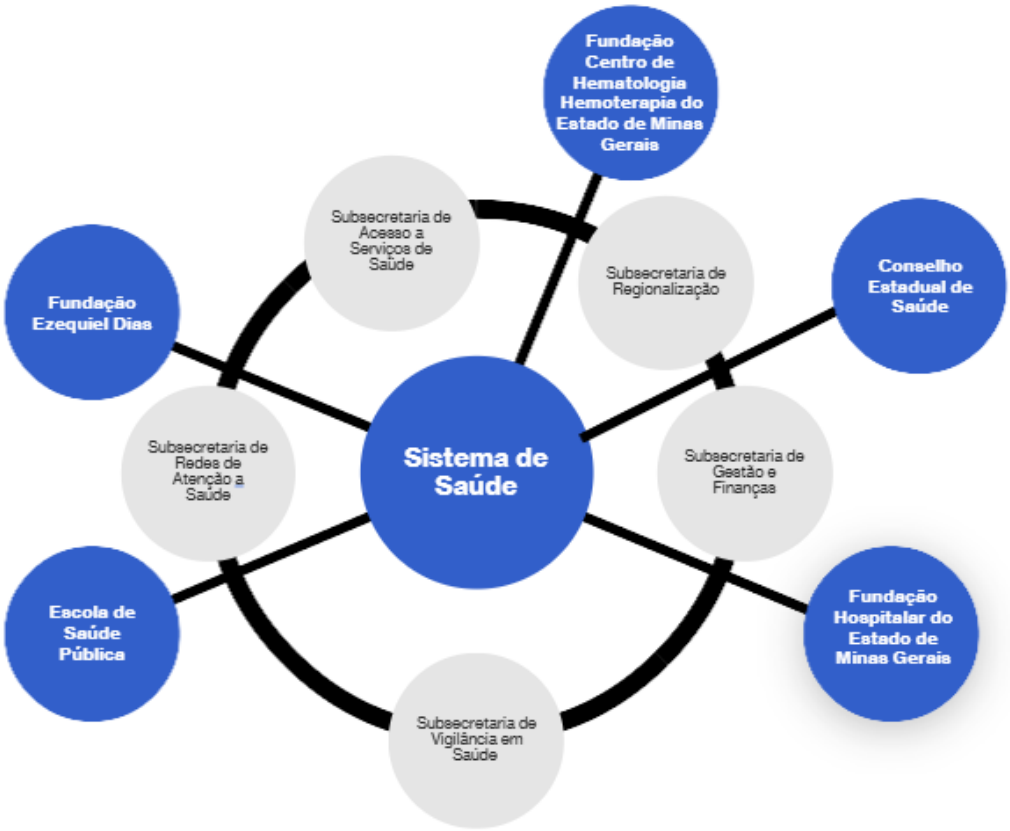
Política Pública avaliada pela Fundação João Pinheiro (FJP) ou no âmbito do Monitoramento Executivo da Seplag.

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA SAÚDE

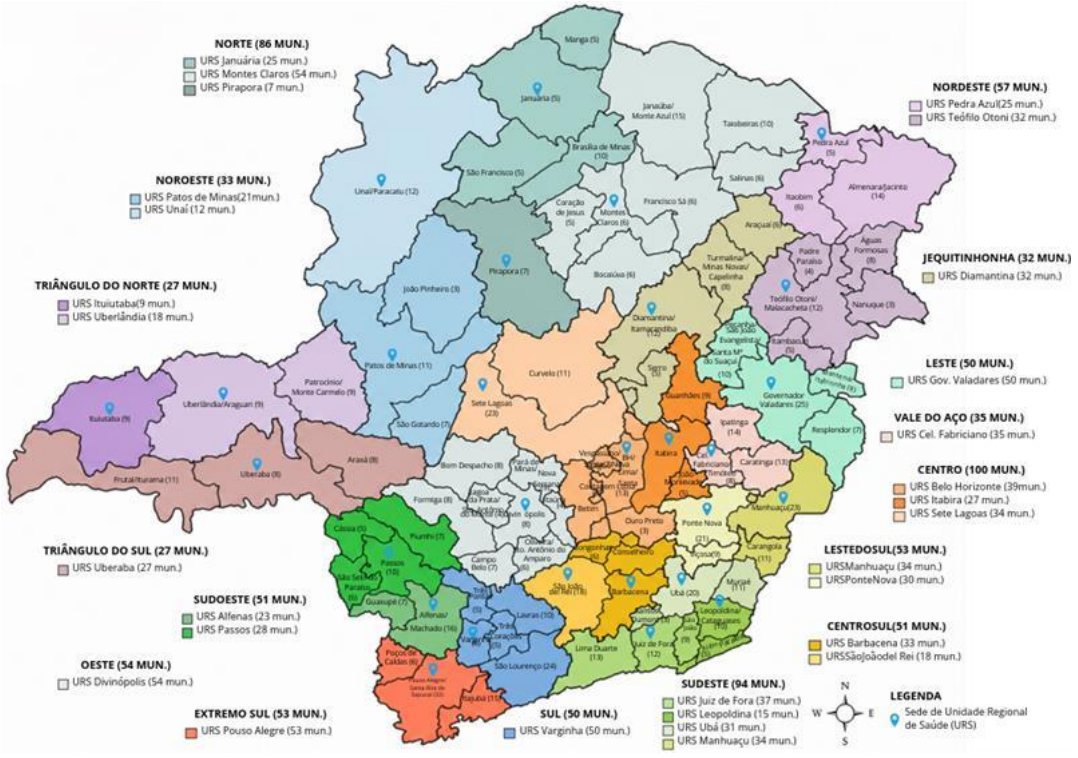
1. Demonstração do Sistema

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) é responsável pela formulação, regulação e promoção das políticas de saúde pública no Estado, bem como pela gestão, coordenação, controle e avaliação das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais. Compete ainda à Secretaria promover a regionalização e a descentralização dos serviços e ações de saúde, a qualificação dos profissionais do SUS e, de forma complementar, executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, nutricional e de saúde do trabalhador.

As entidades vinculadas e tecnicamente subordinadas à SES/MG atuam de forma complementar em áreas estratégicas da saúde pública estadual. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) presta serviços de saúde de média e alta complexidade, coordena o Sistema Estadual de Transplantes e atua na formação de profissionais de saúde. A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) é responsável pela oferta de sangue, hemoderivados, células e tecidos e pelo atendimento a pacientes com hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias. A Fundação Ezequiel Dias (Funed) desenvolve pesquisas científicas e tecnológicas em saúde pública, produz medicamentos e realiza análises laboratoriais relacionadas a agravos à saúde coletiva. A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG), por sua vez, atua na formação, qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, por meio de ações de educação permanente e do desenvolvimento de pesquisas em saúde.



Em relação à distribuição regional do Sistema Saúde em Minas Gerais, existem 28 Unidades Regionais de Saúde, distribuídas no território, conforme mapa a seguir:



Outro aspecto relevante da organização do Sistema Saúde, nos últimos 4 anos, foi o Planejamento Estratégico, elaborado em 2023. O planejamento teve como objetivo traçar uma visão de futuro clara, significativa e capaz de integrar e orientar os esforços das equipes. Ele foi dividido em objetivos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e objetivos para a Secretaria Estadual de Saúde (SES), sempre equiparando em importância a gestão e a assistência, com objetivo não só de gerar resultados efetivos aos cidadãos mineiros, mas também de deixar como legado uma secretaria mais organizada, com menos passivos, com processos mais eficientes e com agentes públicos mais capazes e satisfeitos. Ao todo foram elaborados 8 objetivos estratégicos para cada frente:

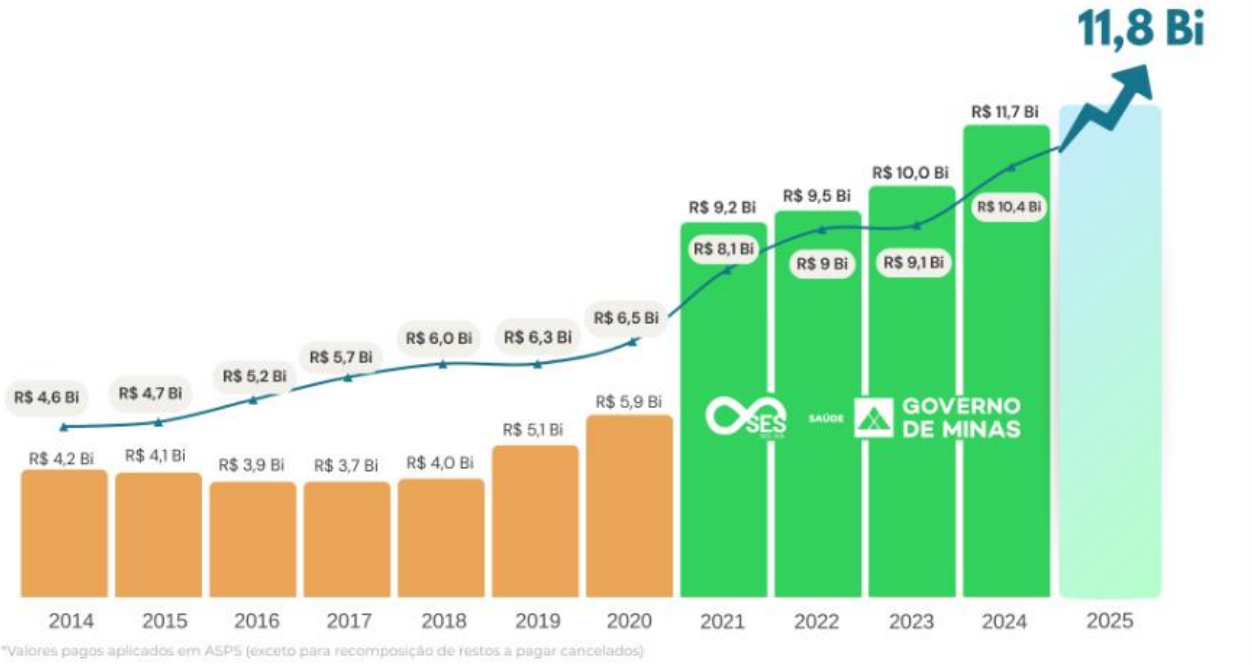
Objetivos SUS – ter o sistema de saúde organizado e eficiente, que ofereça cuidado regionalizado de qualidade, ordenado pela Atenção Primária, com equidade e foco em resultados reais para o cidadão	Objetivos SES – ter um ambiente gerencial organizado e saudável, que estimule a colaboração entre pessoas para a superação de problemas estruturais, com foco em resultados reais para o cidadão
1. Garantir a participação social na construção e na implementação das políticas de saúde	1. Prover a força de trabalho necessária para o alcance dos resultados
2. Ter redes de saúde prioritárias estruturadas e resolutivas	2. Formar equipes de alto desempenho
3. Aproximar os serviços de saúde do cidadão, por meio de uma Atenção Primária universal e um cuidado humanizado	3. Manter equipes satisfeitas e que se orgulhem de trabalhar na SES
4. Alcançar o maior nível de cobertura vacinal, para prevenir internações e óbitos	4. Promover a melhoria contínua de práticas de gestão
5. Modernizar e agilizar a assistência por meio da implantação de tecnologias de saúde	5. Dispor oportunamente de dados confiáveis para subsidiar a tomada de decisão
6. Promover o acesso às redes assistenciais, de acordo com a necessidade por procedimentos e serviços de saúde nos territórios	6. Gerir recursos com foco em resultados reais, simplificando e qualificando estratégias de financiamento
7. Integrar o atendimento pré-hospitalar à rede de urgência e emergência reduzindo a morbimortalidade	7. Qualificar o relacionamento institucional com atores externos para subsidiar a construção de políticas que garantam o acesso à saúde
8. Reduzir as taxas de mortalidade materna e infantil aos menores níveis da série histórica	8. Ser destaque nas agendas positivas do governo por meio da disseminação de conteúdos e entregas de qualidade

Desde então, compromissos, projetos e iniciativas têm sido pactuados, executados e monitorados para estar cada vez mais próximo de alcançar a visão organizacional de “Tornar real o SUS ideal”. Parte majoritária das entregas e das políticas a seguir foi concebida ou aprimorada mediante o foco estabelecido por esse planejamento estratégico.

Nos últimos anos, a execução financeira do Fundo Estadual de Saúde tem mantido resultados consistentes e acima dos parâmetros mínimos constitucionais, evidenciando o

comprometimento do Estado com o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. A seguir, apresenta-se a série histórica da execução financeira total, comparada ao piso constitucional exigido em cada exercício (representado pela linha de referência). Destaca-se, em especial, o recorde de investimento dos últimos 10 anos alcançado em 2025.

Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde em Minas Gerais x Mínimo Constitucional



A linha em azul indica o mínimo constitucional e as colunas representam a execução orçamentária.

2. Entregas e Políticas de Saúde

2.1. Atenção Primária

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do SUS e desempenha papel estratégico na organização da Rede de Atenção à Saúde, na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na continuidade do cuidado.

Em Minas Gerais, os recursos destinados à APS, considerando as diferentes origens de financiamento, totalizaram R$ 1,4 bilhão em 2023, R$ 876,3 milhões em 2024 e R$ 1,1 bilhão em 2025, correspondentes aos valores pagos no período. O pico de recursos aplicados se deu entre 2021 e 2023, totalizando R$839 milhões apenas para investimento, destinados majoritariamente à retomada de obras e construção de novas UBS.

Do total, os recursos estaduais pagos somaram R$ 1,1 bilhão em 2025, dos quais R$ 1 bilhão foi destinado ao custeio de políticas continuadas e R$89 milhões para o investimento na ampliação e qualificação das continuadas. Além do financiamento estadual regular, nesse montante incluem-se os recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas destinadas à APS, que totalizaram R$ 294,5 milhões em 2023, R$ 299 milhões em 2024 e R$ 501,2 milhões em 2025.

Para 2026, foram registrados R$ 649,9 milhões empenhados de origem estadual e R$ 470,9 milhões empenhados por meio de emendas parlamentares impositivas, totalizando aproximadamente R$ 1,1 bilhão empenhado.

2.1.1. Entregas

Entregas prioritárias

Expansão da Cobertura e Construção de UBS

Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** Desde 2019, a SES/MG prioriza o investimento de recursos estaduais para a retomada e conclusão de obras de Unidades Básicas de Saúde (UBS) paralisadas desde 2013 e para a construção de novas unidades, com o objetivo de ampliar e qualificar a estrutura da Atenção Primária à Saúde no estado. No período de 2019 a 2026, foram financiadas 445 UBS, das quais **215 UBS já foram entregues**.
- **Quantidade realizada:** Entrega de **215 novas UBS** e aumento da **cobertura da APS para 98%**, com previsão de alcançar 106% com a entrega das novas UBS.
- **Valor executado:** Foram registrados R$ 678 milhões em recursos destinados à construção de UBS.

- **Data de início e fim:** Início em 2022 - Conclusão 2029
- **Status:** Em andamento.
- **Informações adicionais:** Foi realizada a contratação de uma empresa de engenharia para auxiliar a SES/MG na realização do monitoramento de obras, de forma a somar esforços, permitindo realizar um acompanhamento mais próximo e completo da progressão das obras financiadas por esta SES.

Macrorregião	UBS pendente de entrega
Centro	20
Centro-Sul	14
Jequitinhonha	5
Leste	18
Leste Do Sul	9
Nordeste	11
Noroeste	18
Norte	43
Oeste	17
Sudeste	16
Sudoeste	9
Sul	15
Triângulo Do Norte	19
Triângulo Do Sul	5
Vale Do Aço	4
Extremo Sul	7
Total UBS pendente de entrega	**230**

2.1.2. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

TeleMaisSaúde MG Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A Estratégia TeleMaisSaúde MG, instituída pela Resolução SES/MG nº 10.394/2025, regulamenta, estrutura e institucionaliza as práticas de telessaúde no SUS-MG de forma permanente, articulada e integrada, para qualificar o cuidado, ampliar o acesso e fortalecer as Redes de Atenção à Saúde, em consonância com a Estratégia SUS Digital. A teleconsultoria – regulamentada pelo piloto da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.690/2024 e pela Resolução SES/MG nº 10.393/2025, que a institui como prática permanente da APS e da AAE – consiste na consulta entre profissionais de saúde para discussão de casos clínicos e está disponível nos 853 municípios. A teleorientação e a teleconsulta especializada, regulamentadas pela Resolução SES/MG nº 10.957/2026, foram implementadas em piloto em Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano.

  - **Fluxo de atendimento:** o cidadão acessa o MG App e realiza a teleorientação (plataforma da FELUMA), que define o caminho conforme a necessidade – agendamento na Unidade de Atenção Primária, orientações gerais ou encaminhamento à UPA ou a outro serviço de urgência;
  - no acompanhamento pela Atenção Primária, o profissional aciona a teleconsultoria, com resolubilidade de até 83% na APS;
  - havendo necessidade de especialista, o encaminhamento ocorre à distância – teleconsulta de onde o paciente estiver ou teleconsulta assistida na unidade – ou presencialmente, na rede especializada.
- **Resultados alcançados:**
  - **Teleconsultoria:** 139.903 teleconsultorias entre set/2024 e set/2026; 21,4 milhões de pessoas potencialmente beneficiadas; satisfação média de 4,75 em 5 dos profissionais;
  - A teleconsultoria possui efeito direto de redução da fila da atenção especializada (entre set/2024 e set/2026, 63% das intenções de encaminhamento foram evitadas), explicitando a necessidade de incentivar os municípios a instituírem a teleconsultoria como etapa obrigatória prévia ao encaminhamento à Atenção Especializada.
  - **Teleorientação:** Inspirada em experiências da Inglaterra e Dinamarca (onde a teleorientação é premissa para acesso aos serviços de saúde), o piloto em 3 municípios permitiu testar a metodologia e subsidiar padrão de fluxo e a expansão estadual da política. O fornecimento da teleconsulta e da teleconsultoria são contrapartidas oferecidas pelo estado para que os municípios ofereçam a teleorientação. Resultados do piloto até o momento: 328 teleorientações entre 07/04 e 30/09/2026, com crescimento progressivo (219, ou 67%, entre julho e setembro) – Vespasiano (132), Lagoa Santa (101) e Contagem (95); avaliação de 8,2/10 pelos profissionais da APS;
  - **Teleconsulta especializada:** 291 vagas ofertadas pela FELUMA entre maio e setembro de 2026 (cardiologia, neurologia e endocrinologia), com 193 teleconsultas agendadas.
- **Valor executado:** Até o momento, a operação tem sido sustentada principalmente por recursos federais, por meio de TED entre o Ministério da Saúde e o Hospital das Clínicas da UFMG, a Faculdade de Medicina da UFMG e o Hospital das Clínicas da UFTM, complementado pelo Termo de Doação da FELUMA. Para manter a política, a SES/MG publicou em 04/09/2026 o Edital de Credenciamento nº 2/2026, com valor global estimado de R$ 39,9 milhões, de fonte estadual, para 24 meses (até cinco Núcleos de Telessaúde), dos quais R$18 milhões estão previstos para 2027.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do TeleMaisSaúde MG traria prejuízo direto aos municípios, que hoje enfrentam uma demanda reprimida por consultas especializadas muito superior à capacidade de oferta da rede. Sem as ferramentas de telessaúde, essa demanda volta a pressionar as Secretarias Municipais de Saúde. Elas passam a arcar com filas mais longas, maior custo com transporte sanitário e deslocamento de usuários, e encaminhamentos que muitas vezes poderiam ser resolvidos na própria Atenção Primária à Saúde. Os resultados hoje já demonstram que 62% dos encaminhamentos para AAE foram evitados. O TeleMaisSaúde

MG funciona como ferramenta estratégica de organização da rede: qualifica os encaminhamentos, reduz deslocamentos e procuras desnecessárias por Atenção Ambulatorial Especializada. Com isso, fortalece a resolubilidade da APS como coordenadora do cuidado. Interromper o programa significaria desperdiçar a estrutura e o aprendizado já construídos.

- **Informações adicionais – Edital de Credenciamento em Telessaúde:** o edital credencia instituições com atuação comprovada em telessaúde, com preferência para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos de ensino, pesquisa e extensão, que atuarão como Núcleos de Telessaúde, responsáveis pela plataforma, pela capacitação e pela oferta de teleconsultorias assíncronas respondidas em até 72 horas. A vigência é indeterminada, com janelas semestrais para novos interessados, e a remuneração tem parcela fixa mensal de R$ 120 mil por núcleo e parcela variável de R$ 40 por teleconsultoria respondida no prazo. A transição dá à teleconsultoria uma fonte própria e previsível, que não depende de instrumentos federais temporários como o TED.

Política Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PEFAPS)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A PEFAPS tem como objetivo complementar o financiamento das ações e serviços de Atenção Primária à Saúde nos municípios, por meio de incentivos financeiros associados a critérios, indicadores e compromissos assistenciais e de gestão. O modelo considera, entre outros aspectos, a cobertura das equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal e indicadores relacionados à organização e à qualificação da Atenção Primária. A política possui abrangência estadual e contempla os 853 municípios de Minas Gerais, com transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. A partir da atualização promovida em 2026, os repasses passaram a ser organizados em três parcelas anuais, mantendo-se a vinculação do financiamento ao cumprimento dos critérios e indicadores estabelecidos. A PEFAPS constitui mecanismo de participação do Estado no financiamento da Atenção Primária, complementando os recursos federais e contribuindo para a manutenção e qualificação da oferta de serviços nos municípios.
- **Resultados alcançados:** A PEFAPS consolidou um modelo estadual de financiamento da Atenção Primária, associado ao monitoramento de indicadores e à utilização dos resultados municipais para orientar a distribuição dos recursos:
  - **manutenção do financiamento estadual aos 853 municípios**, com continuidade dos repasses ao longo do período;
  - **fortalecimento do financiamento associado ao desempenho**, com uso dos indicadores municipais para a distribuição dos recursos e da sobra orçamentária;
  - **98,47% de cobertura estimada das equipes de Saúde da Família** e, considerando as equipes que aguardam credenciamento do Ministério da Saúde, **106%**, além de **81,11% de cobertura estimada das equipes de Saúde Bucal**;
  - 112% de cobertura potencial da APS, considerando o cálculo do Ministério da Saúde.

  - financiamento de construção de UBS para **211 municípios**.
- **Valor executado:** R$ 434,6 milhões (2023), R$ 436,7 milhões (2024), R$ 435 milhões (2025) e R$ 270 milhões (pagamento parcial de 2026), totalizando R$ 1,6 bilhão, em repasses quadrimestrais. Para 2026, foi previsto o valor anual de R$ 437.122.406,90. O restante do valor previsto se refere à terceira parcela quadrimestral e será pago até o fim de 2026.(Resolução SES/MG nº 11.012/2026).
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do financiamento estadual, prevista na Resolução SES/MG n° 11.012, de 09 de abril de 2026, representa risco para a sustentabilidade financeira da Atenção Primária nos municípios, especialmente por se tratar de mecanismo de abrangência estadual e de caráter continuado. A interrupção ou redução significativa dos repasses pode comprometer a capacidade dos municípios de manter e qualificar ações e serviços da APS, além de enfraquecer o modelo de financiamento associado ao acompanhamento de indicadores e à indução de resultados. A continuidade da PEFAPS é, portanto, relevante para preservar a participação estadual no financiamento da APS, a previsibilidade dos recursos municipais e os mecanismos de monitoramento e qualificação construídos ao longo do período.

Outras políticas públicas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Promoção da Saúde e Políticas de Equidade	Financiamento de políticas de promoção da saúde, práticas integrativas e complementares (PICS) e equidade em saúde, com foco nas populações em vulnerabilidade, incluindo atividade física e práticas corporais, monitoramento alimentar e nutricional e educação em saúde, com repasses vinculados ao desempenho. Valores pagos: R$ 87 mi (2023), R$ 77 mi (2024), R$ 78 mi (2025) e R$ 44 mi (2026), total de R$ 286 milhões.	853 municípios alcançados pelo financiamento de promoção da saúde, PICS e equidade; 91 municípios com financiamento para equipes de atenção primária prisional; 21 municípios com financiamento estadual da PNASPI para a população indígena aldeada; apoio institucional à PNAISP, PNAISARI, Política Nacional de Controle do Tabagismo e Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e às políticas para populações em vulnerabilidade.
SES/MG	Política Estadual de Promoção da Saúde	Política estadual alinhada às diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, voltada à promoção da saúde e à articulação com as políticas de equidade, com financiamento estadual e mecanismos de monitoramento e avaliação.	Segundo o estudo de avaliabilidade da Política Nacional de Promoção da Saúde, Minas Gerais é apontado como a única unidade da Federação que consolidou uma política estadual de promoção da saúde.

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Linha de Cuidado da Pessoa com Sobrepeso e Obesidade	Instrumento orientador da organização do cuidado às pessoas com sobrepeso e obesidade na Rede de Atenção à Saúde, com foco na articulação dos serviços e na qualificação da assistência.	Elaborada em 2025, em fase de implantação; próximos passos: protocolos assistenciais e qualificação dos profissionais. A incorporação de novos medicamentos está em estudo.
SES/MG	Linha de Cuidado da Saúde da Criança	Organiza o percurso assistencial da criança na RAS, articulando a APS aos demais pontos de atenção, e inclui o Guia de Estratificação de Risco da Saúde da Criança e do Adolescente.	Padronizou o percurso assistencial da criança na RAS e instituiu critério único de estratificação de risco, o que permite à APS identificar precocemente crianças de maior risco e encaminhá-las ao ponto de atenção adequado. A linha qualifica o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e subsidia o planejamento da oferta especializada.
SES/MG	Linha de Cuidado da Saúde da Pessoa Idosa	Define responsabilidades e fluxos entre os pontos de atenção, da APS aos serviços especializados e à atenção domiciliar. Inclui o Guia de Estratificação de Risco da Pessoa Idosa e o Plano Operativo Estadual de Saúde da Pessoa Idosa (POESPI).	Definiu responsabilidades e fluxos entre APS, atenção especializada e atenção domiciliar. Com o guia de estratificação, as equipes passaram a contar com critério comum para identificar idosos frágeis e priorizar seu cuidado. O Plano Orientativo orienta as ações estaduais em andamento diante do envelhecimento acelerado da população mineira.
SES/MG	Plano Estadual de Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil	Aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.564/2021 (alterada pela nº 3.791/2022), organiza-se em quatro áreas: prevenção da gravidez não planejada, acesso universal a serviços de qualidade, qualificação dos profissionais e mobilização social.	Pactuado na CIB, o Plano estabeleceu uma agenda comum entre Estado e municípios para reduzir os óbitos evitáveis, integrando ações de prevenção da gravidez não planejada, ampliação do acesso aos serviços, qualificação profissional e mobilização social. Também orienta a vigilância e a investigação dos óbitos e direciona investimentos para a rede materno-infantil. Em 2025, a Razão de Mortalidade Materna apurada foi de 32,96 óbitos por 100 mil nascidos vivos, resultado inferior à meta

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
			pactuada de 40,25 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Destaca-se, ainda, o indicador de pré-natal adequado, que alcançou 60,30% em 2025, superando a meta do ciclo de 47%.
SES/MG	Plano Operativo Estadual de Saúde das Mulheres	Alinhado à PNAISM, busca melhorar a qualidade da assistência à saúde das mulheres em todas as fases do ciclo de vida, enfrentando iniquidades e promovendo a integralidade do cuidado.	Traduziu as diretrizes da PNAISM em ações concretas para o estado, integrando o cuidado às mulheres em todas as fases da vida e priorizando grupos em maior vulnerabilidade. O plano serve de referência para o planejamento regional e para a articulação das ações de saúde sexual e reprodutiva, prevenção do câncer e enfrentamento da violência.

2.2. Atenção Especializada Ambulatorial

2.2.1. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Especializa Minas Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A estratégia Especializa Minas, definida pelas Resoluções SES/MG nº 10.137 e nº 10.789/2025, promoveu a unificação das políticas de Atenção Ambulatorial Especializada antes organizadas nos modelos dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e de Ampliação da Média Complexidade (AMC). Atualizou as diretrizes assistenciais, definiu carteiras de cuidados especializados vinculadas às linhas prioritárias e instituiu metodologia de financiamento estadual com monitoramento por indicadores qualitativos e quantitativos. Atua nas linhas de pré-natal de alto risco, pediatria de risco/doenças raras, propedêutica do câncer de mama e colo do útero, hipertensão e diabetes de alto risco e obesidade. Em 2025, foram financiados 116 Pontos de Atenção Especializada.
- **Resultados alcançados:** Ampliação da resolubilidade microrregional nas Linhas de Cuidado Prioritárias, isto é, de procedimentos realizados dentro da própria microrregião de saúde, sem grandes deslocamentos pelo usuário do SUS: nas consultas de pediatria, 94,4% das microrregiões tiveram resolubilidade acima de 70%; nas ultrassonografias obstétricas (pré-natal), 96% das microrregiões e microrregiões agregadas superaram 80%; e, na propedêutica do câncer de mama, 86% das microrregiões agregadas tiveram resolubilidade acima de 70% para biópsia/exérese de nódulo,

punção por agulha grossa, anatomopatológico, mamografia (inclusive bilateral de rastreamento) e ultrassom mamário bilateral.

- **Valor executado:** R$ 81,2 milhões (2023), R$ 81,5 milhões (2024), R$ 119,9 milhões (2025) e R$ 97 milhões executados em 2026, de R$ 157,8 milhões previstos. a
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade da política Especializa Minas poderá comprometer o acesso a consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos nas linhas de cuidado prioritárias. Poderá, ainda, provocar aumento das filas de espera, necessidade de deslocamentos para outras regiões e agravamento das desigualdades territoriais no acesso à saúde, além de prejudicar a continuidade do acompanhamento de pacientes com condições crônicas e de alto risco.

Programa Miguilim - Saúde ocular nas escolas

Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:**
  Programa Miguilim – módulo de saúde ocular, regulamentado pela Resolução SES/MG nº 9.069, de 18 de outubro de 2023, tem como objetivo ampliar o acesso de estudantes de 5 a 18 anos da rede pública de ensino à assistência oftalmológica, por meio do financiamento estadual aos municípios e serviços pactuados. A política prevê recursos para a realização de consultas oftalmológicas e para o fornecimento de óculos aos estudantes com indicação, favorecendo a identificação e o tratamento de alterações visuais. Além disso, desenvolve ação intersetorial que inclui a triagem das crianças pelos profissionais de educação das escolas da rede pública de ensino, de forma a acelerar o diagnóstico e evitar o comprometimento da aprendizagem.
- **Resultados alcançados:** Como resultado esperado, busca-se ampliar a realização de consultas e a concessão de óculos, garantindo o encaminhamento dos estudantes identificados com alterações visuais para avaliação e tratamento adequados. Para a população, a iniciativa representa maior acesso à saúde ocular pelo SUS, contribuindo para a prevenção do agravamento de problemas de visão e para melhores condições de aprendizagem, desenvolvimento e qualidade de vida das crianças e adolescentes. Vale destacar que há uma dificuldade significativa no monitoramento dos dados do programa decorrente do não preenchimento dos mesmos pelos pontos de atenção no sistema desenvolvido para o monitoramento do programa. Assim, os dados disponíveis são parciais e devem ser analisados com cautela:
- Foram detectadas 84.909 triagens com alteração, que resultaram em 10.403 consultas e 7.482 óculos entregues. Foram inscritos 4.340 profissionais da saúde e da educação nos cursos de capacitação do programa.

- **Valor executado:** 2023: R$ 21.458.127,15; 2024: R$ 202.508,75; 2025:R$ 20.181.703,25; 2026: R$ 19.982.103,99
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do Programa Miguilim poderá comprometer o acesso ao diagnóstico e às consultas oftalmológicas de crianças e adolescentes no tempo adequado, comprometendo possivelmente seu desenvolvimento educacional.

Saúde Mental – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A RAPS é uma rede integrada de serviços que atende pessoas com sofrimento mental ou com problemas decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, organizada nos três níveis de atenção, em consonância com a Lei Federal nº 10.216/2001 e a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial:
  - **Atenção Primária:** Centros de Convivência e Cultura (CCC/CECO), Unidades de Acolhimento Adulto e Infantojuvenil (UAA/UAI) e Estratégia de Consultório de Rua (ECR) (Resolução SES/MG nº 8.107/2022);
  - **Atenção Especializada:** Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas modalidades, e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) - moradias para pessoas que permaneceram por no mínimo dois anos em hospitais psiquiátricos ou de custódia, sem suporte social ou familiar (Resolução SES/MG nº 10.773/2025);
  - **Atenção Hospitalar:** leitos de saúde mental em hospitais gerais, cofinanciados pelo Valora Minas, e leitos em quatro hospitais psiquiátricos – modelo cuja superação progressiva é priorizada, com fortalecimento dos serviços de base comunitária (Resolução SES/MG nº 7.223/2020);
  - o Estado cofinancia 131 CCC/CECO, 14 UA, 30 ECR, 465 CAPS, 139 SRT e 632 leitos em hospitais gerais; em 2026, criou a Casa de Acolhimento Terapêutico para os últimos pacientes do Hospital Colônia de Barbacena; e mantém a EAP-Desinst, que atua na desinstitucionalização de pessoas inimputáveis que cumpriram medida de segurança (destaque para o Hospital de Custódia Jorge Vaz).
- **Resultados alcançados:** A RAPS em Minas Gerais mantém 99,56% de cobertura populacional: 93,4% dos municípios possuem cobertura de pelo menos um CAPS e 91% contam com leitos de saúde mental em hospitais gerais. Além da ampliação e manutenção da oferta de cuidado em rede, 40 pacientes foram desinstitucionalizados nos últimos dois anos.
- **Valor executado:** Em 2025, R$ 128,5 milhões (R$ 109,1 milhões para CAPS e SRT e R$ 19,4 milhões para UAA, UAI, eCR e CCC). Em 2026, previsão de mais de R$ 122,7 milhões para CAPS e SRT, além de R$ 22 milhões para UAA, UAI, eCR e CCC.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do cofinanciamento estadual pode comprometer a sustentabilidade e a continuidade dos serviços da RAPS, com redução da oferta e risco de desassistência. A retração da rede pode sobrecarregar os serviços remanescentes, ampliar a demanda por internações e favorecer a reinstitucionalização de pessoas já desinstitucionalizadas. Também pode induzir à busca por alternativas não integradas à RAPS, como clínicas e comunidades terapêuticas, com risco de expansão de serviços clandestinos e de violações de direitos humanos, além de ampliar a judicialização e as demandas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça quanto às diretrizes da Reforma Psiquiátrica e ao cuidado em liberdade.

Linha de Cuidado da Doença Renal Crônica (DRC) / Hemodiálise

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A Linha de Cuidado da Doença Renal Crônica, cujas regras de financiamento foram definidas pela Resolução SES/MG 8.956/2023, tem como objetivo ampliar e descentralizar a oferta de tratamento dialítico no SUS em Minas Gerais, por meio do repasse de recursos para a construção e/ou ampliação de centros de hemodiálise, contribuindo para aproximar os serviços dos locais de residência dos pacientes e reduzir a necessidade de deslocamentos para outras regiões. A iniciativa também contempla o incentivo à diálise peritoneal, com o propósito de ampliar a oferta dessa modalidade pelos serviços de saúde, inclusive para a realização do tratamento no domicílio, conforme indicação clínica e organização assistencial. Dessa forma, a política busca fortalecer a rede regionalizada de atenção à DRC, ampliar a capacidade de atendimento e favorecer o acesso e a continuidade do tratamento para os usuários do SUS em Minas Gerais.
- **Resultados alcançados:**
  - 226 equipamentos financiados para a rede de DRC/Hemodiálise
  - 11 novos estabelecimentos especializados em DRC financiados entre 2022 e 2025, contribuindo para a redução de 60% na distância média percorrida pelos pacientes, através de resolução
  - 17 novos serviços a serem financiados, através de convênios, dos quais 13 estão em tramitação.
- **Valor executado:** Custeio de R$ 5,3 milhões (2024), R$ 4,9 milhões (2025) e R$ 4,1 milhões planejados para 2026;
  - Investimento em novos serviços de R$ 34,1 milhões (2023), R$ 4 milhões (2024) e R$ 8 milhões (2025); e investimento em equipamentos de hemodiálise de R$ 13,8 milhões (2023), R$ 1,8 milhão (2024) e R$ 14,2 milhões (2025) – cerca de R$ 86,1 milhões no período.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade da política pode comprometer a expansão e a regionalização da oferta de tratamento para a Doença Renal Crônica, dificultando a manutenção e ampliação dos serviços especializados e dos equipamentos financiados. Como consequência, pode haver redução do acesso à diálise peritoneal e maior concentração da assistência em determinados municípios, aumentando a necessidade de deslocamento de longas distâncias pelos pacientes.

Programa Estadual de Enfrentamento ao Câncer – Cuidar na Hora Certa

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** Amplia e qualifica o acesso ao rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer, com foco em diagnóstico precoce, tratamento em tempo oportuno e redução da mortalidade, por meio do repasse de recursos aos municípios para financiamento das linhas de cuidado com foco na jornada do usuário, da atenção primária à hospitalar. Atua em três frentes – câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de próstata – e no diagnóstico precoce:

- **Câncer de Mama** (Resolução SES/MG nº 10.968/2026): cinco eixos – busca ativa pela APS, ampliação das mamografias de rastreamento, redução do tempo para biópsias, Profissional Integrador do Cuidado em Rede e tratamento oportuno, com incentivo de R$ 1.500 por cirurgia realizada no prazo. Destaca-se a ampliação da faixa etária para rastreamento do câncer de mama, passando a contemplar mulheres de 40 a 74 anos, bem como a realização do exame sem a necessidade de solicitação médica. Inclui 62 novos mamógrafos, testes genéticos BRCA1/BRCA2 com a UFMG e aconselhamento genético nos Centros de Referência em Avaliação e Aconselhamento Genético (CRAAG – Resolução nº 11.196/2026), ação pioneira no país. Por fim, foi desenvolvida no MGApp a funcionalidade 'Minhas Mamografias', uma aba projetada para permitir que as usuárias acompanhem seu histórico de mamografias. A funcionalidade integra os dados do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) e, assim, possibilita à usuária verificar o histórico de exames realizados, identificar a data recomendada para a próxima mamografia e acessar orientações em saúde sobre o tema.
- **Câncer de Colo do Útero** (Resolução nº 10.966/2026): cinco eixos – vacinação contra HPV (9 a 14 anos), educação em saúde, rastreamento por citopatológico e teste de DNA-HPV (rastreio organizado iniciado em 2025, em implantação faseada em um projeto-piloto com Diamantina, Uberaba, Juiz de Fora e Santo Antônio do Monte), diagnóstico e tratamento oportunos;
- **Câncer de Próstata**: Linha de Cuidado no SUS/MG, protocolo para testagem oportuna a partir de sinais e sintomas e incentivo estadual para ressonância magnética multiparamétrica;
- **Diagnóstico Precoce** (Resolução nº 10.785/2025): bonificações para biópsias em 14 modalidades oncológicas, de até 1.000% sobre a Tabela SIGTAP (médias de 489% em câncer de boca, 390% em cabeça e pescoço, 415% em cânceres hematológicos, 254% em outras especialidades e 53% em próstata).

- **Resultados alcançados:**
  - aumento de 70% na cobertura de mamografias entre 2024 e 2025, que chegou a 34,11%;
  - 612 biópsias realizadas no tempo oportuno (2025) e painel de monitoramento do câncer de mama;
  - pacientes que iniciaram o tratamento em até 60 dias passaram de 67% (2015–2023) para 89,2% no 1º quadrimestre de 2026;
  - contratação de 85 profissionais integradores e plataforma de busca ativa em teste com previsão de lançamento em novembro;
  - previsão de 6 mil testes genéticos para rastreamento de câncer de mama no próximo triênio;
  - 22.604 kits de teste de DNA-HPV disponibilizados na 1ª fase;
  - incremento médio de 53% nos repasses para diagnóstico do câncer de próstata e aumento de 100% na produção de ressonância magnética multiparamétrica.
- **Valor executado:** R$ 67,4 milhões (2023 – aquisição de 62 mamógrafos), R$ 9,8 milhões (2024 – custeio), R$ 21,2 milhões (2025 – custeio) e R$ 28,2 milhões previstos para o custeio em 2026.

- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade das políticas voltadas ao diagnóstico e ao tratamento do câncer em tempo oportuno pode comprometer a continuidade da assistência, atrasar o diagnóstico e o início do tratamento, reduzir a efetividade das ações implementadas e ampliar o risco de agravamento da doença, com impactos diretos na qualidade de vida e nos desfechos clínicos dos pacientes.

Doenças Raras

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Deliberação CIB nº 5.003/2024) busca garantir atenção integral, humanizada e de qualidade, promovendo equidade, redução da morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida. A rede foi formalmente estruturada, com competências para a Atenção Primária e a Atenção Especializada e dois eixos de cuidado (doenças raras de origem genética e não genética). Em dezembro de 2024, foi aprovado incentivo financeiro, vigente desde 2025, para habilitação e manutenção dos serviços de referência, com ressarcimento de avaliações clínicas diagnósticas e aconselhamento genético; em 2026, a Resolução nº 11.011/2026 instituiu os Centros Estaduais de Referência em Plasmaférese. Destaca-se o Programa de Triagem Neonatal (PTN): Minas Gerais é o primeiro e único estado a triar 64 doenças pelo "teste do pezinho". O modelo adotado possibilita a coleta em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, nas maternidades de alto risco, nos casos em que o recém-nascido permanece internado, garantindo a triagem de 100% dos nascidos vivos no estado. Os casos identificados são encaminhados para confirmação diagnóstica e tratamento na rede pública de saúde, assegurando a continuidade do cuidado e o acesso ao tratamento indicado. O programa também prevê, quando necessário, o custeio de transporte e hospedagem para famílias de baixa renda que precisam se deslocar para concluir o processo diagnóstico, além do financiamento de medicamentos e fórmulas destinados ao tratamento das crianças triadas.
- **Resultados alcançados:**
  - expansão gradual do PTN: 13 doenças triadas até 2022, 23 no início de 2024, 60 ao final de 2024 e 64 em 2026;
  - 4.164 postos de coleta, com cobertura nos 853 municípios, e cerca de 1.100 testes por dia analisados pelo NUPAD/UFMG;
  - mais de 330 mil crianças triadas, das quais 1.674 iniciaram tratamento ambulatorial.
- **Valor executado:** Ampliação do PTN: R$ 22,5 milhões (2023), R$ 16 milhões (2024), R$ 64,3 milhões (2025) e R$42,6 milhões (2026). Política Estadual: R$ executado 1,7 milhão (2025) e planejado R$ 1,8 milhão para 2026.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade dessa política poderá comprometer o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento especializado e a continuidade do cuidado, com risco de agravamento das condições clínicas, desenvolvimento de sequelas evitáveis e aumento da morbimortalidade. A interrupção do financiamento poderá prejudicar a manutenção dos serviços de referência, a realização de avaliações

diagnósticas e aconselhamento genético, além de comprometer os avanços do Programa de Triagem Neonatal (PTN).

Saúde Bucal

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** Dentro da Atenção Especializada, a Política Estadual de Saúde Bucal é composta pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e pelos Serviços de Especialidades em Saúde Bucal (SESB). Além disso, contempla os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD).
- **Centros de Especialidades Odontológicas:** Os CEO são unidades de saúde responsáveis pelo atendimento especializado em saúde bucal. Devem ofertar à população, no mínimo, os seguintes serviços: diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer bucal, cirurgia oral dos tecidos moles e duros, periodontia especializada, endodontia, atendimento especializado às pessoas com necessidades especiais/deficiência. O Programa Estadual dos CEO é regido pela Resolução SES/MG nº 10.398, de 20 de agosto de 2025, que estabelece as regras para a implantação, o credenciamento e o financiamento estadual destes serviços no estado de Minas Gerais.
- **Reabilitação Protética Dentária:** consiste no cofinanciamento dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) credenciados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de qualificar e ampliar o acesso à oferta de reabilitação protética dentária no Sistema Único de Saúde (SUS). Os laboratórios devem assumir e operacionalizar suas atribuições e competências como serviços de apoio à atenção ambulatorial especializada e à Atenção Primária à Saúde (APS) em Saúde Bucal, conforme estabelecido nas diretrizes da Rede de Atenção à Saúde Bucal de Minas Gerais (RASB-MG), por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.660/2021, e nas respectivas linhas de cuidado em Saúde Bucal, atuando de forma integrada com os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e a APS, a fim de contribuir para a ampliação do acesso, a continuidade e a integralidade do cuidado.
- **Resultados alcançados:**
  - 115 CEO em funcionamento em MG, sendo que 98 fazem parte do Programa Estadual dos CEO;
  - Número de procedimentos endodônticos realizados pelos serviços CEO credenciados: 59.204 procedimentos (2023), 58.957 procedimentos (2024), 62.663 procedimentos (2025), 28.294 procedimentos (janeiro a julho de 2026);
  - 690 municípios possuem Laboratório de Prótese Dentária credenciado pelo Ministério da Saúde;
  - Número de próteses dentárias produzidas pelos municípios mineiros: 150.681 próteses (2023), 150.806 próteses (2024), 156.757 próteses (2025), 80.189 próteses (janeiro a julho de 2026)
- **Valor executado:** O financiamento da Rede de Atenção à Saúde Bucal, incluindo os Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios Regionais de Prótese Dentária e a Linha de Cuidado das Lesões de Lábio e Cavidade Bucal, cuja execução total foi de: R$ 75 milhões (2023), com adiantamento do pagamento para estruturação da rede, R$ 5,5 milhões

(2024) e R$ 24,1 milhões (2025). Para o exercício de 2026 foi planejado o recurso de R$ 50 milhões (2026).

- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do financiamento estadual da política de saúde bucal pode prejudicar a manutenção e a continuidade do fornecimento desse serviço à população, principalmente no que tange aos CEO, considerando que os recursos federais repassados aos municípios sede dos CEO são insuficientes para cobrir integralmente as despesas de manutenção e funcionamento. Dessa forma, o apoio financeiro estadual é fundamental para garantir a sustentabilidade dos serviços, a continuidade da assistência e a ampliação do acesso da população ao atendimento odontológico especializado.

Outras políticas públicas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Política Materno-Infantil	Ações estratégicas para reduzir a Razão de Mortalidade Materna de 40 para 30 por 100 mil nascidos vivos e a Taxa de Mortalidade Infantil de 11,11 para menos de dois dígitos por mil nascidos vivos até 2027: Linha de Cuidado Materno-Infantil; Rede de Medicina Fetal (Deliberações CIB-SUS/MG nº 5.140 e 5.141/2025); custeio da Rede de Bancos de Leite Humano da FIOCRUZ desde 2022; e Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, com a OPAS.	1 hospital credenciado para cirurgias intrauterinas e 6 ambulatórios para gestantes e fetos com malformações; 14 Bancos de Leite Humano e 31 Postos de Coleta financiados; razão de mortalidade materna de 44,35 (2019) para 32,96 (2025). Vale ressaltar que os dados finais de mortalidade após investigação dos casos são publicados com cerca de 1 ano de atraso no relatório do comitê de mortalidade materno infantil, o que pode gerar alguma divergência na informação, devido à atualização do SIM. pré-natal adequado de 38% (2024) para 60,3% (2025); 737 profissionais capacitados em 28 hospitais (285 médicos e 452 enfermeiros) e 17 instrutores formados.
SES/MG	Rede de Atenção em Oftalmologia	Estratégia instituída pela Resolução SES/MG nº 10.777/2025, que fortalece a assistência oftalmológica no SUS/MG por meio do financiamento e da organização dos serviços especializados, para ampliar consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Custeio: R$ 67.262.533,30 (2023), R$ 67.228.724,91 (2025) e R$ 54.394.804,88 (2026).	100% de cobertura com definição e pactuação das referências microrregionais e macrorregionais e organização da rede por tipologias assistenciais, sendo: 1) 95 municípios credenciados como ambulatórios básicos para tipologia I;

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
			2) 32 municípios credenciados como ambulatórios especializados para tipologia II; 3) 13 municípios credenciados como unidades de alta complexidade para tipologia III. Ampliação de **61%** em consultas oftalmológicas, **23%** de procedimentos diagnósticos e tratamento de glaucoma clínico, e aumento de **147**% para procedimentos cirúrgicos de catarata, contribuindo para o fortalecimento da linha de cuidado em saúde ocular no SUS-MG.
SES/MG	Linha de Doenças Respiratórias Graves	Estratégia instituída pela Resolução SES/MG nº 10.690/2025 para asma grave, DPOC, fibrose cística (adulto), doenças intersticiais e da circulação pulmonar e tratamento respiratório de doenças neuromusculares avançadas, com incentivo a Centros de Referência Estaduais e Unidades de Referência Macrorregional. Custeio: R$ 18,9 milhões (2024), R$ 218,4 milhões (2025) e R$ 21,7 milhões planejados (2026).	Com o financiamento de 10 serviços, foram realizadas 20.909 espirometrias entre os anos de 2023 e 2025.
SES/MG	Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD)	Instituída a partir da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.272/2012, organiza a atenção integral às pessoas com deficiência no SUS (prevenção, diagnóstico, reabilitação e autonomia), com Centros Especializados em Reabilitação, Oficinas Ortopédicas Itinerantes, CEMEAR, Saúde Auditiva, Triagem Auditiva Neonatal, OPM físicas e oftalmológicas, bolsas de ostomia, SERDI, PIPA e Programa Miguilim.	A rede conta com 394 serviços e financiamento estadual de R$ 201 milhões, previstos para 2026 distribuídos entre as diferentes políticas e modalidades de atendimento.

2.3. Atenção Hospitalar

A Atenção Hospitalar constitui um componente estratégico da Rede de Atenção à Saúde de Minas Gerais, desempenhando papel fundamental na organização, qualificação e ampliação da assistência hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua atuação abrange o

financiamento e o fortalecimento tanto da rede hospitalar própria do estado (FHEMIG) quanto das redes municipal e filantrópica, a ampliação da oferta de leitos e serviços especializados, a realização de procedimentos de média e alta complexidade e a promoção do acesso regionalizado aos serviços de saúde, com foco na equidade, na resolubilidade e na qualidade da assistência prestada à população mineira.

Entre 2023 e 2026, os recursos destinados à atenção hospitalar para a rede municipal e filantrópica totalizaram aproximadamente R$ 12,1 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em investimentos e R$ 10,5 bilhões em custeio. Somados aos R$ 8,6 bilhões aplicados na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), os recursos alcançam aproximadamente R$ 20,7 bilhões no período. Esse montante evidencia a dimensão do esforço financeiro do Governo de Minas Gerais para a manutenção, expansão e qualificação da rede hospitalar, contribuindo para o fortalecimento da assistência, a ampliação do acesso e a melhoria da capacidade de resposta às necessidades de saúde da população.

Com relação aos recursos de custeio, em 2026, foram aplicados R$4,4 bilhões somando os recursos para a rede própria e para a rede municipal e filantrópica, enquanto em 2018 o valor aplicado era de R$ 1,9 bilhão.

2.3.1. Entregas

Entregas prioritárias

Hospitais Regionais

Plano de governo | Política avaliada

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG (obras acompanhadas pela SEINFRA)
- **Descrição da Entrega:** Os Hospitais Regionais têm como objetivo ampliar o acesso à atenção hospitalar de média e alta complexidade e enfrentar vazios assistenciais existentes em Minas Gerais. A iniciativa contempla a conclusão, estruturação, equipamento, custeio inicial e viabilização da gestão de cinco hospitais regionais, localizados em Divinópolis, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas. Além da entrega da infraestrutura, o projeto busca assegurar a efetiva entrada das unidades em funcionamento e sua integração às Redes de Atenção à Saúde, ampliando a capacidade de atendimento e a resolubilidade das respectivas regiões.
- **Quantidade realizada:** 5 hospitais, com 1.174 leitos previstos. Divinópolis (inaugurado em 18/06/2026) e Teófilo Otoni (inaugurado em 15/05/2026) estão entregues e em funcionamento; Sete Lagoas foi finalizado em setembro de 2026 e aguarda a definição da entidade gestora; Conselheiro Lafaiete e Governador Valadares estão com obras em andamento.
- **Valor executado:** R$ 714.424.569,91, sendo R$ 333.817.017,86 em obras e R$ 380.607.552,05 em equipagem (detalhamento por hospital abaixo).

Origem dos recursos: Acordo da Vale de Brumadinho – Divinópolis, Teófilo Otoni, Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas e Acordo de Mariana/Rio Doce (Governador Valadares).

- **Data de início e fim:** Obras iniciadas a partir de 24/10/2022 (Teófilo Otoni), com término previsto até abril de 2027 (Conselheiro Lafaiete – prazo contratual).
- **Status:** Em andamento.

Informações adicionais – situação por hospital

Hospital	Situação e plano de escalonamento	Gestora	Leitos	Valor executado	Obra (início – fim)
Divinópolis	Entregue e em funcionamento. Escalonamento: 29 leitos até ago/2026; mais 37 de internação e 10 de UTI até nov/2026; 100% dos leitos até mai/2027 Ultrassonografia em nov/2026, diagnóstico completo até fev/2027 e cardiologia e obstetrícia a partir de ago/2027.	HU Brasil (antiga EBSERH)	196 (118 internação e 40 UTI, entre outros)	R$ 131.564.334,29	Fev/2023 a Jul/2025 (concluída)
Teófilo Otoni	Entregue e em funcionamento. Escalonamento: A primeira fase de escalonamento foi concluída em 30 de setembro de 2026, com a disponibilização de 100 leitos. Está prevista a ampliação progressiva da capacidade hospitalar para 136 leitos até janeiro de 2027, 382 leitos até maio de 2027 e 429 leitos até setembro de 2027, quando se prevê a operação plena da unidade, incluindo oito salas cirúrgicas. A expansão dos serviços assistenciais também contempla a oferta de especialidades como neurologia, cardiologia e oftalmologia.	Associação Mário Penna	429 (351 internação e 55 UTI, entre outros)	R$ 257.199.614,50	Out/2022 a Dez/2025 (concluída a obra) Maio/2026 inauguração do ambulatório Jun/2026 inauguração dos primeiros leitos SET/2026 - 100 leitos disponíveis
Sete Lagoas	Inaugurado setembro/2026; obra em desmobilização e recebimento formal pela SES. Edital republicado e licitação da entidade gestora; plano de escalonamento ainda não enviado. Parte dos atendimentos ambulatoriais do Hospital Municipal Monsenhor Flávio Damato foi transferida para o Regional.	A definir – gestão municipal (cessão do imóvel por 35 anos)	226 (176 internação e 50 UTI, entre outros)	R$ 173.819.987,52	Mar/2023 a setembro/2026 (Concluída a obra) Setembro/2026- início da operação ambulatorial
Conselheiro Lafaiete	Em fase de equipagem pelo Instituto HSVP; obra em andamento. Plano de escalonamento ainda não pactuado; início da operação estimável somente após o recebimento da obra.	Instituto de Saúde HSVP (concessão por 30 anos)	97 (77 internação e 20 UTI)	R$ 51.308.110,96	Ago/2025 a Mai/2027
Governador Valadares	Obra em andamento. Licitação da entidade gestora realizada; habilitação jurídica aguarda dois processos judiciais (incluindo	Resultado preliminar (set/2026): consórcio	226 (176 internação e 50 UTI)	R$ 100.532.522,64	Mar/2023 a Mar/2027

Hospital	Situação e plano de escalonamento	Gestora	Leitos	Valor executado	Obra (início – fim)
	ação popular). Plano de escalonamento aguarda homologação e contrato.	Hospital Bom Samaritano (GV) e Hospital São Francisco de Assis (BH)			

Investimentos para Fortalecimento da Atenção Hospitalar

Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** A estratégia de Investimentos em Atenção Hospitalar tem como objetivo ampliar e qualificar a capacidade assistencial dos hospitais de Minas Gerais por meio da aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes. Os investimentos contemplam equipamentos destinados a diferentes áreas da assistência, incluindo centros cirúrgicos, unidades de internação, terapia intensiva, diagnóstico por imagem, esterilização e suporte à assistência hospitalar, contribuindo para a modernização da estrutura disponível e para a ampliação da capacidade de atendimento da rede.
- **Quantidade realizada:**
  - Entre dezembro de 2019 e agosto de 2026, os leitos de **UTI Adulto** disponíveis ao SUS passaram de 2.013 para 2.668, correspondendo a um **acréscimo de 655 leitos (32,5%)**. No mesmo período, os leitos de **Unidade Coronariana** disponíveis ao SUS passaram de 45 para 127, representando **aumento de 82 leitos (182,2%)**.
  - No recorte entre outubro de 2025 e agosto de 2026, posterior à instituição da estratégia de financiamento de novos leitos de UTI Adulto e UCO pela Resolução SES/MG nº 10.697/2025, verificou-se acréscimo cadastral de 36 leitos SUS de UTI Adulto, enquanto o quantitativo de leitos SUS de UCO permaneceu em 127. No âmbito desta Resolução, a SES custeou cerca de 90 leitos durante o período pré-habilitação, sendo que 34 desses leitos foram posteriormente habilitados, e os demais 54 leitos seguem sendo custeados e ainda aguardam a publicação da portaria de habilitação federal.
  - Entre dezembro de 2019 e agosto de 2026, o CNES registra **aumento de 278 leitos existentes de UTI Pediátrica** em Minas Gerais, dos quais a variação líquida de leitos SUS foi de 91.
  - Desses, 36 leitos receberam investimentos de obra e equipagem pela SES/MG por meio da estratégia de estruturação de leitos UTI-PED (Resolução SES/MG nº 8.203). Outros 79 leitos seguem sendo estruturados até o momento da habilitação.
  - Entre 2023 e 2026, foram financiadas 1.146 indicações para investimentos na estruturação da atenção hospitalar e de urgência e emergência em Minas Gerais, contemplando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como aparelhos de anestesia, ventiladores pulmonares, camas hospitalares elétricas, mesas e focos cirúrgicos, monitores multiparâmetros, arcos cirúrgicos, aparelhos de raio-X, ultrassons, sistemas de videoendoscopia, autoclaves e tomógrafos, entre outros. As indicações financiadas totalizaram 58 em 2023, 272 em 2024, 631 em

2025 e 185 em 2026, beneficiando 314 convenentes distintos, distribuídos em 222 municípios mineiros.
    - Em 2021 foram repassados recursos para a compra de 104 tomógrafos, que foram adquiridos pelos municípios ao longo de 2023 e 2024. Ademais, houve o repasse para a compra de 62 mamógrafos, a fim de ampliar e modernizar o parque tecnológico dos hospitais do estado.
- **Valor executado:** Entre 2023 e 2026, foram investidos aproximadamente R$ 892,9 milhões na estruturação da atenção hospitalar e de urgência e emergência, dos quais R$ 605,8 milhões de recursos estaduais de acordo com demandas municipais e R$ 154,2 milhões de emendas parlamentares. Os investimentos foram distribuídos da seguinte forma: R$ 179,1 milhões (2023), R$ 217,6 milhões (2024), R$ 225,1 milhões (2025) e R$ 271,2 milhões (2026). Adicionalmente, destaca-se o investimento de R$ 160,2 milhões destinado à aquisição de equipamentos de tomografia computadorizada, conforme a Resolução SES/MG nº 7.874/2021, com previsão de 104 equipamentos para ampliação e modernização da capacidade diagnóstica da rede hospitalar. Ressalta-se que os recursos foram repassados em 2021, enquanto a aquisição dos equipamentos ocorreu em 2023.
- **Data de início e fim:** 2023 a 2026.
- **Status:** Em andamento.
- **Informações Adicionais**

  Para as regiões com menor resolubilidade, conforme será apresentado a seguir, destacam-se ações específicas para melhoria do indicador:
    - Jequitinhonha: Aparelhos de hemodiálise; estruturação de leitos de UTI pediátrica; equipamentos e materiais permanentes; arco cirúrgico, aparelho de anestesia e foco cirúrgico com vídeo; veículos para apoio assistencial; expansão das Carretas de Especialidades; e habilitação da oncologia no Hospital Nossa Senhora da Saúde.
    - Leste do Sul: Ampliação de leitos de UTI adulto tipo II e de UTI pediátrica no conjunto da macro. A micro Ponte Nova também recebe recursos do Plano do Rio Doce, detalhados a seguir.
    - Centro Sul: A principal ação estruturante é o Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, um dos cinco hospitais regionais prioritários da SES-MG, que permanecia em implantação em outubro de 2026. Também devem ser destacados os investimentos relacionados à UPA de Barbacena e à habilitação da neurologia de alta complexidade no Hospital Regional de Barbacena, ampliando a capacidade de resposta da rede e a oferta regional de assistência especializada. Além da oferta de OCI (4.019 executadas), destacam-se os investimentos na UPA de Barbacena e a habilitação da neurologia de alta complexidade no Hospital Regional, iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede assistencial.
    - Oeste: Investimentos em acesso eletivo e regulação (transporte sanitário e ambulância), apoio à gestão (veículo), qualificação da atenção especializada e hospitalar (ultrassom, anestesia e videolaringoscópio) e vigilância em saúde (veículo 4x4). A principal ação estruturante na macro é o Hospital Regional de Divinópolis, um

dos cinco hospitais regionais prioritários da SES-MG, com cerca de 200 leitos projetados.

- Noroeste: Ampliação de equipamentos e materiais permanentes e disponibilização de veículos para apoio assistencial. Também se destacam a habilitação da cardiologia na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e a habilitação da ortopedia no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), fortalecendo a oferta regional de procedimentos especializados e contribuindo para ampliar a resolubilidade. Sobre a micro São Gotardo, foram realizados investimentos em ampliação do acesso e da capacidade assistencial (estrutura hospitalar, atenção especializada, APS, transporte sanitário e vigilância). Também houve ampliação gradual da oferta, início da ortopedia e avanço na implantação de UTI, com remanejamento de recursos no fim de 2025.
- Leste: A macro sedia o Hospital Regional de Governador Valadares, um dos cinco hospitais regionais prioritários da SES-MG. A micro Mantena/Itabirinha recebeu investimentos na Rede de Urgência e Emergência, na Atenção Primária e no Programa Carreta de Especialidades, e passou a ser bipolar com a inclusão de Itabirinha no PDR 2025.
- Nordeste: Nas microrregiões Itaobim e Águas Formosas foram registrados investimentos na Rede de Urgência e Emergência e no Programa Carreta de Especialidades; em Águas Formosas, também na Rede de Saúde Bucal. A macro sedia o Hospital Regional de Teófilo Otoni, um dos cinco hospitais regionais prioritários da SES-MG e o de maior capacidade prevista do conjunto, com 429 leitos. A obra foi entregue em dezembro de 2025, e o funcionamento é gradual desde maio de 2026.

Plano de Investimento da Macrorregião Sudeste

Plano de governo

- **Nome do órgão:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** Estruturação do Plano de Investimento da Macrorregião Sudeste, abrangendo os 94 municípios das nove microrregiões, a partir da reorganização dos recursos inicialmente previstos para implantação do Hospital Regional de Juiz de Fora. O investimento, inicialmente previsto em R$ 150 milhões, foi ampliado para R$ 300 milhões, com foco no fortalecimento regionalizado da rede de atenção à saúde. O investimento, inicialmente previsto em R$ 150 milhões, foi ampliado para R$ 300 milhões, com foco no fortalecimento regionalizado da rede de atenção à saúde. O Plano contempla quatro eixos: atenção hospitalar, com investimentos em obras e equipamentos; urgência e emergência, incluindo o novo Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora, UPAs e renovação da frota do SAMU; atenção primária, com construção de UBS e aquisição de equipamentos; e transporte sanitário e consórcios intermunicipais de saúde. A iniciativa busca distribuir os investimentos conforme as necessidades do território, ampliando a capacidade assistencial, qualificando os serviços existentes e fortalecendo a rede regional de saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados mais próximos de sua residência.
- **Quantidade realizada:** Entre as iniciativas, destacam-se a aquisição de equipamentos para o Hospital Universitário e a Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, além do pagamento do projeto do novo Pronto Socorro. Em Ubá, os investimentos contemplam seis novas UBS, ambulância, veículos de transporte sanitário e equipamentos de

oftalmologia para o Hospital Santa Isabel. Em Muriaé, foram destinados quase R$ 8 milhões em equipamentos para o Hospital do Câncer.

- **Valor Executado:** Até o momento, foram repassados aproximadamente R$ 59 milhões, enquanto mais de 60% dos recursos já possuem destinação definida, considerando os investimentos executados e os encaminhados.
- **Status:** Em Andamento

Eficientização da gestão hospitalar

- **Nome do órgão/entidade:** FHEMIG
- **Descrição da Entrega:** Principal entrega do ciclo e expressão da visão institucional do Planejamento Estratégico da Fhemig 2024–2027: “ser reconhecida pela eficiência de sua gestão na oferta de serviços para a saúde pública”. Reúne governança clínica, gestão de leitos por dados (DRG), reorganização da rede assistencial e melhoria contínua. O acompanhamento ocorre por cinco indicadores-síntese da “Fhemig do Futuro”: taxa de ocupação, tempo médio de permanência, internações, cirurgias e doadores efetivos.
- **Quantidade realizada:** A melhoria da eficiência da rede na gestão 2019–2026 resultou de medidas articuladas em três frentes: organização da estrutura, reorganização da oferta e qualificação dos processos assistenciais.
    - **Organização da estrutura:** Foram criados três complexos hospitalares com gestão única: Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (CHU), em 2020 (HJXXIII, HIJPII e HMAL); Complexo Hospitalar de Especialidades (CHE), em 2021 (HAC e HJK); e Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB), em 2022 (HRB e CHPB). O compartilhamento de equipes, serviços de apoio, insumos e estrutura proporcionou ganho de escala e redução de custos. A Fhemig também desenvolveu metodologia própria para calcular a capacidade instalada e orientar metas de produção, classificada em 3º lugar no Prêmio Inova Minas 2024.
    - **Reorganização da oferta:** Com base na capacidade instalada, leitos e serviços foram redistribuídos conforme a vocação das unidades. Na saúde mental, o Hospital Galba Velloso (HGV) foi desativado em 2020 para disponibilização de leitos de retaguarda COVID, com remanejamento de pacientes e equipes para o IRS. Em 2021, foram abertos 40 leitos de apoio à Rede de Atenção Psicossocial em hospitais gerais da Fhemig: 10 no HJK, 10 no HJXXIII, 10 no HRJP e 10 no CHPB.

  Na linha cirúrgica, foram implantadas no HJK, em parceria com o CHU, as linhas de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia plástica reparadora e bucomaxilofacial. A atividade cirúrgica do HMAL foi concentrada no HJXXIII, e o prédio foi cedido à Santa Casa BH para implantação de Instituto Oftalmológico. O bloco cirúrgico do HCM foi reaberto em setembro de 2025, sendo o único de Sabará a realizar cirurgias. Desde fevereiro de 2026, o Opera Mais Fhemig promove mutirões mensais de cirurgias eletivas em sete hospitais, com mais de 900 cirurgias até setembro e meta superior a 1.000 no ano.

- **Qualificação dos processos:** A metodologia DRG, utilizada desde 2019, identifica internações que ultrapassam o tempo esperado para cada caso. A Medicina Hospitalista, em cooperação com a SES e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), foi implantada em sete hospitais, abrangendo 641 leitos, com acompanhamento contínuo dos pacientes e coordenação entre equipes clínicas e cirúrgicas. A metodologia Lean foi incorporada por meio da pós-graduação em Lean Six Sigma e do projeto Lean nas Emergências.

No HJXXIII, as cirurgias programadas passaram de 160 para 208 por mês, e a ocupação do centro cirúrgico subiu de 34% para 62%. No Complexo de Barbacena, as cirurgias aumentaram 51% e as suspensões caíram 56%. A superlotação das emergências diminuiu 23% no HJXXIII e 38% na MOV.

- **Resultados:** Com fluxos organizados e acompanhamento diário da internação, o paciente passou a ficar internado apenas o tempo necessário, liberando leitos para novos atendimentos, sejam clínicos ou cirúrgicos. Entre 2018 e 2025, as cirurgias passaram de 32.743 para 41.006 (+25%), maior marca em 20 anos; as internações cresceram 11%, de 57.471 para 64.048, com pico de 65.648 em 2024; a taxa de ocupação subiu de 76% para 87%, maior da série; o tempo médio de permanência caiu de 8,97 para 7,51 dias (−16%), menor em 20 anos; e a ineficiência global do uso do leito, medida pelo DRG, recuou 9,6% entre 2021 e 2025.
- **Valor executado:** Melhorias processuais sem valor diretamente executado.
- **Origem dos recursos:** Fonte 68 (Edital de estágios).
- **Data de início e fim:** 2019–2026 (PE 2020–2023 e PE 2024–2027).
- **Status:** Em andamento.

2.3.2. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Valor em Saúde e Hospitais de Pequeno Porte

Plano de governo | Política avaliada

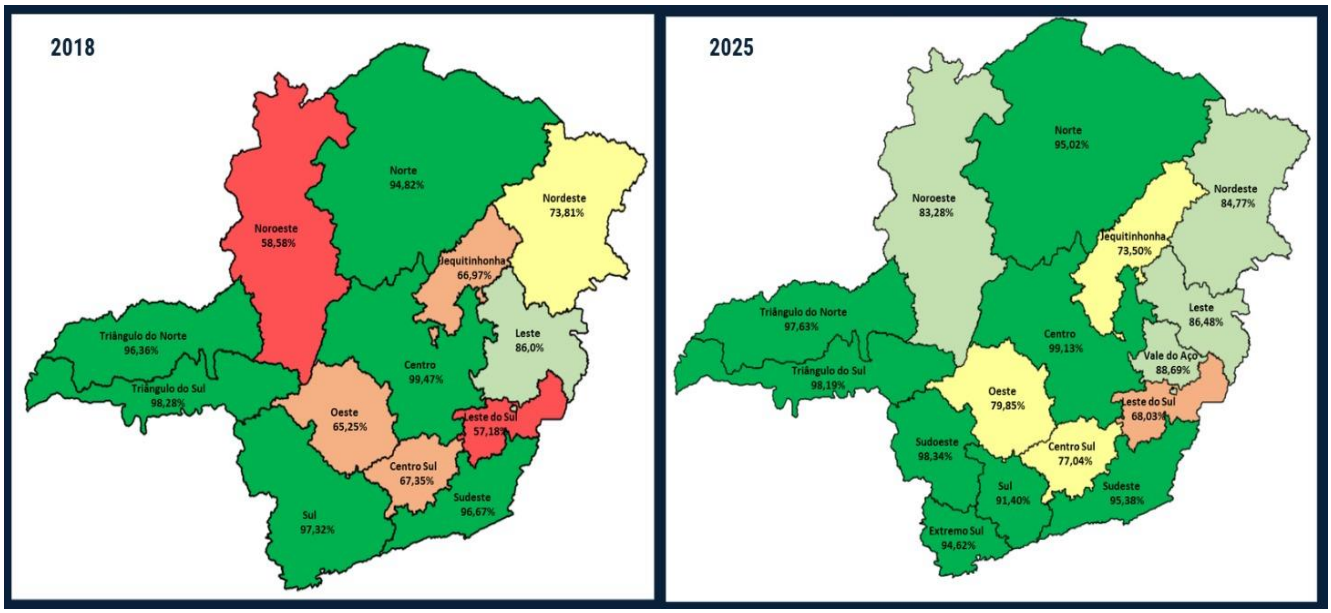
- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O Valora Minas é a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, instituída em 2020 em substituição ao PRO-HOSP, com o objetivo de qualificar a assistência hospitalar, ampliar o acesso aos serviços e promover maior equidade na distribuição dos recursos estaduais. A política estabelece um modelo de financiamento orientado por critérios técnicos e assistenciais, considerando o papel dos estabelecimentos nas Redes de Atenção à Saúde, as necessidades dos territórios, os serviços ofertados e os resultados alcançados. Suas diretrizes gerais estão estabelecidas na Resolução SES/MG nº 7.223/2020 e suas alterações.

  A alocação dos recursos observa parâmetros objetivos, definidos conforme as especificidades de cada módulo da política. No módulo **Valor em Saúde** (Resolução SES/MG nº 10.838/2025), destinado a hospitais de relevância microrregional, macrorregional e estadual, o financiamento considera a contribuição dos estabelecimentos para a resolubilidade dos territórios, os serviços e especialidades disponibilizados à população de referência, a produção assistencial e o cumprimento de metas e indicadores de

desempenho e qualidade. Já o módulo **Hospitais de Pequeno Porte – HPP** (Resolução SES/MG nº 10.787/2025) contempla estabelecimentos que, embora não atendam aos critérios de elegibilidade do Valor em Saúde, desempenham papel relevante na organização da assistência local. Nesse módulo, a definição dos beneficiários e dos incentivos financeiros considera critérios de elegibilidade, tipologia hospitalar, função assistencial e indicadores de monitoramento, conforme as regras estabelecidas na regulamentação específica.

Dessa forma, o Valora Minas busca direcionar os recursos estaduais de maneira regionalizada, considerando a capacidade de resposta dos estabelecimentos às necessidades assistenciais da população e vinculando o financiamento ao papel desempenhado pelos hospitais na rede e aos resultados dos serviços prestados.

- **Resultados alcançados:**
  - **Terapia intensiva:** entre 2018 e 2026, os leitos de UTI Adulto passaram de 1.984 para 2.668 (+34,5%) e os de UTI Pediátrica, de 196 para 285 (+45,4%) – 773 leitos incorporados, elevando a capacidade de 2.180 para 2.953 (+35,5%);
  - **Rede filantrópica:** o Valora Minas beneficia 350 hospitais, dos quais 257 beneficentes sem fins lucrativos, cujos incentivos estaduais passaram de R$ 523 milhões para R$ 1,2 bilhão;
  - **Resolubilidade (PDR):** entre 2018 e 2025, a resolubilidade hospitalar macrorregional da atenção terciária passou de 90,95% para 91,82%; as macrorregiões com resolubilidade ideal ou boa (≥ 80%) passaram de 53,8% para 75% e as com resolubilidade baixa ou crítica (< 70%) caíram de 38,5% para 6,3%, em contexto de crescimento de 76,5% nos procedimentos de alta complexidade (187.508 para 331.015) e de 11,9% nos de média (699.585 para 782.557).



Evolução da resolubilidade hospitalar por macrorregião (2018–2025).

Resolubilidade das macrorregiões de saúde na Atenção Terciária – 2014, 2018, 2022 e 2026*

Macrorregião de Saúde	Resolubilidade 2014	Resolubilidade 2018	Resolubilidade 2022	Resolubilidade 2026*
Centro	99,53	99,47	99,59	98,8
Centro Sul	60,07	67,35	71,47	77,3
Extremo Sul	-	-	-	94,3
Jequitinhonha	49,16	66,97	61,30	73,9
Leste	85,14	86,00	86,61	85,2
Leste do Sul	57,91	57,18	58,92	63,4
Nordeste	62,38	73,81	77,27	86,4
Noroeste	64,11	58,58	55,68	84,7
Norte	95,98	94,82	93,40	95,1
Oeste	51,13	65,25	75,90	79,5
Sudeste	97,05	96,67	96,99	95,8
Sudoeste	-	-	-	90,4
Sul [1]	96,45	97,32	97,79	92,3
Triângulo do Norte	96,04	96,36	97,82	97,5
Triângulo do Sul	97,64	98,28	98,10	97,4
Vale do Aço	-	-	88,89	89,3

Fonte: SES/SUBR-SIR-DARPS-CEAR - Tabwin/Datasus

* Para o ano de 2026, a apuração considera apenas o 1° quadrimestre.

[1] Até 2023, a Macro Sul apresentava configuração unificada. Para 2014, 2018 e 2022 os valores referem-se à Macro Sul unificada; para 2026, à Macro Sul após o ajuste do PDR-SUS/MG (desmembrada em Extremo Sul, Sudoeste e Sul).

Elencos AC/MCHE-1 + AC/MCHE-2, conforme PDR-SUS/MG e Carteira de Serviços Hospitalares do SUS/MG. "-" = dado não disponível (macrorregião inexistente no período).

LEGENDA

- Macrorregiões com resolubilidade ideal: ≥ 90,00%
- Macrorregiões com boa resolubilidade: ≥ 80,00% e < 90,00%
- Macrorregiões com resolubilidade regular: ≥ 70,00% e < 80,00%
- Macrorregiões com baixa resolubilidade: ≥ 60,00% e < 70,00%
- Macrorregiões com resolubilidade crítica: < 60,00%

- **Valor executado:** Em 2018, o PRO-HOSP dispunha de um orçamento anual de aproximadamente R$ 677 milhões, dos quais R$ 543,5 milhões eram destinados a 11 hospitais, enquanto os R$ 133 milhões restantes eram distribuídos entre outros 141 hospitais. Observa-se que um grupo restrito de hospitais concentrava a maior parcela dos recursos, evidenciando a necessidade de maior equidade na alocação do financiamento hospitalar estadual. Nesse contexto, a Política Valora Minas veio equacionar essa distorção, ao propor uma lógica de financiamento orientada pelas necessidades assistenciais, pela relevância dos hospitais para a organização das redes de atenção à saúde e pela valorização do papel de cada estabelecimento na prestação de serviços ao SUS/MG.
- Com a implementação do Valora Minas, os recursos destinados ao custeio da política de atenção hospitalar apresentaram crescimento expressivo, passando de R$ 1,7 bilhão em 2023 para R$ 2 bilhões anuais em 2024 e 2025, com previsão de alcançar R$ 2,1 bilhões em 2026 (valor programado). Em comparação com 2018, esse montante representa um incremento anual de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, equivalente a 3,1 vezes o valor registrado naquele ano.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do Valora Minas poderia comprometer a sustentabilidade financeira dos hospitais beneficiados e a manutenção de serviços essenciais, especialmente em regiões com menor capacidade instalada e maior dependência do cofinanciamento estadual, além de gerar instabilidade para os prestadores. Representaria também o enfraquecimento de um instrumento de organização da rede hospitalar, comprometendo a regionalização, a distribuição territorial dos serviços e a capacidade do Estado de induzir a ampliação do acesso e da resolubilidade. Eventual revisão ou substituição da política deverá ser precedida de avaliação dos resultados e dos impactos financeiros e assistenciais, com medidas de transição que assegurem a continuidade dos serviços.
- **Informações adicionais:** integram o Valora Minas a **Rede de Atenção ao Parto e Nascimento** (Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.222/2020), com 345 instituições (144 beneficiárias do Valora), 357 serviços de referência para o parto, 2.806 leitos obstétricos, capacidade para até 269.376 partos anuais, 583 leitos de UTIN, 270 de UCINCo e 110 de UCINCa; a **Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual** (Deliberações nº 3.939/2022 e 4.355/2023), com recursos a 112 hospitais para atendimento às vítimas e coleta de vestígios, em articulação com a Polícia Civil (Resolução nº 9.066/2023); a Rede de Saúde Mental, a Rede de portas de urgência e Emergência, a Rede de Saúde Bucal (beira leito hospitalar) e o **Projeto Otimiza SUS** (Resolução nº 7.925/2021), com a metodologia DRG em 149 instituições e o Programa Nacional de Gestão de Custos (APURASUS) em 213 instituições (146 hospitais e 67 UPAs).

Opera Mais, Minas Gerais

Plano de governo | Política avaliada

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O Opera Mais, Minas Gerais é o módulo de cirurgias eletivas da Política de Atenção Hospitalar do Estado – Valora Minas, voltado à ampliação do acesso da população aos procedimentos cirúrgicos eletivos e à redução das filas e do tempo de espera. A política

utiliza recursos próprios do Estado para incentivar o aumento da oferta, por meio da complementação dos valores da tabela SUS e da concessão de bonificações vinculadas ao cumprimento de metas e ao desempenho dos prestadores. Em 2025 o programa passou por uma revisão, buscando realizar um diagnóstico detalhado dos valores por procedimento, de modo a mitigar distorções na tabela SUS. As diretrizes e regras de financiamento estão estabelecidas na Resolução SES/MG nº 7.830/2021 e suas alterações, com regulamentação específica para o exercício de 2026 pela Resolução SES/MG nº 11.010/2026 e suas alterações.

- **Resultados alcançados:** Entre 2022 e 2025, a produção de cirurgias eletivas hospitalares passou de 220.947 para 347.975 procedimentos anuais, crescimento de 57,5%, com 274.481 procedimentos em 2023 e 322.349 em 2024, demonstrando crescimento contínuo. Em comparação com 2019, período anterior à pandemia e à implantação do Opera Mais, quando foram realizados 186.505 procedimentos, **o volume de 2025 representa aumento de 86,6%**. Quando somadas às cirurgias ambulatoriais, Minas Gerais alcançou mais de 1 milhão de cirurgias em 2025.
- **Valor executado:** Aproximadamente R$ 1,55 bilhão em recursos estaduais entre 2022 e 2025: R$ 129 milhões (2022), R$ 372 milhões (2023), R$ 541 milhões (2024) e R$ 511 milhões (2025). Para 2026, está previsto o montante de aproximadamente R$ 410,7 milhões. Origem dos recursos: Tesouro Estadual, operacionalizado por meio do Fundo Estadual de Saúde.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do Opera Mais poderia comprometer a capacidade de financiamento e realização de cirurgias eletivas hospitalares, com impactos sobre a oferta, o tempo de espera e o acúmulo de demandas. A interrupção dos incentivos, que complementam a tabela SUS e remuneram o desempenho, poderia dificultar a manutenção da capacidade cirúrgica nos estabelecimentos que dependem desses recursos para organizar equipes, adquirir insumos e manter a programação. Também poderia enfraquecer a capacidade do Estado de coordenar e regionalizar a oferta, uma vez que o modelo estabelece metas, monitoramento e incentivos vinculados à produção.

Descentralização da gestão hospitalar

Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** FHEMIG
- **Descrição da Política Pública:** Alinhada aos objetivos de longo prazo do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), a Fhemig tem expandido modelos de gestão hospitalar baseados em parcerias, reconhecidos como válidos pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 1.923/2015). Esses modelos oferecem maior autonomia, agilidade e flexibilidade, facilitam a incorporação de soluções e tecnologias e otimizam recursos. A política integra o objetivo estratégico do Mapa 2024–2027 “Expandir as parcerias como forma de qualificar e simplificar processos”. A Fhemig transfere a gestão operacional ou a execução de projetos aos parceiros, mantendo o planejamento, a regulação e a fiscalização. Os instrumentos utilizados são municipalização, contrato de gestão com Organização Social de Saúde (OSS), termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), parceria público-privada

(PPP) e cessão de uso de imóveis. A criação de um Serviço Social Autônomo (SSA) permanece em estágio preliminar de implantação.

- **Resultados alcançados:** Uma PPP assinada (Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio – HoPE); um contrato de gestão em execução (HRAD); um contrato em processo de assinatura (HRJP); quatro municipalizações (CEPAI, CMT, Casa de Saúde Padre Damião e Casa de Saúde Santa Fé); um termo de parceria em execução (CHB – Acreditação do Hospital Regional); e três termos de cessão ou permissão de uso de imóveis vigentes: Consórcio Circuito das Águas (Três Corações), Fundação Cristiano Varella (Ubá) e Santa Casa de Misericórdia (Belo Horizonte).
- **Valor executado:** Segue valor detalhado, por parceria (quando aplicável):
    - **PPP - Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (HoPE):** Parceria para construção, equipagem, manutenção e operação dos serviços de apoio não assistenciais ("bata cinza"). O novo complexo terá 532 leitos, 110 deles de UTI, e o novo Lacen-MG. Para tal, prevê um investimento de R$1,8 bilhão para construção e equipagem do complexo (CAPEX) e de R$4,5 bilhões em despesas operacionais ao longo dos 30 anos de contrato (OPEX), com data-base em mar/2025;
    - **OSS – Hospital Regional Antônio Dias (HRAD):** Contrato de Gestão nº 12/2024 com a Faepu, contemplando valor executado de R$212.765.576,56 em 28 meses, incluindo custeio mensal e investimentos, que nesse caso são executados diretamente pela OSS;
    - **OSS – Hospital Regional Dr. João Penido (HRJP):** Gerido pela Fundação Benjamin Guimarães (Hospital da Baleia). Ainda não houve execução orçamentária, mas apresenta valor estimado de R$ 420,4 milhões em 5 anos (R$ 76,5 milhões no 1º ano), com 90% fixos e 10% vinculados a indicadores de desempenho.
    - **Municipalização:** Transferência da gestão de unidades de atenção psicossocial e de cuidados prolongados aos municípios, serviços estes que, pela lógica do SUS, deveriam integrar a rede municipal. Até o momento, CEPAI e CMT foram transferidos à Prefeitura de Belo Horizonte, como CAPS AD e CAPS Infantojuvenil (transição concluída em dez/2024). Casa de Saúde Padre Damião transferida à Prefeitura de Ubá (transição até dez/2026). Casa de Saúde Santa Fé transferida à Prefeitura de Três Corações (termo assinado em 08/06/2026, transição até dez/2027). Tratativas iniciadas com a Prefeitura de Bambuí para a Casa de Saúde São Francisco de Assis. Trata-se de desoneração do Tesouro Estadual, não se aplicando assim o conceito de valor executado.
- **Origem dos recursos**: Tesouro Estadual, recursos SUS e Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho.
- **Prejuízo de descontinuidade**: Muito alto, considerando que os contratos em curso possuem obrigações e prazos jurídicos. Sua interrupção comprometeria a assistência nas unidades transferidas, os investimentos realizados e a capacidade da Fhemig de se concentrar na média e alta complexidade.

2.4. Rede de Urgência e Emergência

A Rede de Urgência e Emergência (RUE) de Minas Gerais constitui uma rede regionalizada e integrada de serviços destinada a garantir atendimento oportuno, qualificado e resolutivo às situações de urgência e emergência, articulando o SAMU, as UPA 24h, as portas hospitalares de urgência e emergência, os serviços de apoio diagnóstico, os leitos de retaguarda e demais componentes assistenciais.

Os pontos de atenção pré e pós hospitalar, como o Transporte de Urgência e Emergência, as UPAs e o SAD, foram políticas fundamentais. Entre 2023 e 2026* (parcial) foram pagos R$2,93 bilhões, dos quais R$2,9 bilhões são recursos de custeio e R$36 milhões de investimento. Dentre os recursos de custeio, R$ 727milhões são recursos federais e R$2,12 bi são recursos estaduais, dos quais R$20 milhões são emendas. A título de comparação, no caso das UPAs, a partir de 2023, o aporte estadual de custeio passou de R$5 milhões para R$19,3 milhões mensais.

Com relação às portas de Urgência e Emergência hospitalares, houve a revisão da grade de referência, juntamente com a estratégia de fortalecimento das Linhas de Resposta Rápida como o AVC, IAM e traumatortopedia. O custeio do Programa Estadual de Portas de Urgência e Emergência ocorre, por meio do programa Valora Minas. O programa é composto por unidades do módulo Valor em Saúde e do Módulo HPP.

2.4.1. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Programa Rede Resposta / Programa Estadual de Portas de Urgência e Emergência Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** Desde 2019, o Estado vem reformulando de forma contínua o financiamento das portas hospitalares da Rede de Urgência e Emergência (RUE), para ampliar o acesso, aumentar a resolutividade hospitalar e reduzir os vazios assistenciais regionais. Cada hospital passou a ter tipologia e função definidas conforme seu perfil assistencial, sua capacidade instalada e seu papel na rede regionalizada. Essa evolução se deu por atualizações sucessivas das diretrizes, como a Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.282/2023, e se consolidou com a Resolução SES/MG nº 10.446/2025, no âmbito do Valora Minas. A resolução revisa os critérios de classificação e financiamento e organiza as portas nos componentes Porta Aberta e Porta Referenciada, com diferentes níveis de complexidade. Com isso, o financiamento passa a se alinhar cada vez mais às necessidades de cada território.

- **Resultados alcançados:** A política consolidou uma rede estadual de urgência com 278 hospitais tipificados, com funções assistenciais definidas e fluxos organizados conforme as necessidades regionais. A rede inclui desde hospitais de pequeno porte, que funcionam como apoio e primeiro atendimento nos municípios menores, até hospitais de referência para casos de maior complexidade. Também estruturou a assistência nas linhas prioritárias de AVC, infarto agudo do miocárdio e trauma-ortopedia, condições em que o tempo de resposta é decisivo para evitar mortes e sequelas. Com isso, o financiamento hospitalar de urgência deixou de ser apenas um repasse e passou a funcionar como instrumento de organização da rede.

  Considerando a implementação do Valora 2.0 em 2023, observa-se um aumento da produção hospitalar de urgência nos hospitais beneficiados (2023/2025) de 8,6 %. Se compararmos por exemplo com os dois anos anteriores (antes do incremento financeiro para componente de produção de urgência - 2021/2023), o crescimento foi de 5%.

  Considerando todo o crescimento da gestão atual a partir de 2019 (dados entre 2018 - 2025), o crescimento da produção de urgência foi de 20,8% (390.304 procedimentos). Vale destacar ainda que, considerando a produção total de MG, ao longo do período, a produção dos hospitais que integram o Valora passou a representar uma parcela cada vez maior da produção estadual de urgência e emergência.
- **Valor executado:** O Programa Estadual de Portas de Urgência e Emergência contempla **158 hospitais** do Módulo Valor em Saúde, com um montante de **R$ 588.154.650,22**: R$ 500.919.000,00 no custeio da RUE e R$ 87.235.650,22 nos procedimentos estratégicos da RUE. No Módulo Hospitais de Pequeno Porte (HPP), outros **120 hospitais** têm a tipologia de Serviço de Apoio à Rede de Urgência e Emergência, com um montante de **R$ 77.265.869,87 anuais**. No total, são **278 hospitais** e **R$ 665.420.520,09** destinados à Rede de Urgência e Emergência.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A interrupção comprometeria a sustentabilidade financeira de 278 hospitais que funcionam como porta de entrada da urgência no estado. Muitos deles são a única referência em municípios menores e em regiões com vazios assistenciais. A perda desse financiamento poderia reduzir o atendimento ou fechar portas de urgência. Isso aumentaria o tempo e a distância de deslocamento dos pacientes e sobrecarregaria os hospitais de referência. Nas linhas de AVC, infarto e trauma, o atraso no atendimento se traduz diretamente em mais mortes e sequelas.

Transporte de Urgência e Emergência – SAMU 192, transporte inter-hospitalar e Serviço Aeromédico (SAS-MG)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG, Consórcios Intermunicipais de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e Polícia Militar (COMAVE)
- **Descrição da Política Pública:** O transporte de urgência e emergência compreende diretrizes, planejamento, coordenação e supervisão de ações da Rede de Atenção às Urgências do SUS-MG, com destaque para o SAMU

192, o transporte inter-hospitalar contratado e o serviço aeromédico estadual.

- O SAMU 192 mantém escuta permanente 24 horas pelo número 192, regulação médica com foco em assistência pré-hospitalar móvel e transferência regulada de pacientes graves; cobre 791 municípios no formato regional por consórcio (11 consórcios), 60 no formato regional por municípios (3 municípios gerenciadores) e 2 no formato municipal. A regulamentação de seu financiamento estadual envolve: Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.476, de 21 de julho de 2021; RESOLUÇÃO SES/MG nº 7.611, de 21 de julho de 2021; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.782, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.937, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.344, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.275, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG nº 5.503 de 28 de novembro de 2025; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 5.013, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024; RESOLUÇÃO SES/MG nº 10.752, de 28 de novembro de 2025.
- O Serviço Aéreo de Saúde (SAS-MG) executa, em parceria com o CBMMG, atendimentos aéreos pré-hospitalares, busca e salvamento regulados pela Saúde, transporte de órgãos e tecidos e apoio à Força Estadual de Saúde, complementado por parceria com a PMMG (COMAVE). As aeronaves usadas nesse transporte são adquiridas pela SES/MG e operadas pelo CBMMG, mediante celebração de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO). A regulamentação de seu financiamento estadual envolve: Resolução SES/MG nº 10834; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.837, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.832, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
- De forma complementar, há o transporte inter-hospitalar de alto risco em Suporte Avançado, para distâncias superiores a 200 km e para fora da macrorregião, contratado com empresa privada (ambulância Tipo D – UTI móvel).

- **Resultados alcançados:**
  - **Cobertura universal do SAMU:** de 564 municípios no SAMU regional e 15 no municipal (10,5 milhões de mineiros) em 2018, para 851 no regional e 2 no municipal (mais de 21 milhões) em 2026;
  - **Trombólise pré-hospitalar:** R$ 622 mil para aquisição de Tenecteplase pelos gestores do SAMU (Resolução nº 10.786/2025), antecedendo o financiamento federal;
  - **Ampliação do financiamento estadual**, com nova metodologia de custeio, e **eletrocardiógrafos** para as Unidades de Suporte Básico (Resolução nº 11.453/2026), objetivando uso em serviço de telecardiologia junto ao Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, com contratação em andamento (contrato nº 9517892/2026).
  - **Contratação de serviço de telecardiologia** em parceria com a UFMG, para oferecer telediagnóstico de eletrocardiogramas e orientação especializada por cardiologistas, 24 horas por dia, às equipes das Unidades de Suporte Básico do SAMU 192, com

emissão de laudos em até 10 minutos, visando agilizar o diagnóstico e o manejo de pacientes com suspeita de Síndrome Coronariana Aguda (SCA), especialmente infarto agudo do miocárdio, e qualificar o atendimento pré-hospitalar em Minas Gerais.

- **Transporte inter-hospitalar:** 135 transportes entre janeiro e agosto de 2026 (R$ 1.672.242,52);
- **SAS-MG:** diretrizes pactuadas (Resolução nº 10.837/2025) e bases ampliadas de 4 em 2022 para 6 em 2026 (Juiz de Fora e Governador Valadares). A frota foi ampliada de 4 aeronaves em 2022 para 8 em 2026, além de 2 aquisições com valor de seguro para substituir unidades acidentadas em 2021 e 2024.

- **Valor executado:**

De acordo com a normativa federal, **Portaria nº 1010/GM/MS, de 21 de maio de 2012**, o financiamento do SAMU deveria se dar na seguinte proporção:

- União: 50% (cinquenta por cento) da despesa;
- Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa;
- Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa.

No entanto, em Minas Gerais, considerando os recursos para custeio do SAMU 192 terrestre, a distribuição se dá da seguinte forma ao longo dos anos.

Ano	Valor do custeio estadual	Participação estadual	Valor do custeio federal	Participação federal
2018	R$ 71.232.355,05	53,12%	R$ 62.858.437,20	46,88%
2019	R$ 133.626.022,74	65,73%	R$ 69.658.740,90	34,27%
2020	R$ 148.128.085,81	62,81%	R$ 87.724.676,80	37,19%
2021	R$ 164.317.376,75	64,40%	R$ 90.848.132,20	35,60%
2022	R$ 196.596.813,36	67,99%	R$ 92.571.663,00	32,01%
2023	R$ 180.343.988,35	46,19%	R$ 210.135.375,22	53,81%
2024	R$ 240.722.415,84	54,85%	R$ 198.142.631,69	45,15%
2025	R$ 271.417.538,97	57,01%	R$ 204.677.234,62	42,99%
2026 (parcial 09/2026)	R$ 276.025.851,33	71,01%	R$ 112.692.573,20	28,99%
Total Geral	R$ 1.682.410.448,20	59,84%	R$ 1.129.309.464,83	40,16%

Além disso, houve financiamento de R$5.205.060,00 para aquisição de eletrocardiógrafos em 2026, além de previsão remanescente de gasto de R$622.000,00 no mesmo ano para aquisição do trombolítico Tenecteplase para tratamento de IAM no atendimento pré-hospitalar.

Finalmente, destacamos que entre 2021 e 2026 houve um investimento de R$86 milhões na ampliação e qualificação do SAMU Regional.

Com relação ao custeio do transporte aéreo, este é 100% custeado com recursos estaduais do Fundo Estadual de Saúde e repassado ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar.

Recurso 100% estadual do FES para financiamento do transporte aéreo		
ANO	**BOA (CBMMG)**	**COMAVE (PMMG)**
2023	R$17 milhões	N/A
2024	R$19 milhões	R$470 mil
2025	R$17 milhões	R$900 mil
2026*	R$20 milhões	R$497 mil
TOTAL	R$74 milhões	R$1,9 milhão

Ademais, houve empenho de R$264 milhões que resultou na aquisição de 4 aeronaves adicionais para o Serviço Aéreo.

- **Prejuízo de descontinuidade:** O Estado financia a maior parte do custeio do SAMU 192. Reduzir ou interromper os repasses comprometeria a operação de bases e ameaçaria a cobertura universal recentemente conquistada, com impactos sobre tempo-resposta, cobertura e continuidade do cuidado – em emergências, atrasos podem resultar em agravamento, complicações permanentes ou óbito. A interrupção também comprometeria as transferências reguladas de pacientes graves em suporte avançado. No transporte inter-hospitalar contratado, afetaria pacientes de alto risco a mais de 200 km; no Serviço Aeromédico, o atendimento oportuno, com possível aumento de óbitos e redução das repatriações.

Outras políticas públicas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Programa UPA 24h	O Programa UPA 24h integra a estratégia estadual de fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência de Minas Gerais e tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de urgência e emergência. As UPAs são estabelecimentos de complexidade intermediária que funcionam de forma ininterrupta e articulada com a Atenção Primária, o SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, atuando no atendimento e estabilização de quadros agudos, na	Em 2026, a estratégia foi ampliada com a criação de um mecanismo específico de financiamento para estabelecimentos que já integram a Rede de Urgência e Emergência e estão em processo de transição para habilitação como UPA 24h, garantindo suporte financeiro durante esse período. A política fortaleceu o papel estadual no financiamento da Rede de Urgência e Emergência, estabelecendo uma fonte regular de custeio para as UPAs habilitadas. O modelo contempla tanto UPAs

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
		realização de diagnóstico inicial e no encaminhamento dos pacientes que necessitam de continuidade do cuidado na rede hospitalar. Cofinanciamento estadual das UPAs habilitadas pelo Ministério da Saúde, com contrapartida de 100% do incentivo mensal federal de referência a partir de 2025 (em 2018, o Estado complementava com 25%; com a Resolução nº 8.348/2022, o aporte passou, em 2023, de R$ 5 milhões para R$ 19,378 milhões mensais). Em 2026, foi criado mecanismo para estabelecimentos em transição para habilitação como UPA 24h.	novas quanto ampliadas, com valores definidos conforme a opção da unidade e sua situação de habilitação e qualificação. **72 UPAs cofinanciadas, com até R$ 500 mil mensais (UPAs novas) e R$ 300 mil mensais (ampliadas).** **Ademais, com os investimentos estaduais será possível viabilizar a implantação de novas UPAs, que se encontram em processo de tramitação para financiamento de obras ou equipamentos:** Matipó; Unaí; São Gotardo; Mato Verde; Cambuí; Pompéu; Janaúba; Alpinópolis; Jaíba; Ubá; Piumhi; Vespasiano; Porteirinha; Três Corações; Sete Lagoas; Bicas; Viçosa, Teófilo Otoni e Pedro Leopoldo Ainda, foi celebrado o convênio para obras relativas à UPA de Cássia. Também já foram pagos os investimentos relativos à abertura de novas UPAs em Diamantina (equipamentos); Barbacena (equipamentos), Coromandel (obra), Paracatu (obra), Montes Claros (equipamento).
SES/MG	Serviço de Atenção Domiciliar – Programa Melhor em Casa	Atendimento domiciliar pelo SUS a pessoas que precisam de cuidados contínuos ou intensivos e têm dificuldade de se deslocar, inclusive após alta hospitalar. Minas Gerais complementa o financiamento federal com incentivo estadual (Resolução SES/MG nº 8.390/2022, atualizada pela nº 10.589/2025). A Resolução SES/MG nº 10.589/2025 prevê R$ 33,19 milhões anuais para o incentivo estadual, repassados em parcelas quadrimestrais condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira. O recurso é	Institucionalização do SAD como estratégia prioritária de desospitalização, articulando hospital, atenção primária, UPA e atenção domiciliar; Ampliação e manutenção da oferta de EMAD/EMAP em diferentes regiões do estado; Maior sustentabilidade financeira dos serviços municipais, com a combinação dos recursos federal e estadual; Fortalecimento da desospitalização, permitindo que usuários que não necessitam permanecer internados continuem o cuidado em casa;

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
		correspondente a 30% do incentivo federal mensal destinado às EMAD tipos I e II. Os recursos complementam o financiamento federal e custeiam profissionais, materiais, equipamentos, veículos e estrutura operacional das visitas domiciliares.	Continuidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, especialmente para pacientes com maior complexidade clínica; Redução potencial da permanência hospitalar e maior disponibilidade de leitos hospitalares para casos agudos.
SES/MG	Unidades de Cuidado Prolongado	Atendem pacientes que superaram a fase aguda, mas precisam de cuidados hospitalares e reabilitação por até 90 dias, como etapa intermediária entre o hospital de agudos e a Atenção Básica ou domiciliar. O cofinanciamento integra o módulo Unidades de Internação Estratégicas do Valora Minas (Deliberação CIB nº 5.001 e Resolução nº 9.889/2024, atualizadas até a Resolução nº 10.445/2025).	Implantação de uma nova modalidade de financiamento estadual para UCP/HCP; Incorporação das UCP/HCP à Política de Atenção Hospitalar – Valora Minas; Ampliação da sustentabilidade financeira dos serviços habilitados pelo Ministério da Saúde; fortalecimento da linha de cuidado da desospitalização; Criação de maior capacidade de transição do paciente do cuidado hospitalar agudo para o cuidado intermediário/prolongado; incentivo à utilização adequada dos leitos hospitalares de maior complexidade; Fortalecimento da integração entre hospital, NIR, UCP/HCP, SAD e demais pontos da RAS

2.5. Regulação do Acesso à Assistência

A regulação tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS/MG, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais. Esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolo, classificação de risco e demais critérios de priorização. O processo de trabalho contempla: a organização dos fluxos assistenciais; o controle e monitoramento físico e financeiro, aferindo a conformidade entre a oferta e a utilização dos serviços assistenciais; o gerenciamento dos processos regulatórios e a alocação das demandas assistenciais.

No último quadriênio o estado buscou ter um papel mais ativo no apoio à regulação eletiva, ainda que a responsabilidade por ela seja do município. Assim, fortaleceu-se a

disponibilização de sistemas de monitoramento de filas, do apoio técnico e de processos recorrentes de revisão e qualificação dos dados.

Ainda assim, o foco e competência principais do estado é a regulação de urgência e emergência. Nesse sentido, conforme apresentaremos, houve uma qualificação e uma modernização completa no processo de trabalho e no sistema de regulação que partiu de um diagnóstico profundo dos problemas de acesso no estado. Entre 2023 e 2026, houve um investimento de R$7,5 milhões em recursos estaduais para a modernização do processo, além de R$10,7 milhões no custeio do complexo regulador.

2.5.1. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Central de Operações para Regulação Estadual (CORE-MG) Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:**

  • CORE-MG foi criada para enfrentar limitações do modelo anterior de regulação estadual, então estruturado em 13 centrais regionais e apoiado pelo SUSfácilMG, sistema desenvolvido há cerca de 20 anos. A fragmentação da operação e as limitações do sistema dificultavam a padronização dos processos, a rastreabilidade da trajetória dos pacientes e o acompanhamento atualizado da disponibilidade de leitos.

  Para enfrentar esses problemas, o projeto Regulação 4.0 foi estruturado em dois eixos complementares: a unificação da operação estadual de regulação de urgência na CORE-MG, sediada em Belo Horizonte, com garantia de plantão médico 24h em modelo presencial e com direcionamento do esforço regional para o monitoramento dos leitos disponíveis, e o desenvolvimento da plataforma CORE Saúde MG, em substituição ao SUSfácilMG.

  A centralização da operação ocorreu em 5 de maio de 2026, e o novo sistema entrou em produção em 19 de maio de 2026. A organização e o financiamento da CORE-MG estão disciplinados pelas Resoluções SES/MG nº 10.832/2025, nº 10.834/2025, nº 11.007/2026 e nº 11.008/2026.

  A plataforma ampliou a rastreabilidade e a segurança do processo regulatório e foi concebida para evolução contínua, permitindo o aprimoramento dos fluxos de forma ágil, a integração com outros sistemas e a incorporação de novas funcionalidades. Na reorganização das centrais, foi estruturada uma equipe multiprofissional composta por médicos reguladores, que atuam como autoridades sanitárias, médicos auxiliares de regulação, profissionais de enfermagem, coordenadores estaduais e macrorregionais, equipes técnicas das Coordenações de Acesso a Serviços de Saúde, núcleo de judicialização e equipe da Superintendência de Regulação do Acesso.

Essa organização combina a tomada de decisão técnico-assistencial com o acompanhamento dos processos regulatórios, o monitoramento das filas de urgência e a articulação permanente com os estabelecimentos de saúde e os territórios. Com isso, fortalece a aplicação uniforme dos protocolos e critérios de priorização, a rastreabilidade das decisões regulatórias e a equidade no acesso aos serviços.

De forma excepcional e complementar, a rede credenciada pode ser acionada quando houver necessidade assistencial comprovada e a rede SUS não dispuser de recurso compatível em tempo clinicamente oportuno. O acionamento considera a condição clínica do paciente, o risco associado à espera, a disponibilidade efetiva da rede pública, a segurança do transporte e a janela clínica, podendo ocorrer antes do esgotamento de todas as tentativas de busca quando a demora representar risco assistencial. O Edital de Credenciamento nº 01/2025 estabeleceu a tabela de valores dos serviços e as regras para sua oferta ao SUS.

- **Resultados alcançados:**
  - **Tempo até a internação:** +18,6% dos pacientes internados em até 1h. 88,2% das solicitações alcançaram internação em até 24 horas (+0,3% em relação ao mesmo período no ano passado);
  - **Números até 07/10/2026:** 45.209 usuários, 35.873 leitos ofertados, 553.326 solicitações e 445.608 laudos finalizados;
  - **Resolubilidade macrorregional:** CORE e SUSfácilMG em procedimentos apenas de alta complexidade, no período 19/05/2026 a 13/10/2026 (CORE) e 19/05/2025 a 13/10/2025 (SUSfácilMG), considerando data de solicitação, e excluídas as solicitações canceladas e registros das centrais municipais de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia.

	CORE						SUSFácilMG					
Macro	Solicitações	Int. Em até 24h	Acesso em 24h	Internações	Int. Na própria macro	Resolubilidade	Soli.	Int. em até 24h	Acesso em 24h	Int.	Int.na macro	Resolubilidade
CENTRO	5.292	4.540	85,8%	5.296	5.260	99,3%	5.601	4.161	74,3%	5.601	5.582	99,7%
CENTRO SUL	1.203	925	76,9%	1.203	1.193	99,2%	1.094	859	78,5%	1.094	1.031	94,2%
EXTREMO SUL	2.516	2.266	90,1%	2.517	2.456	97,6%	2.393	2.200	91,9%	2.393	2.354	98,4%
JEQUITINHONHA	1.067	923	86,5%	1.067	1.058	99,2%	1.195	1.023	85,6%	1.195	1.148	96,1%
LESTE	825	648	78,5%	825	821	99,5%	900	732	81,3%	900	856	95,1%
LESTE DO SUL	1.405	1.287	91,6%	1.405	1.365	97,2%	1.201	1.085	90,3%	1.201	1.115	92,8%
NORDESTE	1.652	1.368	82,8%	1.653	1.589	96,1%	1.502	1.178	78,4%	1.502	1.413	94,1%
NOROESTE	2.311	1.820	78,8%	2.312	2.229	96,4%	1.926	1.620	84,1%	1.926	1.855	96,3%
NORTE	4.913	4.069	82,8%	4.915	4.915	100,0%	4.749	3.928	82,7%	4.749	4.713	99,2%
OESTE	2.906	2.489	85,7%	2.907	2.888	99,3%	2.962	2.493	84,2%	2.962	2.821	95,2%
SUDESTE	1.222	1.120	91,7%	1.223	1.219	99,7%	1.082	953	88,1%	1.082	1.070	98,9%

	CORE						SUSFácilMG					
Macro	Solicitações	Int. Em até 24h	Acesso em 24h	Internações	Int. Na própria macro	Resolubilidade	Soli.	Int. em até 24h	Acesso em 24h	Int.	Int.na macro	Resolubilidade
SUDOESTE	3.791	3.331	87,9%	3.791	3.670	96,8%	3.111	2.788	89,6%	3.111	2.980	95,8%
SUL	1.799	1.347	74,9%	1.799	1.690	93,9%	2.014	1.574	78,2%	2.014	1.925	95,6%
TRIÂNGULO DO NORTE	917	605	66,0%	917	892	97,3%	929	622	67,0%	929	919	98,9%
TRIÂNGULO DO SUL	333	265	79,6%	333	309	92,8%	317	248	78,2%	317	304	95,9%
VALE DO AÇO	1.610	1.330	82,6%	1.610	1.590	98,8%	1.342	1.151	85,8%	1.342	1.309	97,5%
MINAS GERAIS	**33.762**	**28.333**	**83,9%**	**33.773**	**33.144**	**98,1%**	**32.318**	**26.615**	**82,4%**	**32.318**	**31.395**	**97,1%**

- **Capacitação:** 47 processos com 21.590 participantes;
- **Rede credenciada:** 45 prestadores contratualizados e 6 em contratualização; 479 contas pagas no prazo de 120 dias.

Comparativo SUSFácilMG × CORE Saúde MG (principais temas)

Tema	SUSFácilMG (modelo anterior)	CORE Saúde MG / Regulação 4.0
Arquitetura do sistema	Sistema legado desenvolvido há cerca de 20 anos, em modelo antigo.	Plataforma moderna, em modelo de evolução contínua.
Integração nacional	Sem integração estruturada com bases nacionais.	Integração com CadSUS, CNES, CFM, SIGTAP e RNDS.
Mapa de leitos	Atualização descentralizada, sem integração e sem rotina.	Monitoramento contínuo e compartilhado entre estado, regionais e municípios.
Rastreabilidade dos pacientes	Acompanhamento parcial, com pacientes sem CPF/CNS e baixa auditabilidade.	Rastreamento eletrônico contínuo da trajetória regulatória, com identificação de todos os pacientes.
Classificação de risco	Predominantemente manual e subjetiva.	Escore automatizado com apoio à decisão regulatória, baseado em protocolos estaduais.
Gestão de filas	Filas fragmentadas por macrorregiões e de baixa confiabilidade.	Fila integrada estadual, com filtros por território, perfil, prioridade e especialidade.
Autenticação e segurança	Controle local, com baixo nível de segurança.	Gov.br com dois fatores, perfis específicos e alinhamento à LGPD.
Hospedagem e estabilidade	Infraestrutura PRODEMGE com menor flexibilidade de expansão.	Nuvem Microsoft Azure com autoescalabilidade, alta disponibilidade e monitoramento externo.

- **Valor executado:** Cerca de R$ 18 milhões até setembro de 2026 para organização e operação da CORE-MG e do sistema CORE Saúde MG (consórcio público, convênio de PD&I, obras e materiais).

  Quanto à aquisição de leitos, de modo excepcional e complementar, que decorrem de necessidade assistencial, podendo haver ou não atendimento a ordem judicial, os valores aplicados se expressam no quadro abaixo.

Ano	Ordem judicial	Necessidade Clínica	Valor anual
2025	R$ 31.505.229,42	R$ 38.971.174,64	R$ 70.476.404,06
2026*	R$ 14.025.050,07	R$ 25.409.324,48	R$ 39.434.374,55
Total	**R$ 45.530.279,49**	**R$ 64.380.499,12**	

*Execução parcial.

- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade da CORE Saúde MG representa risco significativo para a própria operação cotidiana da regulação assistencial: a indisponibilidade do sistema pode comprometer a recepção, análise, priorização e encaminhamento das solicitações, gerar passivos regulatórios e perda de informações clínicas e de leitos, com impacto sobre o tempo de resposta, a segurança e a equidade do acesso. **O retorno ao SUSFácilMG é operacionalmente impraticável e assistencialmente arriscado: diagnósticos do LAIS/UFRN e da PRODEMGE apontam infraestrutura obsoleta, sem suporte e com risco de indisponibilidade por tempo indeterminado – só em maio de 2026 houve seis chamados formais de indisponibilidade. A reversão implicaria ruptura de fluxos já reorganizados e aumento do risco assistencial.**

  A rede credenciada e o mecanismo de compra de leitos, utilizados de forma excepcional e complementar à rede SUS, constituem ponto de atenção para a sustentabilidade da eficácia da regulação estadual, considerando a variabilidade da demanda, o perfil clínico dos pacientes, o tempo de permanência e a disponibilidade da rede pública. A manutenção da rede credenciada e o acompanhamento dos valores comprometidos, faturados, revisados e pagos são essenciais ao funcionamento do sistema e acesso dos usuários.

Regulação do Acesso Eletivo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A atuação estadual ocorre de forma complementar às responsabilidades municipais. Atualmente, a gestão das filas de acesso eletivo é descentralizada e compete às Secretarias Municipais de Saúde, responsáveis pela organização das demandas de seus munícipes, priorização dos casos e acompanhamento do acesso, inclusive quando o atendimento ocorre fora do município de residência. A SES-MG, por sua vez, exerce papel de coordenação estadual da política, estabelecendo diretrizes e protocolos, apoiando tecnicamente os municípios e Unidades Regionais de Saúde, fortalecendo a governança regional e aprimorando os instrumentos de informação e regulação. Nesse arranjo, a integração e consolidação das informações não se confundem com a centralização da gestão das filas. Entre as principais frentes de atuação estão a elaboração, revisão e qualificação de protocolos de acesso; critérios de encaminhamento e fluxos assistenciais ambulatoriais e hospitalares; o apoio técnico aos municípios e Unidades Regionais de Saúde; a participação nas discussões e pactuações da Programação Pactuada e Integrada (PPI); a organização e qualificação de fluxos relacionados a

agendas específicas, como Doenças Raras e Medicina Fetal; e o desenvolvimento de instrumentos de governança regional, como os Comitês de Regulação do Acesso Eletivo, além de também participar da modernização dos processos regulatórios, com destaque para a implantação gradual dos módulos eletivos da CORE Saúde MG. A regulamentação de seu financiamento estadual envolve: RESOLUÇÃO SES/MG nº 10.833, de 15 de dezembro de 2025; RESOLUÇÃO SES/MG nº 10.836, de 15 de dezembro de 2025.

- **Resultados Alcançados**
  - Estruturação dos Comitês de Regulação do Acesso Eletivo pelas Unidades Regionais de Saúde. Constituição de 89 comitês microrregionais e 16 comitês macrorregionais, como espaços de articulação territorial, discussão de fluxos assistenciais e qualificação da governança, conforme Resolução SES/MG nº 10.836, de 15 de dezembro de 2025.
  - Consulta pública da proposta de Protocolo para a Regulação do Acesso Eletivo. A proposta é ofertar referências técnicas comuns aos processos regulatórios conduzidos pelos municípios, aumentando a padronização e a segurança das decisões. Após o recebimento das contribuições, o documento está em fase de análise e revisão para posterior publicação.
  - Monitoramento do acesso ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para crianças identificadas ainda no período gestacional com condições de saúde que demandem intervenções intrauterinas, especialmente no âmbito das cirurgias fetais. Também está prevista a atuação regulatória sobre as cardiopatias, com o objetivo de regular as gestantes para realização do parto em unidades habilitadas e com capacidade de realizar as intervenções necessárias de forma imediata, reduzindo riscos decorrentes do deslocamento ou da ausência de estrutura assistencial adequada no momento do nascimento.
  - Qualificação e atualização das filas do módulo eletivo. Identificação e tratamento de solicitações que já não representam uma necessidade assistencial vigente, como procedimentos já realizados, demandas canceladas, duplicidades, usuários que não necessitam mais do atendimento ou registros desatualizados. Foram realizadas 4 estratégias de atualização de filas, conforme descrito na tabela abaixo. Na última estratégia realizada, em outubro de 2025, houve assinatura de termo de atualização de filas pelos municípios como instrumento de compromisso municipal com a fila atualizada, alcançando 843 termos firmados. Nessa estratégia, tem-se um comparativo pré e pós-estratégia de atualização de filas eletivas.

Ano da estratégia	Ano da fila de referência	Quantidade de inconsistências	Quantidade de municípios executores	Quantidade de municípios de origem	Base de dados	Período de produção
2023	2022	25.458	69	782	SIH	2018 a 2022
2024	2022/2023	13.501	171	694	SIH	2016 a 2023
2025/ Abril	2023	23.044	210	732	SIA e SIH	2016 a 2023

Ano da estratégia	Ano da fila de referência	Quantidade de inconsistências	Quantidade de municípios executores	Quantidade de municípios de origem	Base de dados	Período de produção
2025/ Outubro	2024	57.015	260	799	SIA e SIH	2016 a 2024

- **Prejuízo em Caso de Descontinuidade:** A descontinuidade da política de Regulação do Acesso Eletivo pode comprometer a capacidade do estado de exercer sua função de coordenação, apoio técnico e indução da organização regional do acesso, produzindo impactos sobre protocolos, fluxos, pactuações, governança regional e articulação com os municípios. No curto prazo, a interrupção de agendas em andamento pode gerar perda de conhecimento institucional, descontinuidade dos processos de revisão e implantação de protocolos, enfraquecimento dos Comitês de Regulação do Acesso Eletivo e redução da capacidade de acompanhamento dos fluxos assistenciais. Considerando que a gestão das filas permanece descentralizada nos municípios, a perda de continuidade da coordenação estadual também pode ampliar a heterogeneidade entre os territórios e dificultar a construção de referências comuns para priorização, organização dos fluxos e acompanhamento do acesso.

2.6. Transporte Eletivo (Transporta SUS, Veículos de Acesso Eletivo e Tratamento Fora do Domicílio)

As políticas de transporte eletivo contemplam a formulação, implementação, cofinanciamento e monitoramento de ações relacionadas ao transporte sanitário eletivo no SUS em Minas Gerais, apoiando os municípios na estruturação regional desse serviço, compreendendo o Transporta SUS-MG, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e financiamento de veículos de transporte eletivo.

Nesse sentido, entre 2023 e 2025, foram aplicados R$1,2 bilhão nos sistemas de transporte, dos quais R$1,1 bilhão foi recurso de investimento e R$125 milhões em recursos de custeio. Dentre os recursos de investimento, R$ 340 milhões foram destinados para o TransportaSUS e R$770 milhões destinados à aquisição de veículos para acesso à assistência, incluindo os mais de R$400 milhões destinados à expansão do TFD. Desses, R$156 milhões se caracterizavam como recursos de emendas parlamentares.

2.6.1. Entregas prioritárias

- **Nome da Entrega:** Expansão do Transporte Fora do Domicílio (TFD)
- **Nome do órgão:** SES/MG
- **Descrição da política:** O Transporte Fora do Domicílio (TFD), por sua vez, compreende um conjunto mais amplo de medidas destinadas a viabilizar o acesso de usuários a tratamentos realizados fora de seu município de residência. Atualmente, a execução do TFD encontra-se predominantemente sob responsabilidade municipal, enquanto a atuação

estadual vem se concentrando especialmente no apoio ao componente transporte por meio das políticas de transporte sanitário eletivo.

- Assim, entre 2023 e 2026, a maior parte do apoio estadual ao TFD se deu através do financiamento de veículos de transporte eletivo envolvendo repasses financeiros para organização da frota municipal destinada ao transporte de pacientes, de modo complementar à iniciativa estadual, Transporta SUS-MG.

  Para além da política atualmente em vigor, propõe-se um novo Manual de TFD, apreciado pelo Conselho Estadual de Saúde, que manifestou interesse na ampliação da participação financeira do Estado para além do transporte, contemplando também alimentação e pernoite. Embora não haja previsão orçamentária específica para essa ampliação em 2027, a entrada em vigor da Lei Federal nº 15.390/2026, em abril de 2027, poderá trazer novos parâmetros para o financiamento do TFD. A partir desse novo cenário, a discussão deverá ser retomada, inclusive para reavaliar o papel do Estado no financiamento dos diferentes componentes do TFD.
- **Quantitativo financiado:** Entre 2023 e 2025 foram financiados 1.313 veículos.

Quantitativo de veículos	2023	2024	2025
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão	87	45	113
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta	140	23	32
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4	76	22	68
Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante)	160	132	415
Total	463	222	628

- **Valor executado:** De 2023 a 2026, foram investidos mais de 400 milhões de reais no financiamento de veículos para municípios, conforme distribuição abaixo.

Tipos de Aplicação	2023	2024	2025	2026
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão	R$ 28.171.644,00	R$ 14.981.270,00	R$ 36.590.756,00	R$ 9.111.800,00
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta	R$ 33.784.240,00	R$ 6.172.234,00	R$ 8.587.456,00	R$ 3.543.800,00
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4	R$ 26.183.140,00	R$ 7.576.285,00	R$ 23.427.020,00	R$ 3.555.000,00
Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante)	R$ 48.768.000,00	R$ 41.105.800,00	R$ 126.492.000,00	R$ 14.271.751,00
Total Geral	R$ 136.907.024,00	R$ 69.835.589,00	R$ 195.097.232,00	R$ 30.482.351,00

- **Status**: Pagamento concluído, aquisição pelos municípios em andamento.

2.6.2. Políticas Prioritárias

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Nome da Política: Transporta SUS-MG** Plano de governo Política avaliada
- **Descrição da Política Pública:** O Transporta SUS tem por finalidade qualificar e ampliar o Transporte Eletivo em Saúde, viabilizando acesso seguro e equânime a pontos de atenção da rede assistencial do estado em tempo e local oportuno para procedimentos eletivos, no próprio município de residência ou em outro município, nas regiões de saúde de referência, conforme pactuado. A política atua em duas frentes principais: fortalecimento da capacidade municipal, por meio do apoio estadual no cofinanciamento dos serviços em seus territórios; e expansão dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo, que são formas de estabelecer relações de cooperação regionalizada para realização de transporte eletivo em saúde intermunicipal, de forma a complementar o serviço próprio do município.

  A organização regional permite o compartilhamento de estrutura e veículos entre municípios, a otimização das rotas, o melhor aproveitamento da frota e a ampliação da capacidade de deslocamento dos usuários do SUS para consultas, exames, tratamentos e demais procedimentos eletivos realizados fora de seu município de residência.

  O cofinanciamento do transporte eletivo foi estruturado nos anos de 2022 e 2023 por meio da transferência de recursos para os municípios e, a partir de 2026, foi transferido para consórcios para apoiar a operação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo, reduzindo o ônus financeiro dos municípios e contribuindo para a manutenção do serviço. Atualmente, essa frente tem como principal instrumento a Resolução SES/MG nº 11.015/2026. Além do custeio, foi estruturado o financiamento estadual por meio da transferência de recursos de investimento aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) para aquisição de micro-ônibus e ampliação da capacidade de transporte dos sistemas regionais.
- **Resultados Alcançados**
  - **Transporta SUS-MG.**
    - Até 2026, foram adquiridos 684 micro-ônibus para redução do déficit de assentos nos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo em Saúde, reduzindo o déficit de assentos para 21%. Ressalta-se que em 2026, por meio de articulação da política estadual transporta SUS e da política federal **Caminhos da Saúde,** iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS), há previsão de zerar o déficit de assentos nos Sistemas Regionais, por meio da doação de vans e micro-ônibus pelo MS.
- **Valor Executado**
  - **Transporta SUS-MG.**
    - Até 2026, foram investidos aproximadamente 408 milhões de reais para aquisição de 684 micro-ônibus. Em 2026, há previsão de custeio de aproximadamente 24 milhões de reais,

destinados aos sistemas de transporte eletivo, tanto os veículos do transportaSUS quanto do Caminhos da Saúde.

- **Prejuízo em Caso de Descontinuidade:** A descontinuidade do Transporta SUS-MG poderia reduzir o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nos municípios de menor porte que dependem do deslocamento para municípios-polo para realização de consultas, exames e tratamentos. A interrupção do cofinanciamento do custeio poderia comprometer a operação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo, aumentar o ônus financeiro dos municípios e reduzir a disponibilidade de transporte para os usuários do SUS, com potencial impacto na continuidade do cuidado e no acesso à rede regionalizada de saúde.

2.7. Assistência Farmacêutica

A consolidação do bloco de Políticas Públicas Continuadas da Assistência Farmacêutica na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) é fundamental à garantia da integralidade da atenção à saúde e da universalidade do acesso no SUS/MG. A gestão estadual empenha-se em prover abastecimento regular e ininterrupto de insumos essenciais, desde a Atenção Primária até os tratamentos de alta complexidade. A contínua descentralização e a regionalização dos serviços fortalecem a autonomia municipal, aproximam o cuidado do cidadão e promovem a sustentabilidade assistencial e financeira do sistema de saúde mineiro.

Sua organização compreende quatro frentes principais:

- Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF),
- Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
- Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF),
- Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF Onco).

Cada componente possui regras próprias de financiamento, aquisição, distribuição e dispensação, mas compartilha sistemas, estruturas logísticas e instrumentos de monitoramento estaduais.

Na Secretaria de Estado de Saúde, entre 2023 e 2026 (setembro), foi pago cerca de R$1,5 bilhão na assistência farmacêutica. Desse total, R$938 milhões foram aplicados na aquisição de medicamentos (CEAF e PNAISP), R$299 milhões para o componente básico da assistência farmacêutica, R$14 milhões no elenco complementar, R$220,8 milhões para o Farmácia de Minas. Além disso, R$ 8 milhões foram destinados para investimento na assistência farmacêutica municipal, dos quais R$2,6 milhões são de emendas.

2.7.1. Entregas

Entregas prioritárias

Farmácia Digital Plano de governo

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** Solução tecnológica desenvolvida no escopo do projeto "Farmácia Aqui Pertim" para solicitação 100% online de medicamentos do CEAF, permitindo a abertura de processos e o envio eletrônico de pendências documentais sem necessidade de comparecimento presencial (https://farmaciadigital.saude.mg.gov.br/home, integrado ao aplicativo MG App).
- **Quantidade realizada:** Até 07/10/2026, foram contabilizadas 920 solicitações digitais cadastradas, oriundas de 91 municípios e abrangendo 26 Unidades Regionais de Saúde, cobrindo 71 PCDTs.
- **Valor executado:** R$ 1.851.457,95 desde o início do projeto de desenvolvimento.
- **Data de início e fim:** Lançado em 14/05/2026, com sustentação contínua.
- **Status:** Em andamento. Previsão de incrementos que permitam a submissão de pedidos estritamente pelo sistema Farmácia Digital em 19/04/2027.
- **Informações adicionais:** a fase inicial foca na desburocratização da abertura de processos. As evoluções projetadas preveem módulo de prescrição eletrônica com alertas para médicos, validação automatizada de documentos, emissão de notificações de status ao usuário e a migração completa da análise técnica, hoje feita via SEI!, para o ambiente nativo da plataforma, reformulando os processos de trabalho da equipe. Há também previsão de análise preditiva de processos e de conferência de documentação com uso de IA no primeiro semestre de 2027

2.7.2. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O CEAF garante o tratamento medicamentoso ambulatorial de alta complexidade para condições clínicas raras, graves ou crônicas, regido pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. O financiamento e a aquisição dividem-se em Grupo 1A (aquisição e distribuição centralizada pelo Ministério da Saúde), Grupo 1B (aquisição pelo Estado com financiamento federal) e Grupo 2 (aquisição e financiamento integrais do Estado). O acesso segue quatro etapas:
  - **Solicitação:** o cidadão apresenta o LME, a prescrição, exames e demais documentos exigidos no PCDT, na Farmácia Regional, nos municípios aderidos à Descentralização do CEAF ou, desde maio de 2026, de forma remota pela Farmácia Digital;

- **Análise:** a equipe da SAF verifica se a solicitação atende aos critérios do PCDT;
- **Dispensação:** após a aprovação, o medicamento é disponibilizado na farmácia responsável;
- **Renovação:** nos tratamentos contínuos, a solicitação é renovada periodicamente. O andamento pode ser consultado no MG App.

- **Valor Executado:** Valor pago para a aquisição de medicamentos do CEAF em 2026, até setembro, considerando os Restos a Pagar, é de R$212 milhões. Considerando apenas os valores empenhados em 2026, está planejado até dezembro o pagamento de R$196 milhões
- **Resultados alcançados:** O CEAF contempla, nos Grupos 1B e 2, 90 medicamentos em 176 apresentações. Em 2025, foram analisados 152.887 processos (109.926 de primeira avaliação e 42.961 de reavaliação), com tempo médio de 21,8 dias; em 2026, até setembro, 110.533 processos. Em setembro de 2026, foram emitidos 15.056 pareceres, com tempo médio de resposta de 34,2 dias úteis (mediana de 32). A força-tarefa de 2024 mobilizou 41 colaboradores, analisou cerca de 11 mil processos e reduziu em 53% o tempo de resposta das solicitações de insulinas.
  - O **Alta Segura** tem como objetivo qualificar a transição do cuidado hospitalar para a rede assistencial no território, beneficiando pacientes transplantados que necessitam de medicamentos imunossupressores para prevenir a rejeição do órgão transplantado. O programa também estabelece o prazo de até 30 dias para que os procuradores legais providenciem a documentação necessária à continuidade do atendimento nas unidades da Farmácia de Minas. A iniciativa contempla 6 municípios, 10 instituições hospitalares e 7 tipos de medicamentos, fortalecendo a integração entre os serviços hospitalares e a Assistência Farmacêutica.
  - **Projeto Piloto de Descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (DCEAF) em serviço especializado da Rede de Atenção à Saúde especificamente junto à Santa Casa de Belo Horizonte.** A iniciativa recém-publicada pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 5.997, de 02 de outubro de 2026, consiste em disponibilizar os medicamentos infusionais do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) diretamente nos serviços municipais especializados, integrados às Redes de Atenção à Saúde. Entre os principais benefícios esperados, destacam-se a ampliação do acesso aos medicamentos, a redução dos deslocamentos dos pacientes, a maior comodidade para a realização do tratamento e o fortalecimento da segurança assistencial, por meio da qualificação da capacidade dos estabelecimentos executores de assegurar a rastreabilidade de todas as etapas relacionadas à assistência farmacêutica, desde o recebimento e armazenamento dos medicamentos até sua administração ao paciente, contribuindo para a qualidade do cuidado e a integralidade da atenção à saúde.
  - **Ampliação das Estratégias de Aquisição de Medicamentos do CEAF.** A estratégia consiste na adoção do credenciamento paralelo e não excludente como mecanismo complementar para aquisição de medicamentos do CEAF.O objetivo é ampliar fornecedores, agilizar

contratações e reduzir o risco de desabastecimento. A implantação do modelo está em andamento na SES-MG. O Estudo Técnico Preliminar foi concluído e o Termo de Referência está em fase final de elaboração. Excepcionalmente, podem ser realizadas dispensas emergenciais, como no caso da Ciclosporina, para evitar o desabastecimento.

- **Atendimento da Farmácia nas Unidades de Atendimento Integrado – UAI.** O atendimento para abertura de processos de solicitação de medicamentos especializados da Farmácia de Minas está disponível em quatro UAIs, distribuídas em dois municípios: Belo Horizonte e Uberlândia, com agendamento prévio pelo MG App ou pelo Portal Cidadão MG. Trata-se de uma parceria entre a SES-MG e a SEPLAG-MG que permite que os cidadãos realizem a entrega da documentação necessária para acesso aos medicamentos especializados em locais de fácil acesso e ampla capilaridade, proporcionando mais comodidade aos usuários e contribuindo para a redução da demanda presencial nas unidades da Farmácia de Minas.

Descentralização do Componente Especializado (DCEAF)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** Política que descentraliza para os municípios habilitados as etapas operacionais de abertura de solicitações, programação, recebimento, dispensação e renovação do tratamento com medicamentos do CEAF, mantendo sob responsabilidade da SES/MG a análise técnica das solicitações. A Resolução SES/MG nº 9.063/2023 regulamenta o seu financiamento para adesão dos municípios e demais providências.
- **Resultados alcançados:** Atualmente, a DCEAF conta com 766 municípios aderidos à estratégia, dentre os quais 603 estão efetivamente executando.
- **Valor executado:** Entre 2023 e 2025, foram repassados R$ 76,5 milhões aos municípios em custeio e incentivo; para 2026, foi programado orçamento de R$ 28.812.288,97 em repasses diretos de incentivo aos municípios executantes.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Obrigatoriedade de deslocamento presencial periódico dos usuários até a sede da respectiva Unidade Regional de Saúde (entre as 28 URS), impondo barreiras geográficas, elevando custos de transporte e gerando atrasos no início dos tratamentos.
- **Informações adicionais:** sob a perspectiva de transição de governo, a ativação das unidades aderidas representa a principal alavanca de expansão do acesso local a medicamentos especializados, sem necessidade de alterações normativas ou novos marcos legais.

Elenco Complementar

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** Fruto da consolidação e evolução do projeto "Farmácia Aqui Pertim", a política reorganizou a disponibilização de 48 medicamentos do CEAF com perfil assistencial compatível com a Atenção Primária, transferindo o fornecimento desses itens para os municípios aderentes, aproximando o medicamento da residência do cidadão e

eliminando a abertura de processos administrativos complexos no CEAF. O repasse financeiro de incentivo aos municípios para cobrir os custos operacionais de recebimento, armazenamento e dispensação desses medicamentos ao cidadão é regido pela Resolução SES/MG nº 9.063/2023.

- **Resultados alcançados:** São 518 municípios aderentes, correspondendo a 60,7% dos municípios mineiros, com um rol de 48 medicamentos executados via Ata de Registro de Preços Estadual (ARPE).
- **Valor executado:** Repasse antecipado de R$ 14,1 milhões para apoiar o início da execução municipal. Em 2026, foram programados R$ 35.160.063,18, dos quais R$ 23,9 milhões já foram repassados aos municípios até setembro.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Perda da comodidade do acesso local no município, retardo e burocratização do atendimento, retorno de usuários às Unidades Regionais de Saúde e elevação dos custos indiretos de transporte para os cidadãos. A garantia formal ao medicamento permanece via fluxo tradicional do CEAF.
- **Informações adicionais:** a execução via Ata de Registro de Preços Estadual é o principal mecanismo de apoio técnico e econômico do Estado aos municípios executantes. A revisão periódica do elenco e do estudo de financiamento, prevista na Resolução SES/MG nº 11.005/2026, deverá ser orientada pela avaliação contínua da execução junto aos territórios.

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O CBAF destina-se ao fornecimento de medicamentos e insumos essenciais voltados às necessidades primárias de saúde, cobrindo agravos de elevada prevalência como hipertensão, diabetes e infecções no âmbito da APS. Em Minas Gerais, a política foi reorganizada e consolidada pela Resolução SES/MG nº 11.005/2026, que unificou o regramento do CBAF, instituiu o Elenco Complementar e estabeleceu o incentivo para enfrentamento de arboviroses. Além do aporte financeiro, o Estado apoia a aquisição municipal mediante a Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), disponibilizando Atas de Registro de Preços Estaduais para gerar economia de escala.
- **Resultados alcançados:** Até outubro de 2026, 851 municípios aderiram à política e 834 foram beneficiados pela ERAF. Foi adotada contrapartida estadual superior ao piso federal (até R$ 3,35 por habitante/ano, frente ao mínimo nacional de R$ 3,01); criado incentivo específico para medicamentos e insumos de combate às arboviroses (até R$ 0,51 por habitante/ano); estruturado o Elenco Complementar; ampliada a eficiência das compras municipais com o uso das atas estaduais; e alcançada disponibilidade adequada de medicamentos traçadores em 720 municípios
- **Valor executado:** Entre 2023 e 2025, foram executados R$ 215,8 milhões; para 2026, foi programado o orçamento de R$ 85 milhões, com R$ 59.695.870,53 repassados
- **Prejuízo de descontinuidade:** Risco relevante de desequilíbrio financeiro para os municípios, redução na capacidade de compra municipal, comprometimento do combate às epidemias sazonais de arboviroses e

retração nos ganhos de acesso obtidos com a descentralização do Elenco Complementar.

- **Informações adicionais:** a Resolução SES/MG nº 11.005/2026 é o instrumento central de vigência e integração da política de financiamento e gestão da Assistência Farmacêutica Básica. Em outubro de 2026, dos 20 itens do CBAF monitorados, 14 estavam abastecidos, 2 em nível parcial e 4 desabastecidos.

Outras políticas públicas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Farmácia de Minas	Programa estruturado em 2007/2008 e reconfigurado pelas Resoluções SES/MG nº 8.428/2022 e nº 10.397/2025, que evoluiu do financiamento de obras para o custeio dos serviços farmacêuticos municipais (1 serviço a cada 20 mil habitantes, ao menos 1 por município), com foco no cuidado clínico, na consulta farmacêutica e no uso racional de medicamentos. Valores: R$ 172,9 milhões de custeio entre 2023 e 2025; para 2026, programados R$ 60 milhões, dos quais R$ 180 mil em investimento. Fim das filas - A reorganização dos processos de trabalho nas Farmácias de Minas, associada à melhoria da infraestrutura física, à ampliação dos guichês de atendimento, à implantação do agendamento remoto e à expansão dos serviços farmacêuticos nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI), promoveu avanços significativos na qualidade do atendimento	851 municípios aderentes (99,7%); estabelecimentos financiados de 738 para até 1.402, nos últimos 12 meses: 144.034 consultas farmacêuticas na APS, 473.812 na atenção especializada, 3.131 atividades coletivas na APS (34.138 participações) e 23.274 na atenção especializada. Essas medidas contribuíram para superar um cenário histórico de filas e longas esperas. Com as melhorias implementadas, busca-se proporcionar um atendimento mais organizado, ágil, acessível e humanizado, garantindo maior conforto e dignidade aos usuários e melhores condições de trabalho para as equipes, além de fortalecer a eficiência e a capacidade de resposta da Assistência Farmacêutica estadual.

2.8. Judicialização

2.8.1. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Gestão da Judicialização da Saúde

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A judicialização da saúde ocorre quando o cidadão recorre ao Poder Judiciário para obter medicamentos, tratamentos, exames, cirurgias ou internações pelo SUS. Nos últimos anos, a SES/MG promoveu uma transformação histórica, alcançando os melhores resultados já registrados pelo Estado. Com governança e transformação digital, a atuação evoluiu em duas frentes: ampliar a capacidade de cumprimento das decisões judiciais e transformar a judicialização em um termômetro da saúde, capaz de identificar lacunas assistenciais, orientar o aprimoramento das políticas públicas e prevenir novos litígios. Em 2026, essa transformação ganhou nova dimensão com o Programa Estadual de Desjudicialização da Saúde (PEDS), que articula essas frentes em 14 projetos e produtos voltados à eficiência, à inovação e à integração institucional. O financiamento do ressarcimento interfederativo decorrente do cumprimento de decisões judiciais em saúde está regulamentado em Resolução SES/MG nº 11.468/2026.
- **Resultados alcançados:**
    - fornecimento de medicamentos: cobertura de 18% em 2020 para 95% em 2025;
    - fornecimento de dietas: cobertura de 32% em 2024 para 97% em 2025;
    - redução de 86,7% no tempo médio de tramitação interna;
    - 8.316 notas técnicas produzidas com a Defensoria Pública entre 2020 e 2025, com 61% das demandas analisadas não convertidas em ações judiciais;
    - 429 processos migrados voluntariamente da via judicial para a via administrativa;
    - ressarcimento interfederativo (Tema 1234 do STF): instrução de mais de R$ 105 milhões entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, com potencial estimado de recuperação de R$ 2,3 bilhões.
- **Valor executado:** R$ 637,7 milhões (2023), R$ 995,4 milhões (2024) e R$ 840,4 milhões (2025); orçamento planejado para 2026 de R$ 648,9 milhões.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade da política compromete o cumprimento das decisões judiciais, com risco de desabastecimento, interrupção de tratamentos, bloqueios judiciais e aumento de custos. Nos primeiros 90 dias, é essencial assegurar a continuidade das aquisições, contratos, estoques e pagamentos, preservar os pedidos de ressarcimento à União e manter a implantação do e-SUS AF, a evolução do SIGJUD e do Portal JudSaúde e a integração com o Sistema de Justiça. A manutenção das equipes técnicas e dos projetos do PEDS é fundamental para preservar e ampliar os resultados alcançados.

2.9. Vigilância em Saúde

A vigilância em saúde contempla áreas fundamentais para o monitoramento e prevenção de agravos, como a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Entre 2023 e 2026 foram aplicados mais de R$ 1,78 bilhão em ações relacionadas à vigilância.

No âmbito da vigilância sanitária, destacam-se o VISA CIS (descrito no capítulo de consórcios), o Programa de Descentralização da Vigilância Sanitária (cujos pagamentos se encerraram em 2024), o Pro AGRI (pagamentos encerrados em 2023) e o desenvolvimento dos sistemas VISA Digital Estados e Municípios (descritos na lista de sistemas a serem concluídos). Nesse sentido, entre 2023 e 2026, foram aplicados R$164 milhões em vigilância sanitária, sendo R$134 milhões para custeio e R$29,8 milhões para investimento.

No âmbito da vigilância epidemiológica, incluem-se a vigilância de condições crônicas, doenças transmissíveis, imunização e saúde ambiental, as políticas de imunização e prevenção às arboviroses. Entre 2023 e 2026 foram financiados R$883 milhões em ações da vigilância epidemiológica na SES/MG.

Ainda foram investidos na Política Estadual de Vigilância - VIGIMINAS cerca de R$100 milhões e R$128 milhões na vigilância laboratorial. Além de R$ 20 milhões nas indenizações para filhos de pais segregados com hanseníase.

Finalmente foram aplicados R$335 milhões em outras ações da vigilância como os Termos junto à OPAS e outros investimentos em municípios para fortalecimento da vigilância, os quais incluem R$11 milhões em emendas parlamentares. Destaca-se que a vigilância é área extensa e que trouxemos um recorte das políticas de maior montante financeiro e relevância assistencial.

2.9.1. Políticas Públicas

Políticas Públicas prioritárias

Arboviroses

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A Política Estadual para Vigilância, Prevenção e Controle das Arboviroses, instituída pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.415/2023, integra ações de vigilância epidemiológica, entomológica e laboratorial, prevenção e controle vetorial, assistência à saúde, mobilização social e apoio aos municípios. Para o período sazonal 2026–2027, merecem destaque o monitoramento dos planos de

contingência estadual e municipais, a análise dos indicadores epidemiológicos e entomológicos, a identificação e o tratamento de áreas prioritárias, a preparação da rede assistencial e o fortalecimento da capacidade diagnóstica, bem como a manutenção das estratégias de controle vetorial – VigiDrones, Wolbachia, UBV, ovitrampas e Estações Disseminadoras de Larvicidas –, de equipamentos, qualificação profissional, comunicação de risco e mobilização social. Essas iniciativas são orientadas pelo Plano Estadual de Contingência (PEC-ARBO) e pelos Planos Municipais, aprovados pela Resolução SES/MG nº 10.440/2025 para dezembro de 2025 a novembro de 2027.

- **Resultados alcançados:**
  - menor taxa de mortalidade por arboviroses alcançada em 2025;
  - política estadual instituída e planos de contingência 2025–2027 publicados, com painel de monitoramento (100% dos municípios cadastrados e cerca de 80% de respostas);
  - VigiDrones: mapeamento de 30% da área urbana dos municípios mineiros, com tratamento de focos;
  - UBV descentralizado pelos CIS, com atendimento de 100% das solicitações municipais, e manutenção descentralizada de equipamentos (Resolução nº 10.442/2025);
  - Conclusão da Biofábrica Wolbachia; início das Estações Disseminadoras de Larvicidas em Uberlândia, Araguari e Ituiutaba;
  - Monitoramento dos planos de contingência: desenvolvimento de painel de acompanhamento dos indicadores municipais, com cadastro de 100% dos municípios para preenchimento do formulário on-line e cerca de 80% de respostas de autodeclaração sobre a execução dos planos.
  - Investigação de óbitos: instituição do Comitê Estadual de Investigação de Óbitos por Arboviroses, visando identificar fatores associados à gravidade e subsidiar medidas de prevenção e qualificação da assistência.
  - Rede laboratorial e assistencial: fortalecimento da articulação com o LACEN e os centros colaboradores para diagnóstico, vigilância e investigação de arboviroses.
  - Vigilância entomológica: realização de capacitações para implantação e utilização de ovitrampas, monitoramento da resistência do mosquito aos inseticidas e qualificação das equipes para identificação de áreas prioritárias.
  - Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL): início da implantação da tecnologia em Uberlândia, Araguari e Ituiutaba, com capacitação das equipes e definição de áreas prioritárias.
  - - Qualificação profissional: realização de seminários, oficinas, webinários, treinamentos e atividades da Jornada Mineira de Arboviroses, abrangendo vigilância epidemiológica e entomológica, controle vetorial, manejo clínico e vigilância da febre amarela.
  - - Vigilância de outras arboviroses: fortalecimento da vigilância integrada da febre amarela e da febre do Oropouche, incluindo investigação epidemiológica, capacitação, testagem e qualificação dos fluxos laboratoriais.

- **Valor executado:** Para a sazonalidade 2025–2026, foi estabelecido o montante de R$ 35.163.217,50. Para a política, foram definidos valores anuais de referência de R$ 28.050.000,00 para serviços de ultrabaixo volume (UBV) veicular, R$ 12.486.600,00 para manutenção dos conjuntos de UBV veicular cedidos pela SES-MG e R$ 7.376.617,50 para manutenção de equipamentos costais motorizados, totalizando R$ 47,9 milhões. Esses valores correspondem aos montantes informados para a sazonalidade e para as referências anuais da política, não necessariamente ao total efetivamente pago ou liquidado.
    - Drones: A Política VigiDrones contou com previsão inicial de aproximadamente R$ 30,5 milhões, dos quais cerca de R$ 30 milhões haviam sido investidos até maio de 2026. Para o ciclo 2026–2028, foi estimado novo investimento de R$ 42,5 milhões.
    - Biofábrica Wolbachia: A fonte dos recursos é o Acordo Judicial de Reparação Integral decorrente do rompimento da Barragem de Brumadinho (AJRI).
        - Investimento global previsto: R$ 77.582.596,51.
        - Na Fase I, de implantação, o recurso total previsto é de R$ 20.406.887,83, sendo executado e auditado pela FGV, até o momento, R$ 16.710.146,37;
        - Na Fase II, que se refere à operação pelo período de 5 (cinco) anos, o recurso previsto é de R$ 57.175.708,68, sendo executado, até o momento, R$ 14.000.000,00.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A interrupção ou redução dos investimentos poderá comprometer a prevenção, a detecção e a resposta oportuna às arboviroses, prejudicando a continuidade do controle vetorial, a manutenção de equipamentos, a disponibilidade de insumos e a execução dos serviços descentralizados. Também poderá reduzir a capacidade operacional dos municípios e consórcios, enfraquecer a integração entre vigilância, laboratório e assistência e comprometer os resultados das estratégias tecnológicas implantadas. No período sazonal 2026–2027, esses impactos poderão dificultar o tratamento oportuno de áreas prioritárias, a organização da rede assistencial e a prevenção de casos graves e óbitos evitáveis.

Imunização – Programa Mineiro de Imunizações (PMI)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O Programa Mineiro de Imunizações (PMI) constitui uma política estruturante da SES/MG, regulamentada pela Resolução SES/MG nº 10.441/2025, que normatiza, financia, executa e monitora as ações de vacinação em todo o Estado, com o objetivo de ampliar e recuperar as coberturas vacinais, promover o controle, a eliminação e a erradicação de doenças imunopreveníveis e reduzir a morbimortalidade. Abrange os 853 municípios, com financiamento descentralizado aos Fundos Municipais de Saúde, e envolve estratégias de mobilização, vacinação extramuros, fortalecimento da Rede de Frio, capacitação de profissionais, ampliação do acesso aos CRIE e vigilância de ESAVI. Está organizado em três eixos: Governança; Imunização e Rede de Frio; e integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde.
- **Resultados alcançados:**

  - Recuperação das coberturas vacinais: em 2021, nenhuma das 19 vacinas do calendário infantil atingiu a meta de cobertura. Em 2025, 17 das 19 vacinas ultrapassaram 80% de cobertura.
  - Recorde de vacinação: em 2025, foram aplicadas 16,4 milhões de doses, além de Minas Gerais ter alcançado a segunda maior média de cobertura vacinal entre os estados brasileiros.
  - Mobilização e campanhas: realização de campanhas de multivacinação; em 2026, foram aplicadas 794.711 doses. No Dia D de 2025, participaram 736 municípios (85%) e 4.035 escolas.
  - Expansão da vacinação: entrega de 252 Vacimóveis e fantasias do Zé Gotinha, ampliando as estratégias de vacinação extramuros.
  - Comunicação e combate à desinformação: desenvolvimento de planos de comunicação e criação de painéis temáticos de acesso aberto.
  - Articulação institucional: parcerias com o Ministério Público, por meio do Selo BoraVacinar; com a UFMG, para oficinas e cursos; e com a SEE, para ações de vacinação nas escolas.
  - Fortalecimento do CRIE: descentralização e informatização dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais.
  - Reconhecimento de boas práticas: premiações e iniciativas de valorização das experiências exitosas em vacinação.
  - Inovação: desenvolvimento das estratégias “Vacina em Dia” e “Onde Tem Vacina”, além de game voltado ao enfrentamento da hesitação vacinal.
- **Valor executado:** Investimentos superiores a R$ 375 milhões nas iniciativas de vacinação: R$ 231 milhões no Programa Mineiro de Imunização e ações de custeio do Vacina Mais Minas, R$ 101 milhões na implementação e operação dos Vacimóveis e R$ 2,7 milhões nas fantasias do Zé Gotinha; R$ 6 milhões para os Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais; R$ 35 milhões em aquisição de materiais em ações de vacinação
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do PMI poderá comprometer a recuperação e a ampliação das coberturas vacinais, reduzindo a capacidade de mobilização dos municípios, de estratégias extramuros e de atendimento a populações vulneráveis, além de comprometer os resultados alcançados e a resposta do Estado diante do risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. Poderá ainda fragilizar a Rede de Frio, com riscos à conservação dos imunobiológicos, reduzir a capacidade de investigação e manejo de ESAVI e de comunicação e mobilização, contribuindo para o aumento da hesitação vacinal e do risco epidemiológico.

Vigiminas

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** O Programa VigiMinas, instituído pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.545, de 22 de setembro de 2021 e Resolução SES/MG nº 7.734, de 22 de setembro de 2021, tem como finalidade financiar, estruturar e fortalecer as ações de Vigilância em Saúde nos âmbitos estadual e municipal, por meio da implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Minas Gerais (SEVS-MG).

A iniciativa contempla todos os municípios mineiros e abrange as áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, da saúde do trabalhador, laboratorial e de emergências em saúde pública, além de serviços especializados de interesse epidemiológico. Sua atuação envolve o financiamento de ações e serviços, o fortalecimento das equipes municipais, a organização dos processos de trabalho, a definição de responsabilidades entre os entes envolvidos e o monitoramento de indicadores de desempenho.

- **Resultados alcançados:** Entre os resultados institucionais já previstos e desenvolvidos no âmbito do programa, destacam-se a construção do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde (SEVS-MG), a definição dos eixos de atuação, a organização dos processos de trabalho e o estabelecimento de ações e indicadores destinados a orientar e avaliar o desempenho municipal.

  O programa também consolidou um modelo de atuação integrada entre a Secretaria de Estado de Saúde, as Unidades Regionais de Saúde e as gestões municipais, buscando maior clareza na distribuição de responsabilidades e melhor articulação entre os diferentes componentes da Vigilância em Saúde. Outro avanço relevante é a previsão de financiamento para todos os municípios mineiros, com critérios técnicos de distribuição dos recursos, considerando aspectos como o porte populacional, a estrutura das equipes municipais e a oferta de serviços especializados de interesse epidemiológico.

  Além disso, o VigiMinas prevê mecanismos de monitoramento por indicadores, registro de informações e acompanhamento dos resultados por meio do Painel VigiMinas, favorecendo o aprimoramento contínuo da política pública.
- **Valor executado:**

Ano	Resolução	Valor
2021	7.734/2021	R$ 55.951.546,00
2025	10.388/2025	R$ 34.904.805,00
	10.455/2025	R$ 16.480.000,00
2026	10.917/2026	R$ 40.013.913,00
	11.018/2026	R$ 2.500.000,00
	11.393/2026	R$ 600.000,00
	Total	**R$ 150.450.264,00**

- **Prejuízo de descontinuidade:** A eventual descontinuidade do VigiMinas poderá comprometer a manutenção das equipes contratadas e prejudicar a padronização de procedimentos, o acompanhamento de indicadores, a consolidação de informações e a identificação oportuna de riscos epidemiológicos, sanitários e ambientais. Como consequência, poderá haver redução da capacidade de resposta diante de surtos, epidemias e emergências em saúde pública. Esses efeitos podem ser mais significativos nos municípios com menor capacidade financeira e estrutural.

Enfrentamento a emergências em Saúde Pública

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Política Pública:** A SES/MG vem instituindo resoluções para o financiamento de ações de preparação e resposta às emergências em saúde pública, assegurando suporte aos municípios mineiros. Atualmente, a política é regida pela Resolução SES/MG nº 10.600, de 21 de outubro de 2025, que estabelece regras de financiamento estadual para custeio de ações de enfrentamento de doenças caracterizadas como emergências em saúde pública, com ênfase nas arboviroses, nas doenças transmissíveis agudas causadas por vírus respiratórios e em outras doenças transmissíveis de importância epidemiológica. Abrange os 853 municípios mineiros e prevê repasses financeiros para ações de preparação e resposta, com vigência até 31 de dezembro de 2029.

  A política busca fortalecer a vigilância, a prevenção e o controle dessas doenças, tanto nos períodos sazonais e interepidêmicos quanto diante de epidemias e outras emergências em saúde pública. Sua relevância é ampliada pelo contexto climático previsto para 2026 e 2027, com a possibilidade de intensificação do fenômeno El Niño, que pode alterar os padrões de temperatura e precipitação e favorecer condições propícias à proliferação do *Aedes aegypti*. Esse cenário reforça a necessidade de preparação antecipada dos municípios e de manutenção da capacidade de resposta do SUS.

  O financiamento pode ser utilizado, entre outras finalidades, para custeio de equipes, aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, mobilização social, vigilância laboratorial, locação de veículos e execução de ações previstas em planos de contingência.
- **Resultados alcançados:** A estratégia atualmente vigente, que é a Resolução SES/MG nº 10.600, de 21 de outubro de 2025, estruturou um modelo estadual de financiamento para apoiar os 853 municípios mineiros no enfrentamento das emergências em saúde pública, com previsão de R$ 70,99 milhões anuais, distribuídos em duas categorias: parcela de preparação, no valor total de R$ 23,66 milhões, e parcela de resposta, de R$ 47,33 milhões.

  A resolução também estabeleceu indicadores de monitoramento e mecanismos de acompanhamento do desempenho municipal. Entre os parâmetros definidos estão o envio de relatórios de execução dos Planos Municipais de Contingência para Arboviroses, a participação dos profissionais em ações de qualificação e o encerramento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e de doenças exantemáticas, como sarampo e rubéola, por critério laboratorial.

  Essa estrutura de financiamento e monitoramento é especialmente relevante diante do risco de agravamento do cenário das arboviroses associado ao El Niño em 2026 e 2027, pois favorece o planejamento prévio, o fortalecimento da vigilância e a organização das ações de prevenção e resposta nos municípios.
- **Valor executado:**

Ano	Resolução	Valor
2024	9435/2024	R$ 29.329.971,40
	9678/2024	R$ 84.508.226,42
2025	10.015/2025	R$ 2.748.681,56
	10.116/2025	R$ 5.719.668,86
	10.147/2025	R$ 1.282.429,53
	10.148/2025	R$ 779.061,70
	10.173/2025	R$ 467.742,86
	10.223/2025	R$ 733.141,74
	10.290/2025	R$ 142.498,39
	10.348/2025	R$ 57.378,68
	10.409/2025	R$ 18.742.038,91
	10.600/2025	R$ 70.046.451,40
2026	10.935/2026	R$ 764.272,20
Total		**R$ 215.321.563,65**

- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade da estratégia poderá comprometer a capacidade dos municípios de manter ações de preparação e resposta às emergências em saúde pública. A interrupção dos repasses poderá dificultar o custeio das equipes, a aquisição de insumos, a realização de atividades de mobilização social, o apoio à vigilância laboratorial e a implementação dos planos municipais de contingência.

  O risco é particularmente relevante diante da possibilidade de intensificação do El Niño e de seus possíveis efeitos sobre o cenário epidemiológico das arboviroses em 2026 e 2027.

  Também poderá prejudicar a continuidade do monitoramento dos indicadores e das ações de qualificação dos profissionais, reduzindo a capacidade de identificação oportuna de mudanças no cenário epidemiológico e de organização das respostas locais. Considerando a abrangência estadual da estratégia, a manutenção do financiamento é relevante para assegurar a continuidade do apoio aos municípios, fortalecer a articulação entre Estado e municípios e reduzir os riscos de agravamento de emergências, sobrecarga dos serviços de saúde e ocorrência de óbitos evitáveis.

2.10. Consórcios

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS), regidos pela Lei Federal nº 11.107/2005, permitem que municípios dividam custos e ganhem escala na contratação de consultas e exames especializados, compra de veículos e montagem de equipes técnicas. A SES/MG também os utiliza como canal de repasse de políticas estaduais. Hoje são 75 CIS ativos – 65

generalistas e 10 temáticos de urgência (SAMU) –, cobrindo os 853 municípios, sob coordenação da Subsecretaria de Regionalização.

Considerando o papel cada vez mais estratégico dos Consórcios Intermunicipais de Saúde na execução e operacionalização das políticas públicas de saúde em Minas Gerais, a SES/MG estruturou o Programa de Conformidade dos Consórcios Públicos de Saúde, como instrumento de acompanhamento, transparência, integridade e fortalecimento da governança dessas instituições. O Programa foi instituído pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.987, de 05 de dezembro de 2024.

Destacamos que as entregas e políticas incluídas no presente capítulo se relacionam com diversos níveis de atenção, no entanto, optou-se por consolidá-las a fim de que seja possível ter uma visão geral da atuação do sistema saúde em parceria com os Consórcios.

2.10.1. Entregas

Outras entregas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (Em andamento – Pagamento realizado)
SES/MG / Consórcios Intermunicipais de Saúde	Carreta de Especialidades – Saúde Mais Perto	Ampliação da oferta de consultas especializadas e exames de média complexidade por unidades móveis, complementar à rede, para reduzir barreiras geográficas, filas e tempo de resposta. O piloto, na RMBH, contou com 31 municípios e 4 unidades móveis (saúde da mulher, cardiologia e oftalmologia); a primeira expansão se deu nas macrorregiões Norte, Nordeste e Jequitinhonha. Foram realizadas 40.272 consultas e 29.211 procedimentos e exames. Custeio de aproximadamente R$ 11,2 milhões (piloto 2025: R$ 5 milhões + R$ 1,35 milhão; expansão 2026: R$ 2,9 milhões repassados, com previsão de R$ 5,3 milhões no ano). A gestão das filas permanece municipal, sendo vedada a captação de pacientes pelos consórcios.	Em andamento (dez/2025 – 2026).
SES/MG / CIS	FarmaCIS	Fomento ao gerenciamento regional do componente básico de medicamentos por consórcios, com mais eficiência, rapidez e economia na aquisição, armazenamento e distribuição. Repasse de aproximadamente R$ 24,3 milhões no final de 2022 (Deliberação CIB-SUS/MG 3.952 e Resolução SES/MG 8.368).	Concluída.
SES/MG	Vacimóveis	Estratégia de vacinação extramuros da SES-MG, por meio de veículos adaptados, para ampliar o acesso à imunização, fortalecer a busca ativa e	Concluída a etapa de investimento

Nome do órgão/entidade	Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (Em andamento – Pagamento realizado)
		aumentar as coberturas vacinais, especialmente em áreas de difícil acesso e territórios vulneráveis. Resolução: A Resolução SES/MG nº 9.034/2023 destinou R$ 71,16 milhões para a aquisição de veículos de vacinação, com adesão de 50 Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS)	e adesão prevista na resolução. A estratégia permanece em execução e monitoramento dos resultados
SES/MG / CIS	VigiDrone (VANT)	Uso de drones para mapear áreas urbanas, identificar e georreferenciar potenciais criadouros do Aedes aegypti e apoiar a vigilância e o controle das arboviroses. Até maio de 2026, aproximadamente 497 mil hectares mapeados e mais de 334 mil pontos de interesse identificados. Instituída pela Resolução SES/MG nº 9.035/2023; a Resolução nº 11.198/2026 regulamenta o ciclo 2026–2028, com previsão de R$ 42,5 milhões. Até o presente momento já foram aplicados R$29,8 milhões.	Em execução.
SES/MG / CIS	UBV Veicular	Estratégia de controle vetorial por meio da aplicação espacial de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV Veicular), conhecida como “fumacê”, para o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e Zika. A Resolução SES/MG nº 9.590/2024 destinou aproximadamente R$ 28 milhões ao financiamento da estratégia. Em 2025, a Resolução SES/MG nº 10.442/2025 deu continuidade à iniciativa, com foco na gestão descentralizada de insumos, equipamentos e tratamento de áreas pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).	Concluídas a estruturação e a regulamentação; execução contínua.
SES/MG / CIS	TelePrEP – Profilaxia Pré-Exposição ao HIV	Teleatendimento para ampliar o acesso à PrEP, reduzindo barreiras geográficas. Em articulação e pactuação com os CIS para implantação de máquinas automatizadas de dispensação dos medicamentos.	Em andamento.
SES/MG / CIS	PROCONSÓRCIO	Programa de Desenvolvimento dos Consórcios Públicos de Saúde, voltado ao fortalecimento dos CIS como atores da regionalização, com eixo de investimento em infraestrutura (melhoria de imóveis e aquisição de equipamentos médico-assistenciais). 45 CIS contemplados no eixo de infraestrutura; cerca de R$ 94,6 milhões investidos até 2026 (R$ 42,5 mi em obras, R$ 11,2 mi em equipamentos e R$ 40,5 mi em obras e equipamentos em conjunto)	Pagamento Concluído Status: em andamento

2.10.2. Políticas Públicas

Políticas Prioritárias

VISA - CIS

- **Nome da instituição:** SES/MG
- **Descrição da política:** O Programa VISA-CIS, instituído em 2024, em parceria com os Consórcios Públicos de Saúde, tem como objetivo fortalecer a Vigilância Sanitária municipal, especialmente nos municípios de pequeno porte com limitações de estrutura e capacidade técnica.

  O programa viabiliza o repasse de recursos aos Consórcios, que disponibilizam equipes multiprofissionais para apoiar os municípios, em articulação com as URS e as Vigilâncias Sanitárias municipais. As ações são definidas em Planos de Trabalho Regionais, conforme as necessidades de cada território.

  Sua execução teve início em 2025, e o segundo ciclo está em andamento desde agosto de 2026, com vigência até julho de 2027. Atualmente, o programa possui caráter temporário, estando em curso sua avaliação quanto aos resultados, impactos e efetividade, para subsidiar a decisão e demonstrar a importância da sua continuidade.
- **Resultados alcançados:** O monitoramento parcial realizado em maio de 2026 evidenciou avanços na implementação do VISA-CIS, com a contratação de aproximadamente 280 profissionais, adesão de cerca de 97% dos municípios elegíveis e início das ações de apoio técnico, incluindo inspeção sanitária, educação sanitária, capacitação, gestão da informação e assessoramento jurídico.

  A execução é acompanhada por indicadores de monitoramento previstos na Resolução SES/MG nº 9.637/2024, que avaliam a implantação e as ações desenvolvidas nos territórios.
- **Valores executados e origem dos recursos:** Recurso Estadual, transferido diretamente aos Consórcios:

  1º ANO (2024): R$5.914.764,02 (capital - estruturação do serviço)

  R$ 34.310.187,40 (2025) – custeio

  2º ANO (2026): R$32.231.023,35 - custeio.
- Normativas relacionadas:
  - **Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.799/2024:** institui o VISA-CIS.
  - **Resolução SES/MG nº 9.637/2024:** estabelece financiamento e monitoramento.
  - **Deliberação CIB-SUS/MG nº 5.118/2025:** atualiza as regras do programa.
  - **Resolução SES/MG nº 10.971/2026:** regulamenta o segundo ano de execução.
  - **Resolução SES/MG nº 11.676/2026:** aprova a avaliação e nova adesão dos Consórcios.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do VISA-CIS poderá comprometer a capacidade das Vigilâncias Sanitárias municipais,

especialmente nos municípios de pequeno porte, com impactos na fiscalização, inspeção, capacitação e resposta às demandas sanitárias.

Também poderá gerar perda da estrutura regionalizada, aumento das desigualdades entre municípios e fragilização da articulação regional, com reflexos na proteção da saúde da população.

2.11. Gestão

Para fins deste relatório, entende-se como áreas afetas à gestão: Manutenção das Unidades Regionais; Provimento e capacitação de pessoal; despesas administrativas; gestão de contratos de rateio; Desenvolvimento de sistemas e governança de dados. Também se incluem as resoluções de apoio às atividades das Secretarias Municipais de Saúde, como a aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos que não estão direcionados para atividades assistenciais, mas sim administrativas.

Nesse sentido, em 2025, foram pagos R$ 747,5 milhões para despesas internas à Secretaria, dos quais R$736 milhões são recursos de custeio e R$12 milhões são recursos de investimento.

Já em relação aos investimentos repassados a municípios e consórcios para despesas administrativas, entre 2023 e 2026 foram pagos R$596 milhões de investimento, dos quais R$179 milhões são resultado de emendas parlamentares impositivas.

2.11.1. Entregas

Entregas prioritárias

Acordo de Pagamento da Dívida com Municípios e Entidades (FES/MG)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** Acordo entre o Governo de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios (AMM), homologado em 08/11/2021 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que garante o pagamento da dívida relativa a repasses da saúde a municípios e instituições previstos no orçamento entre 2009 e 2020 e não quitados. O entendimento também envolveu o TCE-MG e o Cosems/MG, com intermediação da Procuradoria-Geral de Justiça. O governo estadual destinará um montante de R$ 6,7 bilhões, pagos em 98 parcelas: R$ 400 milhões até dezembro de 2021, R$ 400 milhões no primeiro semestre de 2022 e o residual em 96 parcelas mensais e consecutivas a partir de outubro de 2022. Termo de acordo: https://www.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/01.-Ata-da-audiencia-e-termos-do-Acordo-063.pdf
- **Quantidade realizada:** Da dívida inicial de R$ 6.533.736.292,43, foram pagos R$ 4.191.236.857,08 até outubro/2026 (cerca de 62%), correspondente às parcelas até dezembro/2026.

- **Valor executado:** R$ 4.191.236.857,08 (até outubro/2026 referente a parcelas até dezembro/2026).
- **Data de início e fim:** Homologação em 08/11/2021; parcelas mensais até setembro/2030.
- **Status:** Em andamento, com todas as parcelas de 2026 pagas, com possibilidade de adiantamento de parcelas de 2027, conforme fluxo de caixa do estado.
- **Informações Adicionais:** Está previsto para o ano de 2027 o adiantamento no pagamento da dívida junto aos municípios.

Rede Mineira de Dados em Saúde

A RMDS (Rede Mineira de Dados em Saúde) é a infraestrutura de interoperabilidade estadual que faz conversar os 2.786 sistemas de saúde em uso em municípios e hospitais sem substituí-los. Os dados permanecem na origem, nenhum município necessita trocar de sistema e a adesão é voluntária. A Rede reconhece o mesmo cidadão em fontes diferentes e reconstrói a linha do tempo do seu cuidado. Com isso, evita exames repetidos, retrabalho e registros duplicados, que o estudo técnico da contratação aponta como uma das maiores causas de desperdício na área da saúde. A RMDS complementa a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) sem duplicar o envio de dados pelos municípios. A Rede é FUNDAMENTAL para garantir a integralidade do cuidado do paciente, incluindo o prontuário eletrônico e informações básicas como a Fila de Procedimentos Eletivos, o mapa real de leitos dos hospitais, entre outros.

A Rede foi instituída pela Resolução SES/MG nº 11.569/2026, pactuada na CIB-SUS/MG em 19/08/2026, e atende ao Decreto Federal nº 12.560/2025 e ao Programa SUS Digital (Portaria GM/MS nº 3.232/2024). Foi contratada por meio do Pregão Eletrônico nº 29/2025 (Contrato nº 9499216/2026, com a BS Suporte Técnico – Isis Saúde). O trabalho recebeu o 1º lugar e Menção Honrosa no IV Simpósio CI-IA Saúde 2026.

- **Entregas realizadas:**
  - **Tecnologia:** Implementação da Infraestrutura de dados no ambiente cloud da SES.
  - **Cidadão (MG App):** Caderneta de Vacinação digital com comprovante verificável, Certificado Internacional de Vacinação e “Minhas Mamografias” - Campanha Outubro Rosa;
  - **Gestão estadual:** Laudos do SISCAN recebidos diariamente, no lugar da extração manual a cada quadrimestre;
  - **Profissionais:** busca ativa de mulheres com exame de mama alterado ou sem seguimento;
  - **Municípios:** adesão iniciada e indicadores disponibilizados pelo Sistema Radar.
- **Entregas previstas para 2026:**
  - **Governança:** criar o comitê previsto na Resolução SES/MG nº 11.569/2026.

  - **Cidadão:** “Onde Tem Vacina”, Cuidar na Hora Certa - Câncer de próstata (Novembro Azul) e informações sobre a triagem neonatal (teste do pezinho) no MG App.
  - **Municípios:** início da adesão dos municípios mineiros à RMDS a partir do Portal da Rede como porta de entrada; e interoperabilidade com os 12 maiores pontos de conexão do Estado (Belo Horizonte e outros 11 municípios de porte intermediário), que concentram 67% dos atendimentos; Painel de Filas eletivas
  - **Rede suplementar:** interoperabilidade com Unimed-BH, MedSênior e Doc4doc, com consentimento do cidadão, para que o histórico de saúde o acompanhe entre o SUS e os serviços privados.
  - **Gestão estadual:** regras dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE); fila hospitalar eletiva e mapa de leitos para a Regulação; e base da Assistência Farmacêutica.
- **Valor executado:** Foram executados cerca de R$ 36,8 milhões, sendo R$ 35,77 milhões em licença da plataforma e R$ 277 mil em serviços. Origem do recurso: Fonte 92 R$ 37.942.785,40 do Programa SUS Digital do Ministério da Saúde, repassados pelas Portarias GM/MS nº 3.534, de 12/04/2024, e nº 4.924, de 25/07/2024. Nos próximos anos há previsão de novos recursos federais, que reduzem a necessidade de recurso estadual.
- **Data de início e fim:** Início em 30/03/2026 e fim em março de 2031, com vigência contratual de cinco anos.
- **Status:** Em andamento. A base tecnológica está concluída, os primeiros serviços estão no ar e a adesão dos 853 municípios está em preparação, conduzida com a SUBR e COSEMS/MG.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Interromper a RMDS tiraria do ar alguns dos serviços disponibilizados no MG App, como: Caderneta de vacina, “Minhas Mamografias” e a busca ativa por mulheres com exames alterados (câncer de mama), acompanhamento do teste do pezinho, fila hospitalar, mapa de leitos e integração com a rede suplementar. Também comprometeria a confiança dos municípios no pacto firmado na CIB. Uma retomada futura exigiria refazer cerca de três anos de construção.

Provimento de Pessoal – Concurso Público SES-MG (Edital SES nº 01/2026 – EPGS)

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** Concurso para a carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS), Nível I, Grau A, autorizado pelo COFIN (Of. COFIN nº 0076/2024). O objetivo é recompor a força de trabalho da SES-MG, substituindo contratos temporários por servidores efetivos no Nível Central e nas 28 Unidades Regionais de Saúde (URS).
- **Quantidade realizada: 380 vagas** (342 de ampla concorrência e 38 reservadas a PcD), sendo 228 no Nível Central e 152 nas URS. Foram feitas **167 nomeações (44% das vagas)**:

Onda	Publicação	Nomeações	Nível Central	URS
1ª	14/08/2026	99	46	53
2ª	10/09/2026	68	30	38

Onda	Publicação	Nomeações	Nível Central	URS
Total		**167**	**76 (33%)**	**91 (60%)**

A 3ª onda está em andamento, com cerca de 30 nomeações previstas (13 no Nível Central e 17 nas URS).

- **Valor executado:** R$ 1.231.700,00 (contrato totalmente pago, em três parcelas de R$ 369.525,00, R$ 431.045,00 e R$ 431.130,00).
- **Data de início e fim:** Edital publicado em 16/01/2026; homologação em 03/07/2026; validade até 03/07/2027, prorrogável até 03/07/2028.
- **Status:** Em andamento – concurso homologado e vigente, com nomeações graduais. Os pontos de atenção constam do capítulo 3.
- **Informações Adicionais:**
  - **Vagas temporárias sem cobertura do concurso.** Além das 380 vagas do concurso, existem 92 vagas temporárias autorizadas pelo COFIN (custo anual de cerca de R$ 5,6 milhões, mais parcela do Of. nº 0669/2026). Elas atendem a atividades permanentes, mas não podem ser substituídas pelas vagas homologadas. Para convertê-las em cargos efetivos, a nova gestão pode pedir autorização para acrescentar vagas ao concurso vigente (edital, item 1.6), aproveitando o cadastro de reserva de 3.175 classificados, ou realizar novo concurso.
  - **Pico de vencimentos em 2027**. Entre janeiro e julho de 2027, 190 contratos completam 1 ou 2 anos de vigência. O pico, de 131 contratos, ocorre entre março e maio, perto do fim da validade do concurso.
  - **Ações judiciais.** A classificação PcD da área de Gestão foi retificada por decisão liminar (Processo nº 1095957-91.2026.8.13.0024), e há ações judiciais de servidores nomeados em acompanhamento.
  - **Vagas do Projeto Brumadinho**. As 32 vagas temporárias ligadas ao Comitê Pró-Brumadinho seguem lógica própria e não serão substituídas pelo concurso. São custeadas pelo Acordo Judicial de reparação entre o Estado e a Vale (Fonte 95), não pelo Tesouro, e acompanham projetos com prazo definido, que se encerram entre dezembro de 2026 e dezembro de 2029. A prorrogação dessas vagas está autorizada até agosto de 2027 (Of. COFIN nº 0547/2026).

Novo Decreto de Financiamento e sistema de monitoramento das resoluções

- **Descrição da entrega:**

  O Decreto Estadual nº 49.080, de 01/08/2025, define as regras de transferência, monitoramento, prestação de contas e avaliação dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES). A regulamentação veio pela Resolução SES/MG nº 10.382, de 11/08/2025. As resoluções de financiamento de 2026 já seguem o novo modelo, com repasse condicionado à assinatura do termo de adesão em sistema eletrônico da SES. Seguem abaixo as principais inovações do Decreto:

  Os repasses passam a se organizar em Estratégias de Saúde e Projetos de Saúde.

O instrumento que sela a relação jurídica é o Termo de Adesão, com metas, indicadores, assinatura digital e relatório de gestão. O termo pode ser prorrogado por até 60 meses e rescindido em caso de inadimplência ou inviabilidade. Continuam possíveis contratos, convênios e instrumentos congêneres previstos em legislação específica. A Prestação de Contas das Estratégias de Saúde (políticas contínuas) pelos municípios passa a ocorrer por meio dos RAGs municipais

O repasse de recursos das estratégias se organiza por Blocos de Financiamento, as contas bancárias específicas passam a ser destinadas apenas aos projetos

Dando continuidade à melhoria de repasse dos recursos, foi elaborado o "SES Resolve". É o sistema que substitui o antigo SiGRes (Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde), que estava defasado e lento. Foi desenvolvido pela Prodemge, em colaboração com a Assessoria de Tecnologia e Informação. Tornou-se a plataforma oficial para cadastro, adesão, assinatura digital, monitoramento e prestação de contas das resoluções de financiamento, conforme o Decreto nº 49.080/2025, e ainda está em construção dos últimos módulos.

- **Resultados Alcançados**
  - 515 Resoluções Cadastradas;
  - 17.450 Termos de Adesão assinados;
  - +30 políticas monitoradas;
  - +1500 recursos abertos pelos beneficiários dentro do sistema;
  - 739 reuniões de Comissão Macrorregional realizadas dentro do sistema
- **Valor executado:** Não se aplica.
- **Status:** Decreto - Concluído; Sistema SES Resolve – Em andamento
- **Prejuízo de descontinuidade:** Após a implementação do SESResolve, o SIGRES foi descontinuado para o cadastro de novas resoluções de financiamento e diretrizes de saúde, com todo o fluxo de cadastro, formalização de Termos de Adesão e a totalidade do monitoramento das políticas de saúde da SES sendo realizados dentro do SESResolve. Desta forma, a descontinuidade do sistema poderia gerar a impossibilidade de monitoramento e implementação continuada das estratégias e projetos de saúde elaborados pela SES, incorrendo em descontinuidade dos serviços de saúde financiados pelo estado.

Recomposição da força de trabalho – concurso público, credenciamento e consórcios

- **Nome do órgão/entidade:** FHEMIG
- **Descrição da Entrega:** Diante das dificuldades de contratação de médicos, decorrentes da concorrência com o mercado privado, da menor flexibilidade das regras do serviço público e da escassez de profissionais em algumas especialidades, a Fhemig adotou estratégia combinada para assegurar a continuidade da assistência e manter as escalas em áreas críticas. A estratégia inclui três instrumentos:
  - **Concurso Público – Edital nº 01/2023:** primeiro concurso da Fhemig em mais de 10 anos, destinado à recomposição do quadro efetivo e à redução da dependência de contratos temporários.

  - **Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas:** editais permanentes de chamamento público para credenciar médicos e empresas médicas para plantões e procedimentos, com remuneração por plantão efetivamente prestado, permitindo reposição ágil em áreas como terapia intensiva, clínica médica, cirurgia e oncologia.
  - **Credenciamento de consórcio para gestão de escala:** contratação complementar e subsidiária de consórcio público intermunicipal de saúde para composição de escalas médicas, quando o processo seletivo simplificado e os credenciamentos de pessoas físicas e jurídicas são insuficientes. O parceiro atual é o Instituto de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep).
- **Resultados**
  - **Concurso público:** 1.801 vagas, 5.201 candidatos aprovados, 3.893 nomeações, 2.491 posses, 2.342 candidatos efetivados e cadastro de reserva ativo com 1.308 candidatos. Dos 1.284 médicos nomeados, apenas 670 tomaram posse, demonstrando a dificuldade e a limitação desse formato de recrutamento.
  - **Recomposição das escalas médicas:** realizada em todos os hospitais da Fhemig. No Complexo Hospitalar de Especialidades, desde janeiro de 2023, foram recompostas as escalas de UTI, bloco cirúrgico e ambulatórios, com aumento de consultas, cirurgias e internações.
  - **Hospital Regional de Barbacena:** o consórcio solucionou a falta crônica de anestesistas, reduziu a espera por cirurgias, permitiu a abertura de cirurgias eletivas de quadril, joelho, varizes e hérnia e viabilizou a incorporação da neurocirurgia como nova vocação.
- **Valor executado:** Seguem indicados, por iniciativa:
  - **Concurso público:** sem execução orçamentária própria, pois os custos dos servidores nomeados integram as despesas com pessoal e encargos sociais (Grupo 1) da Fhemig. Despesas de pessoal: R$ 1,249 bilhão em 2023; R$ 1,327 bilhão em 2024; R$ 1,371 bilhão em 2025; e R$ 1,057 bilhão até setembro de 2026.
  - **Credenciamentos e consórcios:** R$ 289.169.186,04 ao longo dos quatro anos em questão.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e recursos SUS, incluindo Valora Minas.
- **Data de início e fim:** Seguem indicados, por iniciativa:
  - **Concurso público:** iniciado em 2023. Prazos finais por categoria:
    - MED – 02/07/2028;
    - AGAS – 29/10/2028;
    - PENF – 08/03/2027;
    - TOS – 16/05/2027.

  Obs.: Os prazos de MED e AGAS já foram prorrogados.
  - **Consórcios:**
    - CHE: 23/12/2025 a 22/12/2026 (aditivo de prazo em andamento).
    - MOV: 25/12/2025 a 24/12/2026 (aditivo de prazo em andamento).

  - CHU: 01/01/2026 a 31/12/2026 (nova contratação em andamento).
  - CHB: 03/02/2026 a 02/02/2027.
  - CHE (2º contrato): 26/03/2026 a 25/03/2027.
  - CHB (2º contrato): 16/09/2026 a 15/09/2027.
- **Status:** Em andamento.

Logística da SES/MG – Projeto Estratégico Logística e Gestão de Insumos

- **Nome do órgão/entidade:** SES/MG
- **Descrição da Entrega:** O Almoxarifado Central da SES-MG, em Contagem/MG, é responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, insumos e equipamentos para as 28 Unidades Regionais de Saúde e os 853 municípios. A operação é própria, com cerca de 90 colaboradores, e o transporte é feito pelos Correios. A estrutura tem dois galpões, com 12.996,51 m² e 10.962 posições de armazenagem, e área refrigerada com antecâmara, câmara fria e câmara de congelados. O almoxarifado atende principalmente a Assistência Farmacêutica, as demandas judiciais (em média, 11 mil pacientes por mês) e a Vigilância em Saúde. São distribuídas em média 160 toneladas por mês, com picos acima de 200 toneladas, para mais de 1.300 pontos de entrega. São mais de 23 mil pedidos por ano, o equivalente a cerca de 330 milhões de unidades farmacêuticas. Em 2025, foram entregues 46.722 volumes termolábeis e 352.210 termoestáveis.

  O Projeto Estratégico Logística e Gestão de Insumos foi criado para corrigir falhas de tempestividade nas entregas, erros de separação, inconsistências de inventário e o esgotamento da capacidade de armazenagem de termolábeis – cujas entradas cresceram 38,6% entre 2023 e 2024, chegando a exigir o uso da câmara fria da FUNED.
- **Quantidade realizada:**

  Diagnóstico da cadeia logística: análise de fluxos, gargalos, recursos e oportunidades de melhoria.

  Mapa de riscos das soluções: avaliação comparativa dos modelos de operação possíveis.

  Implantação do novo modelo de governança logística (em andamento), fase composta por:

  Ampliação da câmara fria (2026/27); Implantação de WMS (sistema), coletores de dados e Circuito Fechado de TV.
- **Valor a ser executado:** Ampliação da câmara fria: cerca de R$ 10,0 milhões (investimento); WMS, coletores de dados e CFTV: cerca de R$ 300 mil de investimento, mais cerca de R$ 1,3 milhão por ano de custeio; postos hierárquicos e reforço de equipe: cerca de R$ 600 mil por ano (custeio); transporte da rede de frio: cerca de R$ 6,1 milhões por ano.
- **Data de início e fim:** O projeto se iniciou em setembro de 2023
- **Status:** Em andamento. O diagnóstico e o mapa de riscos foram concluídos e as melhorias imediatas estão em execução. A contratação do operador logístico integrado está suspensa por decisão da gestão atual, aguardando definição da próxima gestão (ver capítulo 3).

- **Informações Adicionais**

  Está pendente a decisão acerca da contratação de parceiro para implantação de modelo de operação logística integrada para otimização de recursos. A fase de preparação para a contratação foi iniciada (ETP pronto e TR em andamento).

  A ampliação da Câmara Fria é um projeto que envolve a SUBGF e a SUBVS, que consiste em aumentar o espaço de armazenamento de termolábeis no imóvel próprio da SES localizado no bairro Gameleira, e usá-lo para armazenamento de medicamentos e imunobiológicos. Hoje os medicamentos gelados são armazenados no Almoxarifado Central, conforme apresentado. O cronograma do projeto encontra-se em elaboração.

Registro fotográfico do Almoxarifado Central da SES/MG







Figura 1 – Galpão I: armazenagem e separação; Figura 2 – Galpão II: conferência e expedição pelos Correios; Figura 3 – armazenagem de equipamentos médico-hospitalares.

Engenharia da SES – desenvolvimento de projetos padrão para estabelecimentos de saúde

- **Nome da Entrega:** Projetos Padrão em Estrutura de Alvenaria e Estrutura de Light Steel Frame dos estabelecimentos de UBS de Apoio, UBS tipo I e II.
- **Órgão/Entidade**: SES
- **Descrição da entrega**: No âmbito dos repasses financeiros de investimentos para obras de infraestrutura e serviços de engenharia de estabelecimentos de saúde, foram desenvolvidos projetos arquitetônicos padronizados, pela engenharia estadual da SES/MG, a fim de disponibilizar aos proponentes.

  Após a disponibilização destes projetos, observou-se aumento da produtividade da equipe, com maior número de análises realizadas em menor tempo, além de melhoria na qualidade dos objetos construídos, favorecendo a uniformidade e a adequação das soluções arquitetônicas.
- **Status:** está sendo iniciada, via contrato de serviços de engenharia, a elaboração de projetos padrão para os estabelecimentos UBS Tipo III, UPA Tipos I, II e III e CAPS, ampliando os benefícios dessa iniciativa.

Plano de governo

Prontuário eletrônico e sistema de gestão hospitalar (Tasy)

- **Nome do órgão/entidade:** FHEMIG.
- **Descrição da Entrega:** Substituição do antigo sistema SIGH pelo Tasy, sistema integrado de gestão hospitalar com certificação da Sociedade

Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), acompanhada da modernização do parque tecnológico e da rede de dados das unidades. O novo sistema, por intermédio da implantação do prontuário e da prescrição eletrônicos, favorece o fortalecimento da segurança do paciente ao disponibilizar informações clínicas em tempo real para toda a equipe multiprofissional. A rastreabilidade permite controlar materiais e medicamentos desde a compra até a administração ao paciente, aprimorando o controle de estoques e reduzindo perdas. A gestão do fluxo de pacientes envolve o monitoramento dos tempos de espera e a automação de rotinas, como chamada por painel de senhas, solicitação de dietas e higienização de leitos, agilizando o giro de leitos. Além disso, informações padronizadas e integradas entre as unidades alimentam os indicadores institucionais, o faturamento SUS e a codificação DRG, subsidiando a tomada de decisão da alta gestão.

- **Quantidade realizada:** Implantação em 11 hospitais da rede, com renovação do parque tecnológico (computadores, leitores e impressoras) e modernização do cabeamento de rede.
- **Valor executado:** R$ 23,6 milhões (valor contratado do sistema) e R$ 16 milhões (cabeamento estruturado).
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho.
- **Data de início e fim:** Ago/2022 (parametrização na MOV) – jan/2028 (término do contrato).
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento: viradas previstas no HIJPII em nov/2026, no HJXXIII em mar/2027 e na CSSFA em jun/2027.

Marketplace de compras de insumos hospitalares (Projeto Negócio Mineiro)

- **Nome do órgão/entidade:** FHEMIG.
- **Descrição da Entrega:** Iniciativa inédita no governo de Minas Gerais planejada e executada pela Fhemig, com apoio da SEPLAG, e considerada um marco na forma de aquisição de bens na administração pública. O modelo responde aos principais gargalos do registro de preços tradicional: demora entre o planejamento da compra e a chegada do insumo, cerca de 20% de itens desertos ou fracassados e baixa execução das atas. Esses gargalos levavam a compras emergenciais descentralizadas nas unidades e ao risco de desabastecimento. No piloto, aplicado à compra de curativos, o tempo médio entre o planejamento e a entrega do insumo caiu cerca de 90%, de 270 para 29 dias. Além disso, as compras passaram a ser feitas com preços mais próximos aos praticados no mercado, o que também reduz o volume de itens fracassados ou desertos. O novo modelo de compra de materiais hospitalares é baseado nos procedimentos de credenciamento e pré-qualificação (arts. 79, III, e 80 da Lei nº 14.133/2021).
- **Quantidade realizada:** o Marketplace está em operação, com 27 empresas credenciadas para o fornecimento e 192 produtos pré-qualificados e aptos à venda na plataforma. Outros 52 produtos estão em análise técnica, o que deve ampliar em breve o catálogo disponível. Já foram feitos 14 pedidos, referentes a 74 itens do catálogo de curativos, que receberam ao todo 163 propostas. Até então foram aproximadamente 7 mil curativos entregues, com uma média de 6 dias para a chegada dos insumos.
- **Valor executado:** R$517,34 mil.

- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual.
- **Data de início e fim:** 2025 – em andamento (primeira compra em 2026).
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento, com expansão progressiva para outras categorias.

Outras entregas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
SES/MG	Saúde Mental dos Servidores – Política "Mais Vida no Trabalho"	Instituída pela Resolução SES nº 10.337/2025, promove o bem-estar, a segurança no trabalho e a saúde integral dos trabalhadores. Diante de 490 afastamentos por transtornos mentais e comportamentais entre 2020 e 2022 (51% a 59% dos afastamentos), foram contratadas consultas remotas em psicologia e psiquiatria, vigilância de alto risco, assessoria em saúde mental e treinamento para lideranças: 4.200 consultas de psicologia, 720 de psiquiatria e 600 atendimentos pelo canal de suporte psicológico previstos em um ano, por R$ 418.764,00 (vigência de 10/08/2026 a 09/08/2027).	Em andamento.
SES/MG	Núcleo de Economia da Saúde - NES/MG	Institucionalização e operacionalização do Núcleo de Economia da Saúde (NES/MG) com o objetivo de qualificar a gestão dos recursos do Fundo Estadual de Saúde e subsidiar decisões técnicas baseadas em eficiência alocativa. A entrega englobou: Composição de equipe multidisciplinar e formalização da coordenação via resolução; Elaboração do estudo diagnóstico sobre a execução e acúmulo de saldos da Lei Complementar Estadual nº 171/2023 pelos municípios; Benchmarking e articulação federativa junto ao Ministério da Saúde (COREC/DESID), SES-DF, NES/BA e NES/TO, integrando o NES/MG à Rede ECOS; Elaboração e validação da Carta de Serviços da área, estruturada em seis eixos estratégicos de atuação; Desenvolvimento do Diagnóstico de Qualidade dos Dados do ApuraSUS/PNGC, avaliando 172.368 lançamentos em 149 hospitais e 59 UPAs; Construção do Painel de Entregas da SES-MG, promovendo a reclassificação orçamentária contínua das despesas do SIAFI a partir de 2020; Participação intersetorial na Comissão de Farmácia e Terapêutica (NATS) e no Projeto ESPIE/Comitê de Decisão Informada por Evidências.	Concluído e em Operação Continuada

2.11.2. Políticas Públicas

Outras políticas públicas relevantes

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
SES/MG	Movimenta SES	Programa de processos seletivos internos para recolocação de servidores entre subsecretarias e unidades, abrangendo cargos comissionados (DAD), funções gratificadas (FGD) e FGRSA, com requisitos definidos com a área demandante e processos sigilosos. Com a nomeação dos aprovados no concurso EPGS, ganha papel estratégico na redistribuição dos novos servidores e na retenção de talentos, tornando a ocupação de cargos estratégicos mais aderente às necessidades e com critérios objetivos.	55 vagas abertas entre julho de 2025 e outubro de 2026 (21 em 2025 e 34 em 2026).
SES/MG	Fábrica de Softwares	O contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados. O contrato é sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, futuro e eventual. M.I. Montreal Informática S.A.	No âmbito do contrato, foram entregues os MVPs de seis projetos: **Farmácia Digital; Miguilim; AlexSUS; Jud Saúde; SESLegis; Filhos de Minas.** Os demais incrementos desses projetos seguem em desenvolvimento ou planejamento.
SES/MG	IColab	Contratação da prestação de serviços especializados voltados à Inteligência de Dados e ao Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação, com o propósito de contribuir para a modernização, integração e eficiência da gestão pública em saúde	Os produtos estão em diferentes estágios de execução: **Para AGEPROC:** foi prevista uma plataforma de cadastro de processos por upload, com preenchimento automático de campos. **Para a ASJUR:** foi proposto um portal para registro das demandas, ainda sujeito ao detalhamento do fluxo. **Na SJUD, as entregas estão delimitadas em etapas:** Repositório de Preços e a automação do recebimento de processos judiciais pelo SEI e o respectivo cadastro no SIGJUD.

Nome do órgão/entidade	Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
			Capacitação Blockchain: curso voltado a colaboradores da ATI com o objetivo de introduzi-los à principal metodologia utilizada na construção da RMDS, **BB ágil:** criação de uma solução para auxiliar no monitoramento e no controle dos repasses e pagamentos de políticas públicas realizados pelos municípios.
SES/MG	Sustentação e evolução dos sistemas	Fornecimento de créditos e serviços de computação em nuvem pública Microsoft Azure (IaaS/PaaS), abrangendo infraestrutura, hospedagem, processamento, armazenamento e sustentação de sistemas e aplicações da SES-MG Brasoftware Informática Ltda – 9483098/2025	Principais resultados alcançados: implantação e sustentação de ambientes de dados em nuvem (Data Lake e Databricks); estruturação da infraestrutura de integração da Dadoteca / RMDS; **sustentação e evolução do ecossistema do CORE Saúde-MG**; modernização e ampliação de ambientes Kubernetes (AKS); administração e otimização de servidores virtuais (VMs Azure); ampliação da retenção de backups PostgreSQL com réplicas de leitura; implementação de painéis Grafana para monitoramento e observabilidade; gestão de custos (FinOps) com painéis financeiros automatizados; e consolidação da automação de relatórios gerenciais executivos com apoio de inteligência artificial.

2.12. Reparação em Saúde

2.12.1. Rio Doce

- **Descrição da Política Pública:**

  O Programa Especial de Saúde do Rio Doce (PES-RD), instituído pelo Acordo Judicial de Reparação Integral, tem como finalidade recuperar a saúde coletiva nos territórios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

  Sua governança é composta por duas instâncias colegiadas, que se reúnem mensalmente: a Câmara Técnica (CT), de caráter consultivo, responsável pela formulação, planejamento e acompanhamento das propostas de

execução do programa; e o Comitê Especial Tripartite (CET), de caráter deliberativo, responsável pela aprovação das propostas oriundas da CT.

Para viabilizar a aplicação dos recursos de execução imediata previstos no Acordo, foram aprovados Planos de Ação em Saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal, com a anuência dos respectivos Conselhos de Saúde. Esses planos constituem os principais instrumentos de planejamento e detalhamento da aplicação dos recursos, observadas as diretrizes da Resolução CET nº 3/2025, cabendo à governança do PES-RD sua aprovação e o monitoramento da execução.

Nesse contexto, a SES/MG elaborou o Plano de Ação Estadual, fundamentado em dados territoriais, epidemiológicos e de infraestrutura em saúde, com o objetivo de integrar as ações estaduais e municipais.

Outro ponto pendente de definição pela governança refere-se à destinação dos rendimentos do fundo perpétuo, cuja competência para estabelecer os valores e os entes beneficiários cabe às instâncias do PES-RD. Este ponto carece de discussão na instância, principalmente em razão da divergência de interpretação entre a União e o Estado de Minas Gerais quanto à integralização dos recursos, questão que se encontra sob análise do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

- **Resultados alcançados:** Destacam-se a estruturação da governança do PES-RD, a aprovação do Plano de Ação Estadual referente ao primeiro repasse e a realização de levantamentos territoriais e reuniões técnicas para subsidiar o planejamento das ações. Também se destaca o início do monitoramento da qualidade da água pela Funasa, em 173 pontos distribuídos por 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.
- **Valor executado:** O acordo prevê R$ 12 bilhões para ações de compensação dos danos à saúde coletiva, dos quais R$ 3,6 bilhões se destinam à execução imediata pelos entes federados. Desse montante, R$ 424 milhões estão previstos para ações sob responsabilidade de Minas Gerais. O Plano de Ação Estadual referente ao primeiro repasse contempla R$ 220.162.500,00, enquanto R$ 8,4 bilhões estão previstos para um fundo patrimonial perpétuo.

  Dos R$ 220.162.500,00, R$ 70.847.450,34 já foram pagos, R$ 83.097.406,66 estão em processo de pagamento, já empenhados, restando R$ 66.217.643,00 que estão em fase de celebração.
- **Prejuízo da descontinuidade:** A descontinuidade pode comprometer a implementação das ações de reparação, a articulação entre os entes federativos e o atendimento às necessidades de saúde da população atingida. Também pode prejudicar a aplicação dos recursos e a execução dos planos aprovados.

  No monitoramento da qualidade da água, eventuais lacunas na transição de responsabilidades podem comprometer a continuidade das análises e a identificação de riscos sanitários. A indefinição sobre a integralização dos recursos do fundo patrimonial também representa um fator de incerteza para o financiamento de longo prazo.

2.12.2. Paraopeba

- **Descrição da Política Pública:**

O Acordo Judicial de Reparação Integral (AJRI), firmado em 2021, tem como objetivo reparar os danos coletivos e difusos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho. Com valor global de R$ 37,69 bilhões, contempla ações no município de Brumadinho, em outros 25 municípios atingidos e iniciativas voltadas à melhoria dos serviços públicos estaduais.

A governança do Acordo é exercida pelos quatro Compromitentes: Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), responsáveis pelas deliberações sobre as iniciativas de reparação, observadas as regras e os instrumentos de governança aplicáveis a cada frente do Acordo. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) exerce a função de Secretaria Executiva do Acordo, apoiando a articulação institucional, a organização de reuniões e pautas, a formalização das decisões e o acompanhamento das iniciativas.

No âmbito da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) atua como órgão técnico setorial, acompanhando projetos voltados ao fortalecimento da assistência à saúde, à melhoria da infraestrutura hospitalar, à vigilância em saúde, ao monitoramento da qualidade da água e à avaliação de riscos à saúde humana e ao meio ambiente, além das iniciativas relacionadas à Biofábrica Wolbachia.

Compete à SES/MG contribuir para a concepção e o aprimoramento das iniciativas, bem como realizar a análise e a validação técnica dos Planos de Trabalho apresentados pelos municípios, conforme os fluxos estabelecidos. Essa atuação busca assegurar o alinhamento das propostas às políticas públicas de saúde e às necessidades dos territórios atingidos, respeitando as competências deliberativas dos Compromitentes e as atribuições dos responsáveis pela governança e execução dos projetos.

- **Resultados alcançados:** Entre os principais resultados alcançados na área da saúde, destacam-se as iniciativas de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), conclusão de obras e equipagem de hospitais regionais, além de reforma e aquisição de hospitais da rede Fhemig. Também houve avanços no cronograma dos estudos de avaliação de riscos à saúde humana.

  No âmbito do controle das arboviroses, destacam-se a inauguração da Biofábrica Wolbachia, em Belo Horizonte, e o início da soltura de mosquitos com Wolbachia (wolbitos) nos municípios de Brumadinho, Mário Campos e Betim. Adicionalmente, há a estruturação do novo Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (HoPE), que contempla um complexo hospitalar estadual e um novo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) da FUNED, com serviços essenciais de vigilância epidemiológica.

- **Valor executado:** O AJRI possui valor global de R$ 37.689.767.329,00, destinado a diferentes eixos de reparação socioeconômica, socioambiental e de fortalecimento dos serviços públicos, incluindo iniciativas na área da saúde.

No que se refere à execução de recursos destinados às ações de saúde, destacam-se os valores apresentados a seguir, cuja execução ainda não foi integralmente concluída[1]:

Anexo I.3 (Bacia do Paraopeba): R$ 154.380.234,00;

Anexo I.4 (Brumadinho): R$ 293.246.514,31;

Anexo IV (Fortalecimento dos serviços públicos):

Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Sete Lagoas; do Hospital Regional de Teófilo Otoni; do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete; e do Hospital Regional de Divinópolis: R$ 683.419.625,05;

Conclusão de obra e Equipagem de Hospitais Regionais (Reserva Técnica): R$ 112.639.418,95;

Obras de reforma e aquisição de equipamentos para hospitais da Rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). As unidades contempladas são: Hospital Infantil João Paulo II; Hospital João XXIII; Hospital Júlia Kubitschek; Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo; Maternidade Odete Valadares; Hospital Eduardo de Menezes; Instituto Raul Soares; e Hospital Alberto Cavalcanti: em definição

Cláusula 4.4.9 (Biofábrica Wolbachia e FUNED/HoPE): R$ 135.000.000,00

- **Prejuízo da descontinuidade:** Entre os principais riscos, destacam-se a interrupção de iniciativas de fortalecimento da rede assistencial e de atenção psicossocial, atrasos na execução de obras e na estruturação de unidades hospitalares, além de prejuízos ao monitoramento da qualidade da água e à avaliação dos riscos à saúde humana.

  Também merece atenção a continuidade das ações da Biofábrica Wolbachia, essenciais à estratégia de controle das arboviroses, bem como o acompanhamento da implantação do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (HoPE). A manutenção da articulação institucional, do acompanhamento técnico e do monitoramento dos projetos é fundamental para assegurar o cumprimento dos compromissos estabelecidos no Acordo e a efetiva aplicação dos recursos destinados à reparação.

3. Pontos de Atenção no fechamento de Governo

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para implantação
SES/MG	Provimento de pessoal – Concurso EPGS (Edital SES nº 01/2026)	**Vagas homologadas:** 380 vagas (228 no Nível Central e 152 nas 28 URS; 342 de ampla concorrência e 38 PcD), autorizadas pelo Of. COFIN nº 0076/2024. Homologação em 03/07/2026; validade até 03/07/2027, prorrogável até 03/07/2028. **Total nomeado:** 167 nomeações (44% das vagas) – 1ª onda (14/08/2026): 99; 2ª onda (10/09/2026): 68 –, sendo 76 no Nível Central (33%) e 91 nas URS (60%).	05/01/2027 (fim da vedação eleitoral), com nomeações mensais até lá

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para implantação
		Próximas ondas: 3ª onda em andamento, com cerca de 30 nomeações (13 no Nível Central e 17 nas URS), e ondas de novembro, dezembro e janeiro com mais 14 – cerca de 211 nomeações até a posse, restando cerca de 169 vagas. As nomeações seguem em levas mensais, acompanhando o vencimento dos contratos, e são permitidas no período eleitoral porque o concurso foi homologado antes da vedação. **Saldo entre o déficit dos PSS e as vagas autorizadas:** até 05/01/2027, os contratos que completam 1 ano não podem ser prorrogados e os que completam 2 anos se encerram, sem convocação do PSS. Entre janeiro e julho de 2027, 190 contratos completam 1 ou 2 anos (pico de 131 entre março e maio). Frente às cerca de 169 vagas remanescentes, o saldo é de aproximadamente 21 contratos sem vaga efetiva correspondente. Além disso, 92 vagas temporárias autorizadas pelo COFIN (custo anual de cerca de R$ 5,6 milhões, mais parcela do Of. nº 0669/2026) atendem a atividades permanentes sem correspondência em cargo efetivo; podem ser convertidas por acréscimo de vagas ao concurso (edital, item 1.6), aproveitando o cadastro de reserva de 3.175 classificados, ou por novo concurso. **Observação – PSS Brumadinho:** as 32 vagas temporárias do Comitê Pró-Brumadinho seguem lógica distinta e não entram na conversão: são custeadas pelo Acordo Judicial com a Vale (Fonte 95), e não pelo Tesouro, e acompanham projetos que se encerram entre dez/2026 e dez/2029; prorrogação autorizada até ago/2027 (Of. COFIN nº 0547/2026). Há, ainda, retificação liminar da classificação PcD da área de Gestão (Processo nº 1095957-91.2026.8.13.0024) e ações judiciais de servidores nomeados em acompanhamento.	
SES/MG	Logística – contrato de transporte e decisão sobre o modelo de operação	**Situação contratual:** a execução dos serviços de transporte e distribuição pelos Correios está amparada por decisão judicial liminar (SEI nº 1320.01.0182665/2025-93), necessária para assegurar a continuidade enquanto não se conclui a contratação do operador logístico integrado. Está em finalização novo contrato de transporte com os Correios, com assinatura prevista para outubro de 2026, regularizando a situação.	31/10/2026 (assinatura do novo contrato de transporte) 31/03/2026 (Decisão de publicação do edital de logística integrada)
SES/MG	Hospitais Regionais – obras e gestão (Sete Lagoas, Governador Valadares e	**Governador Valadares:** obra com previsão contratual em 31/10/2026 (verificar negociações com a SEINFRA); homologação da Concorrência para assinatura com entidade gestora depende de dois processos judiciais, incluindo ação popular. **Teófilo Otoni:** saldo de cerca de R$ 10 milhões da equipagem aguardando solicitação formal pelo IMP, em convênio mediado pelo TCE/MG, com	Prazo contratual em revisão

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para implantação
	Teófilo Otoni)	acompanhamento complementar à prestação de contas do Acordo de Brumadinho.	
SES/MG	Cessão de servidores	A SES/MG possui 166 servidores cedidos a órgãos do Grupo Saúde (10 à ESP-MG, 34 à FHEMIG, 26 à FUNED e 96 à HEMOMINAS) e 39 cedidos a outros órgãos; as cessões vigoram até 31 de dezembro, sendo necessária autorização para prorrogação no exercício seguinte. A SES/MG conta, ainda, com 135 servidores cedidos por outros órgãos, cuja permanência é necessária – em especial os médicos cedidos que atuam como autoridade sanitária na CORE-MG. Não há data pactuada, mas é preciso acompanhar a vigência das cessões.	31/12/2026 (cessões da SES); acompanhamento contínuo (cessões para a SES)
SES/MG	Filhos de Minas	O projeto conta com 667 municípios aderentes; dos 543 com contratos formalizados com a empresa fornecedora, 283 registraram a entrega de ao menos um kit e 41 concluíram a distribuição. Os municípios pendentes têm até 31/12/2026 para concluir as entregas. É necessário avaliar a continuidade do programa para providenciar nova Ata de Registro de Preços e Resolução com repasse de recursos.	31/12/2026
SES/MG	Regulação eletiva em Medicina Fetal e Doenças Raras	Monitoramento e evolução dos fluxos de acesso: na rede de Doenças Raras, recém-instituída, garantir o uso adequado dos recursos; na Medicina Fetal, monitorar o acesso à cirurgia intrauterina e implantar a regulação estadual dos partos de crianças com cardiopatias críticas.	30/11/2026

4. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
SES/MG e vinculadas	Pagamento e execução de Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO)	Pagamento e execução de Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO). Relação completa na planilha: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	Checar planilha
SES/MG e vinculadas	Pagamento e execução de convênios	Pagamento e execução de convênios com vencimento, renovação ou parcelas previstas 2027. Relação completa na planilha: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	Checar planilha

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
SES/MG e vinculadas	Pagamento e execução de contratos	Pagamento e execução de contratos com vencimento, renovação ou parcelas previstas para o início de 2027. Relação completa na planilha: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	Checar planilha
SES/MG e vinculadas	Pagamento e execução de resoluções	Pagamento e execução de resoluções com vencimento, renovação ou parcelas previstas para o início de 2027. Relação completa na planilha: [SAÚDE] Contratos, Resoluções, TDCOs e Convênios vigentes e em tramitação Para além da disponibilidade orçamentária, **o pagamento tempestivo das resoluções depende** da continuidade no desenvolvimento **do sistema de monitoramento SES Resolve. S**em ele o pagamento e a prestação de contas se tornam inviáveis. **Assim é fundamental a renovação do contrato de desenvolvimento. Até janeiro precisam ser entregues os módulos de**: Prestação de Contas de Estratégias de Saúde; Monitoramento de Projetos de Saúde (ambos com previsão de entrega no 1° trimestre de 2027); Formas de Cadastro alternativas para resoluções que pagam por procedimentos executados e eixos; Pós-Monitoramento; Módulo de Integração com o BB Ágil; Prestação de Contas de Projetos de Saúde; Relatórios; Controle Interno e Externo; Transparência e Termos de Doação e Cessão.	01/2027
SES/MG	Modelo integrado de operação logística	**Decisão pendente para a nova gestão** (SEI nº 1320.01.0047800/2025-68): Contratação de operador de logística integrada. A partir de Estudo Técnico Preliminar e de discussões técnicas, observou-se que a efetividade da operação logística seria incrementada com a adoção de um modelo integrado operado por terceiro. Por isso, foi elaborado ETP e Termo de Referência, ficando a cargo da nova gestão a decisão de publicar ou não o edital, findado o período eleitoral.	03/2027
SES/MG	Hospitais Regionais de Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas – custeio inicial	Após o recebimento do Plano de Escalonamento e do ofício do município sede com a previsão de abertura, calcular o custeio e publicar resolução específica, com pagamento antecipado dos valores do primeiro quadrimestre.	01/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
SES/MG	Hospital Regional de Teófilo Otoni	Pagamento da resolução de custeio n º 10.908 de 10 de fevereiro de 2026 que garante repasse de recursos e que deve ser pago em janeiro de 2027. Execução e pagamento de convênio para compra de equipamentos realizado com a mediação do TCE/MG e, portanto, exige o acompanhamento do processo de compras e fiscalização da aplicação de recurso em sistemática complementar ao processo de prestação de contas dos recursos advindos do Acordo de Brumadinho. Checar planilha completa: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	02/2027
SES/MG	Financiamento do SAMU 192	Custeio do SAMU regional e municipal em 2027, com aumento previsto em razão da ampliação da frota (USA, USB e motolâncias) e de novas habilitações; a LOA 2027 prevê R$ 496.345.391,00 em fonte estadual e R$ 192.210.077,00 em fonte federal. Checar planilha completa: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5 .	31/01/2027
SES/MG	CORE-MG – serviço médico auxiliar	Custeio do serviço médico auxiliar mediante contrato com consórcio público, com planejamento e dimensionamento contínuo da força de trabalho, acompanhamento de escalas e produtividade e garantia do repasse mensal ao consórcio. Checar planilha completa: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	31/01/2027
SES/MG	CORE Saúde MG – manutenção e evolução da ferramenta	Evolução da plataforma, incluindo implantação e aprimoramento dos módulos de transporte, acesso ao cidadão, acesso eletivo hospitalar e acesso ambulatorial, preservando os investimentos realizados e a operação regulatória.	31/01/2027
SES/MG	Rede credenciada e compra de leitos	Aquisição excepcional e complementar de leitos (**Edital de Credenciamento nº 01/2025**), com agilidade entre regulação, revisão, pagamento e orçamento, acompanhamento dos valores comprometidos, faturados e pagos e cumprimento dos prazos contratuais de repasse aos prestadores. Checar planilha completa de contratos. https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/Acompanha	31/01/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
		mentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	
SES/MG	Mudança de prédio da CORE MG	Localização de nova sede para instalação da Central de Operações para Regulação Estadual (CORE/MG), para aprimoramento das condições estruturais e operacionais para o funcionamento da regulação estadual. O processo se dará por meio de formalização da contratação por inexigibilidade de licitação. Necessário prosseguir com o processo em questão.	31/03/2027
SES/MG	Recebimento de Ambulâncias do SAMU	Doação de veículos pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), seguida do repasse via Termo de Cessão aos consórcios beneficiários, sejam eles vinculados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou consórcios de saúde, envolve fatores que contribuem para o prolongamento do tempo de tramitação dos processos, destacando-se: cumprimento do fluxo administrativo; recebimento dos veículos; demora no envio de documentos; necessidade de emplacamento prévio; ausência de minuta padrão de termo de cessão de uso.	31/03/2027
SES/MG	Veículos da estratégia Caminhos da Saúde (Ministério da Saúde)	Recebimento, conferência, incorporação, entrega e cessão de vans, microônibus e ambulâncias tipo A da estratégia Caminhos da Saúde, do Ministério da Saúde, para composição de frota do transporte regional, organizada pelos consórcios intermunicipais de saúde. Até 14 de outubro de 2026, já chegaram 32 microônibus (do total de 32 pactuados), 9 ambulâncias tipo A (do total de 16 pactuadas) e 95 vans (do total de 123 pactuadas), havendo processos de conferência e cessão em tramitação, com necessidade de acompanhamento contínuo.	31/03/2027
SES/MG	Manutenção do SIGAF e renovação do contrato.	O sistema SIGAF operacionaliza a Assistência Farmacêutica em todo o Estado (853 municípios, 28 Regionais, SAF, Almoxarifado Central e Vigilância Sanitária; cerca de 5.000 estabelecimentos e 87 mil dispensações por dia). O contrato de desenvolvimento (INF 4242) vigora até 15/01/2027, **sendo necessário concluir a contratação sucessora (INF 5410); o de hospedagem (INF 4991) vence em 13/02/2027.**	15/01/2027 (contrato de desenvolvimento); 13/02/2027 (hospedagem)

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
SES/MG	Período sazonal de arboviroses e SRAG	**Financiamento da estratégia de enfrentamento às emergências em saúde pública, continuidade do pagamento da Resolução SES/MG nº 10.600/2025,** preparação e resposta a arboviroses, vírus respiratórios e outras doenças transmissíveis, especialmente, considerando a possível influência do El Niño no período sazonal de 2027, para os 853 municípios. **Arboviroses: continuidade do monitoramento dos planos** e indicadores, manutenção dos drones e equipamentos, UBV descentralizado pelos CIS, monitoramento da resistência dos vetores aos inseticidas e outras estratégias como a Wolbachia, ovitrampas e Estações Disseminadoras de Larvicidas. **Vigilância de Síndrome Gripal:** manutenção do financiamento (VigiMinas) das 34 unidades sentinelas, com coleta semanal de 10 amostras. **Checar planilha completa de resoluções.** https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	28/02/2027 preparação prévia ao período sazonal de 2027
SES/MG	Abertura de leitos clínicos para SRAG	Necessária publicação de resolução em CIB com as diretrizes para abertura e ampliação de leitos clínicos de SRAG no período sazonal. O trâmite envolve alinhamento entre CGPAH, CGCIH e Vigilância, minuta, pactuação na CIB-SUS/MG e divulgação às Regionais	02/2027
SES/MG	Desinstitucionalização – Clínica de Alfenas	Em Alfenas, a SES/MG conduz a desinstitucionalização de 130 pacientes de clínica investigada por graves violações de direitos humanos, sob acompanhamento do Ministério Público. É fundamental fortalecer e garantir a continuidade da EAP-Desinst.	03/2027
SES/MG	Provimento de pessoal – retomada das nomeações após a vedação eleitoral	Com a posse do governador eleito, a Administração poderá voltar a encerrar contratos temporários para nomear concursados e reavaliar o ritmo de provimento das vagas restantes. Entre março e maio de 2027, 131 contratos atingem marcos de vigência. Avaliar com antecedência a prorrogação da validade do concurso (03/07/2027) e o pedido de acréscimo de vagas à COFIN (edital, item 1.6). Destacamos que o acréscimo de vagas para substituição de contratos temporários, para além das já autorizadas pela COFIN, é fundamental pois os servidores concursados garantem a continuidade dos processos, maior segurança	05/01/2027 (retomada)

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
		jurídica e redução de procedimentos administrativos recorrentes.	
SES/MG	Emendas parlamentares impositivas – portfólio	As emendas parlamentares impositivas são de execução obrigatória e envolvem, ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os municípios e a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). A SEGOV disciplina todo o rito e os prazos de execução. **Para o primeiro trimestre é necessário: Concluir, pactuar em CIB e divulgar o portfólio de ações elegíveis para emendas antes da abertura da primeira janela de indicações.** Após, é necessário realizar a disponibilização e divulgação do portfólio aos parlamentares em painel online e realizar atendimento às equipes parlamentares. Destacamos que a Saúde tem, obrigatoriamente, 50% das emendas estaduais, por isso as dúvidas são recorrentes, razão pela qual se sugere a organização supramencionada.	Fevereiro/2027 (se mantido o calendário de 2026)
SES/MG / CES	11ª Conferência Estadual de Saúde	Prevista para 04 a 08 de abril de 2027, com estrutura para 3.000 participantes (Centerminas ou Expominas). É condição predecessora do Plano Estadual de Saúde (Lei Federal nº 8.142/1990). O orçamento está previsto apenas para 2027, sendo necessário reservar e pagar o local assim que o orçamento for aberto.	01/02/2027
SES/MG	Rede Mineira de Dados em Saúde – execução e orçamento de 2027	O Contrato nº 9499216/2026 (BS Suporte Técnico – Isis Saúde) vigora até março de 2031; o risco está na continuidade da execução, que sustenta a caderneta digital de vacinação, o histórico de mamografias e integrações da Regulação e da Assistência Farmacêutica. É preciso assegurar dotação no orçamento de 2027, pagar as faturas da virada do exercício e emitir as ordens de serviço do primeiro trimestre (R$ 4,29 milhões já registrados), nomear o Comitê Estratégico da RMDS (Resolução nº 11.569/2026) e dar continuidade à adesão dos municípios.	31/03/2027
SES/MG	Farmácia Digital – incrementos	É fundamental continuar com o desenvolvimento e a manutenção do sistema de peticionamento de medicamentos. **Até o primeiro trimestre precisa ser entregue o Incremento** 4 (8 sprints, de 01/12/2026 a 31/03/2027): **visão centralizada do paciente, incorporação das solicitações físicas e IA na conferência documental.**	31/03/2027
SES/MG	TeleMaisSaúde MG – credenciamento	Contratação dos núcleos credenciados pelo Edital nº 2/2026, implantação da metodologia e gestão, fiscalização, monitoramento e pagamento conforme o cronograma, para	28/02/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
	dos Núcleos de Telessaúde	manter a teleconsultoria assíncrona da APS e da AAE sem interrupção. Caso a contratação não seja finalizada haverá descontinuidade do serviço nos territórios, com consequente aumento das filas de eletivas e ambulatoriais.	
SES/MG	VISA Digital – Sistemas de vigilância sanitária estadual e municipal	**VISA Digital Estadual** (alvarás sanitários e projetos arquitetônicos de competência estadual; R$ 3.012.793,34/ano, Tesouro): pagamento das faturas de dez/2026 a mar/2027 dos Contratos nº 9389678/2023 (hospedagem), nº 9275811/2021 (desenvolvimento) e nº 9285266/2021 (hospedagem PROECM). **Conclusão dos novos contratos de desenvolvimento/Seg.ID (SEI 5140.01.0001007/2026-35) e de hospedagem (SEI 5140.01.0001067/2026-64)**. **VISA Digital Municípios** (licenciamento sanitário municipal; mais de 500 municípios aderidos, piloto em Contagem, Betim, Curvelo e Uberaba; R$ 2.763.544,90/ano, recurso federal): pagamento dos serviços de jan e fev/2027 do Contrato nº 9480791/2025 (SBAR) e início da expansão em 2027. Vale destacar que os sistemas estão diretamente relacionados à avaliação de projetos arquitetônicos e concessão de alvarás, condições determinantes para as metas de ajuda de custos dos servidores. CHECAR PLANILHA COMPLETA DE CONTRATOS: https://saudemg.sharepoint.com/:f:/s/AcompanhamentoAEST/IgBf22oGC-grRrl67LsDMw5XAY2GgWsdIzZe3dr6CJtCsuk?e=YAdjc5	31/01/2027 (novos contratos);
SES/MG	VISA-CIS – avaliação e 3º ciclo	Avaliação do Programa VISA-CIS para subsidiar sua institucionalização como política permanente e publicação de Resolução para o repasse referente ao 3º ciclo de execução.	31/03/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
SES/MG	Sustentabilidade do Transporta SUS-MG e Manual do TFD	Manutenção do custeio da Resolução SES/MG nº 11.015/2026, monitoramento dos sistemas regionais, acompanhamento da produção no SIA/SUS e articulação com consórcios, municípios e Unidades Regionais. Abrangência: consórcios executores e municípios integrantes dos Sistemas Regionais contemplados pela política. Causa da urgência: consolidação dos Sistemas Regionais e do custeio previsto na Resolução SES/MG nº 11.015/2026 exige previsibilidade orçamentária. A redução ou interrupção do cofinanciamento pode comprometer a operação dos sistemas já estruturados. Continuidade da implementação das novas diretrizes estaduais de TFD, especialmente quanto à organização dos fluxos, implantação das Comissões Municipais e elaboração dos Manuais Municipais.	31/01/2027
SES/MG	Judicialização – sistemas de informação	Continuidade do Portal SJUD, do SIGJUD e da implementação do e-SUS AF; e execução dos 14 projetos e produtos do Programa Estadual de Desjudicialização da Saúde, com prioridades, responsáveis, prazos e monitoramento.	Contínuo
SES/MG	Implementação do Programa Estadual da Desjudicialização da Saúde	Assegurar a continuidade e a execução dos 14 projetos e produtos do Programa Estadual de Desjudicialização da Saúde, com definição de prioridades, responsáveis, prazos e monitoramento dos resultados, de modo a fortalecer as estratégias de solução pré-judicial de demandas, a prevenção de litígios e a integração com o Sistema de Justiça.	Contínuo
SES/MG	Cooperação com a OPAS – Promoção da Saúde	Dotação, empenho e pagamento da parcela de 2027 (R$ 2.608.382,70) do 1º Termo de Ajuste ao 168º Termo de Cooperação Técnica; sem o pagamento, a execução dos Anexos I, II e III do Plano de Trabalho é interrompida.	03/2027
SES/MG	Campanhas do 1º trimestre	As campanhas planejadas para o primeiro trimestre de 2027 são: 1) Combate à dengue e cuidados de prevenção 2) Prevenção de doenças respiratórias 3) Prevenção de ISTs. Esta última, com prazo em 01/2027, antes do carnaval.	03/2027
SES/MG	Relatório de prestação de contas	A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) deverá realizar, nos primeiros meses de 2027, a consolidação, análise e apresentação das Prestações de Contas Anuais referentes ao exercício financeiro de 2026, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). A prestação de contas constitui obrigação dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, abrangendo	03/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
		informações sobre a execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, bem como os resultados da gestão e a aplicação dos recursos públicos. O procedimento é regulamentado pela Instrução Normativa TCEMG nº 14/2011 e pelas decisões normativas editadas anualmente pelo Tribunal, que estabelecem a documentação exigida	
SES/MG	Relatórios de Gestão do SUS	Elaboração do 3°RDQA 2026 e do RAG 2026, conforme LC n°141/2012	02/2027
SES/MG	Alteração dos cadastros dos gestores	A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) deverá providenciar a atualização dos cadastros, perfis de acesso e certificados digitais vinculados ao Secretário de Estado de Saúde e aos demais gestores responsáveis. Destaca-se a necessidade de providenciar, na primeira quinzena de janeiro de 2027, o token de acesso ao sistema de envio de documentos fiscais de pessoal, de responsabilidade do setor de Contabilidade, cuja utilização poderá ser descentralizada ao Chefe de Gabinete ou ao Secretário Adjunto. A atualização compreende: Certificados digitais SES/FES (A1 e A3): Certificados físicos da SES-MG e do Fundo Estadual de Saúde (FES), certificado digital CNPJ e token CPF. Sistemas institucionais: SISAD, SCPA, Transferegov, InvestSUS, SIAPLE, e-TCE, SGI, Sistema e-Aud, Sistema COMPOR (assinatura de Termo de Acordo) e InovaAF. Cadastros de usuários externos no SEI: Ministério da Saúde, Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Governo do Distrito Federal, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).	01/2027
SES/MG	Processos de Tomada de Contas Especial	A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) deve assegurar o acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especial (TCE), destinados à apuração de irregularidades, identificação dos responsáveis e quantificação de eventuais danos ao erário, visando ao ressarcimento dos recursos públicos. O procedimento é regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 102/2008, pelo Decreto Estadual nº 46.830/2015 e pelas normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), observadas as orientações do Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial	03/2027

Nome do órgão/ entidade	Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação
		da Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG). Considerando a transição governamental, será necessário assegurar a continuidade dos processos de Tomada de Contas Especial em andamento, observando os prazos legais para sua instrução e conclusão.	
SES/MG	Ampliação da Câmara Fria da Rede de Frio	No momento, encontram-se em desenvolvimento o Plano de Ação e cronograma para início da execução das obras para ampliação da Câmara Fria da SES. Hoje temos um espaço na Gameleira voltado para os imunobiológicos, e os medicamentos termolábeis ficam no Almoxarifado Central, imóvel alugado. Em janeiro prevemos que a contratação da obra esteja em fase final de instrução da licitação para permitir que a execução seja feita. As macroetapas consistem em: planejamento > projeto arquitetônico > contratação da obra > obra > compra de equipamentos > movimentação dos medicamentos do almoxarifado > realocação da equipe.	01/2027

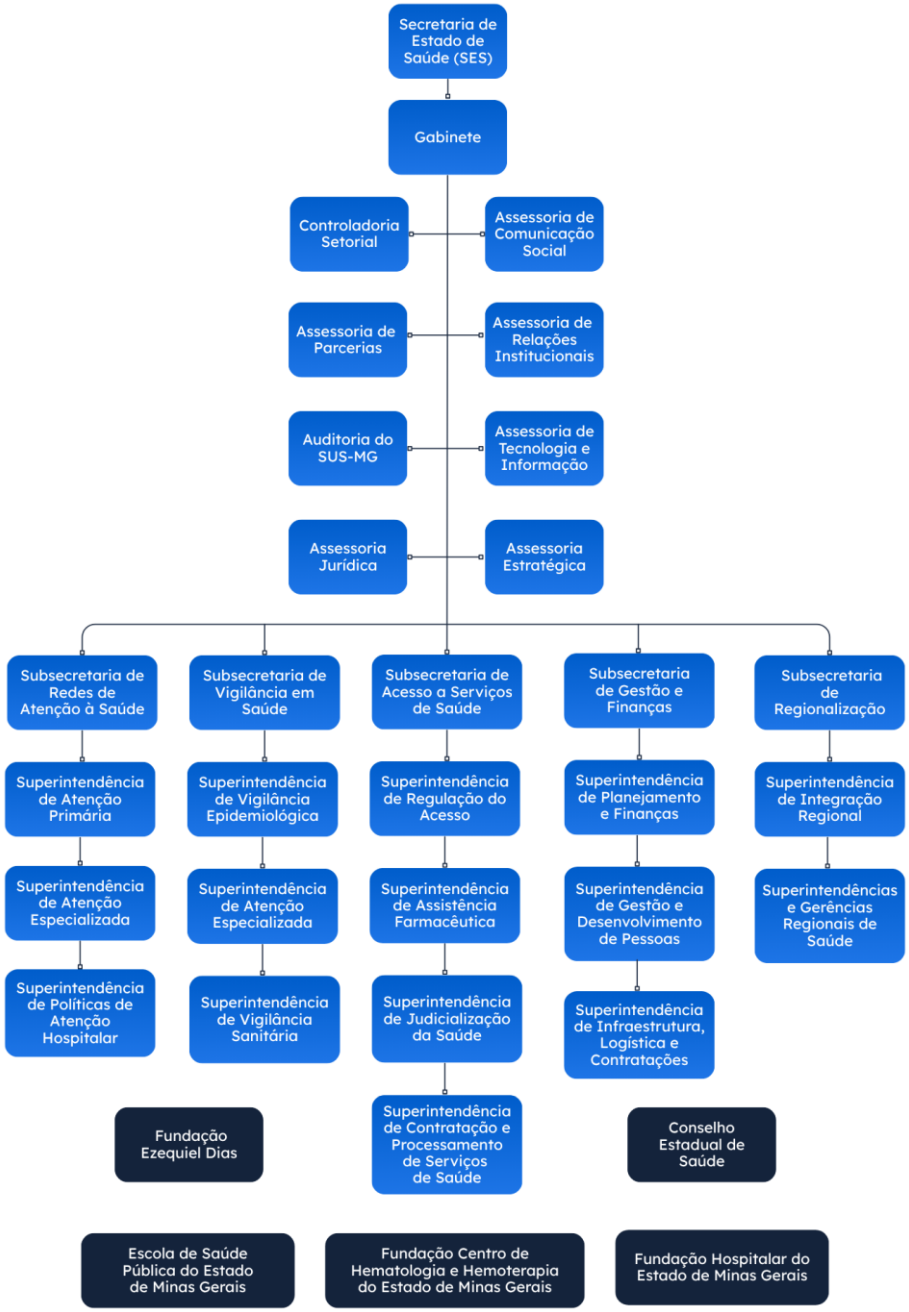
ANEXO I

5. Competências da Secretaria

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), nos termos da Lei nº 24.313/2023, tem como competência formular, regular e fomentar as políticas de saúde pública no Estado, de forma regional e descentralizada, em cooperação com os demais entes federados na prevenção, promoção, preservação e recuperação da saúde da população; gerenciar, coordenar, controlar e avaliar as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado; promover a qualificação dos profissionais do SUS, por meio de pesquisas e atividades de educação em saúde; promover e coordenar a regionalização e a descentralização dos serviços e ações de saúde; e coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, nutricional e de saúde do trabalhador.

Decreto de competências (ALMG): https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48661/2023/original

6. Organograma da Secretaria



Em azul claro observa-se a estrutura formal da Secretaria de Estado de Saúde. Em azul escuro é apresentada a lista de instituições vinculadas. Destacamos que o organograma detalhado delas encontra-se em anexo.

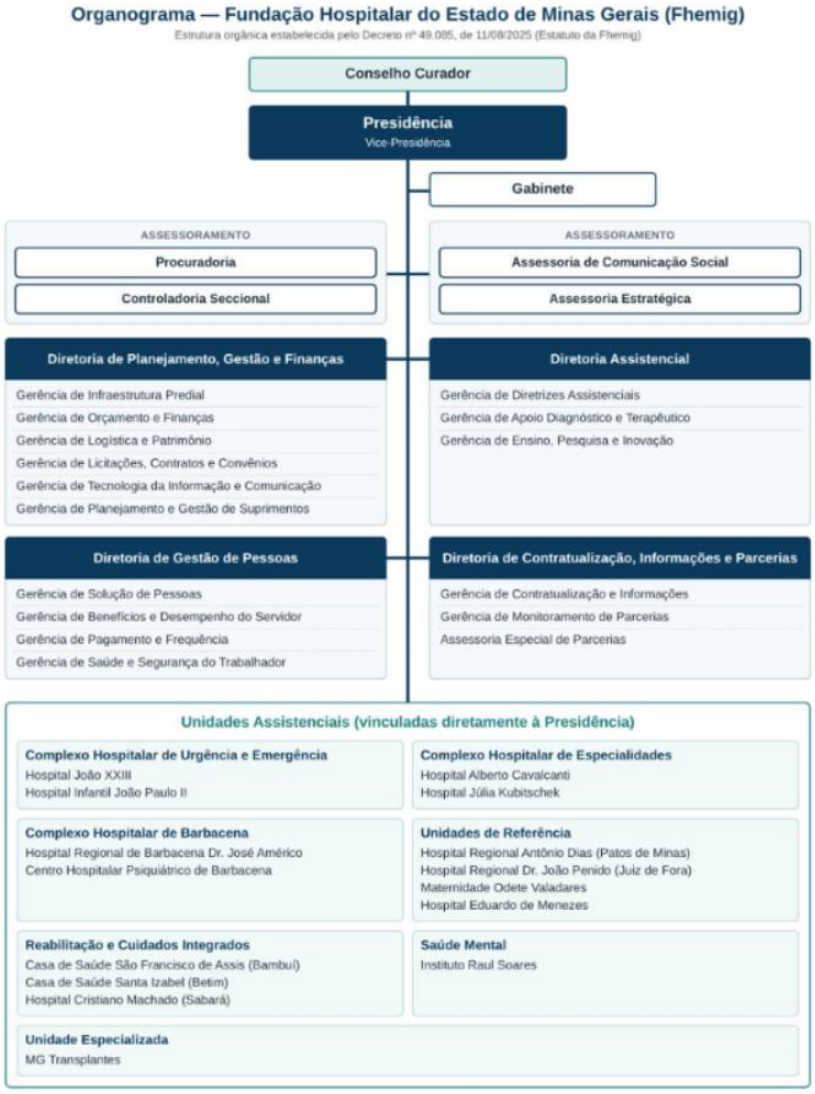
ANEXO II
RELATÓRIO DE GESTÃO – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

7. Competências da Vinculada

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), criada pela Lei nº 7.088/1977 e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), tem como competência prestar serviços de saúde de média e alta complexidade por meio de seus 14 hospitais que estão integrados à rede SUS. Também cabe à Fhemig coordenar o Sistema Estadual de Transplantes, por meio do MG Transplantes, composto por uma central e 07 OPOs (Organização de Procura de Órgãos). A Fhemig é, também, um importante centro formador de profissionais de saúde com 579 vagas de residência médica e 144 multiprofissional, além de estágios. A rede soma 1.708 leitos, dos quais 237 de CTI, além de 31 salas cirúrgicas e mais de 12 mil profissionais.

Decreto nº 49.085, de 11/08/2025 (Estatuto da Fhemig): https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/49085/2025

8. Organograma da Vinculada



Unidades assistenciais – localização e perfil

As unidades assistenciais que compõem a estrutura apresentada no organograma estão distribuídas em sete municípios mineiros – Belo Horizonte, Barbacena, Patos de Minas, Juiz de Fora, Sabará, Betim e Bambuí – e organizadas em complexos hospitalares e unidades de referência, conforme o perfil de atendimento de cada uma:

- **Hospital João XXIII – HJXXIII (Belo Horizonte):** referência estadual em trauma, queimados e toxicologia.
- **Hospital Infantil João Paulo II – HIJPII (Belo Horizonte):** hospital geral pediátrico e referência em doenças raras.
- **Hospital Alberto Cavalcanti – HAC (Belo Horizonte):** referência em oncologia, cirurgia oncológica e quimioterapia.
- **Hospital Júlia Kubitschek – HJK (Belo Horizonte):** hospital geral de alta complexidade: pneumologia, doenças raras, cirurgia geral, ortopedia e maternidade de alto risco distrital.

- **Hospital Regional de Barbacena – HRB (Barbacena):** referência em ortopedia, neurocirurgia e AVC.
- **Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena – CHPB (Barbacena):** internação psiquiátrica e cuidados prolongados.
- **Hospital Regional Antônio Dias – HRAD (Patos de Minas):** referência da Macrorregião Noroeste em trauma, cirurgia geral, ortopedia, neurologia e maternidade de alto risco; gerido pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), que é uma Organização Social de Saúde (OSS), desde 2024.
- **Hospital Regional Dr. João Penido – HRJP (Juiz de Fora):** hospital geral de alta complexidade, referência em pneumologia, cirurgia geral, urologia e maternidade de alto risco.
- **Maternidade Odete Valadares – MOV (Belo Horizonte):** maternidade de alto risco, medicina fetal e banco de leite.
- **Hospital Eduardo de Menezes – HEM (Belo Horizonte):** referência estadual em infectologia (HIV/aids, tuberculose) e processo transexualizador.
- **Hospital Cristiano Machado – HCM (Sabará):** cuidados prolongados, reabilitação, cuidados paliativos e cirurgias eletivas de pequeno e médio porte.
- **Casa de Saúde Santa Izabel – CSSI (Betim):** antiga colônia de hanseníase, voltada a cuidados prolongados e à assistência a ex-hansenianos residentes.
- **Casa de Saúde São Francisco de Assis – CSSFA (Bambuí):** antiga colônia de hanseníase, voltada aos cuidados prolongados e linha de cuidado da hanseníase.
- **Instituto Raul Soares – IRS (Belo Horizonte):** referência estadual no cuidado a pessoas em sofrimento psiquiátrico agudo de maior complexidade. Único hospital público exclusivamente psiquiátrico de MG.
- **MG Transplantes (BH e 7 OPOs regionais):** coordenação estadual de doação e transplantes.

9. Caderno de Entregas da Vinculada

9.1. Entregas Prioritárias

1. Eficientização da gestão hospitalar

- **Descrição da Entrega:** Principal entrega do ciclo e expressão direta da visão institucional do Planejamento Estratégico da Fhemig 2024–2027: “ser reconhecida pela eficiência de sua gestão na oferta de serviços para a saúde pública”. Reúne governança clínica, gestão de leitos por dados (DRG), reorganização da rede assistencial e metodologias de melhoria contínua. O acompanhamento é feito pelos cinco indicadores-síntese da “Fhemig do Futuro”, monitorados em painel gerencial: taxa de ocupação, tempo médio de permanência, internações, cirurgias e doadores efetivos (que serão detalhados na próxima seção).
- **Quantidade realizada:** A melhoria da eficiência da rede na gestão 2019–2026 resultou de um conjunto articulado de medidas, que atuaram em três

frentes complementares: a organização da estrutura, a reorganização da oferta e a qualificação dos processos assistenciais.

Organização da estrutura: A criação dos complexos hospitalares deu gestão única a unidades vizinhas: o Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (CHU) em 2020 (HJXXIII, HIJPII e HMAL), o Complexo Hospitalar de Especialidades (CHE) em 2021 (HAC e HJK) e o Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB) em 2022 (HRB e CHPB). Com isso, equipes, serviços de apoio, insumos e estrutura passaram a ser compartilhados, com ganho de escala e redução de custos. Ao mesmo tempo, a Fhemig desenvolveu uma metodologia própria de cálculo da capacidade instalada, que dimensiona a capacidade real de leitos e serviços de cada unidade e orienta as metas de produção. A metodologia ficou em 3º lugar no Prêmio Inova Minas 2024.

Reorganização da oferta: Com base nessa leitura da capacidade, os leitos e serviços foram redistribuídos conforme a vocação de cada unidade. Na saúde mental, o Hospital Galba Velloso (HGV) foi desativado em 2020 para dar lugar a leitos de retaguarda COVID; os pacientes e equipes do HGV foram remanejados para o IRS. Em 2021, foram abertos 40 novos leitos de saúde mental de apoio à Rede de Atenção Psicossocial em hospitais gerais da Fhemig (10 leitos em cada um destes hospitais, HJK, HJXXIII, HRJP e CHPB). Na linha cirúrgica, foram implantadas no HJK, em parceria com o CHU, as linhas de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia plástica reparadora e bucomaxilofacial. A atividade cirúrgica do HMAL foi concentrada no HJXXIII, e o prédio foi cedido à Santa Casa BH para implantação de um Instituto Oftalmológico. O bloco cirúrgico do HCM foi reaberto em set/2025 e é o único hospital de Sabará a realizar cirurgias. Desde fev/2026, o Opera Mais Fhemig promove mutirões mensais de cirurgias eletivas em 7 hospitais, com mais de 900 cirurgias até setembro e meta de mais de 1.000 no ano.

Qualificação dos processos. Para que a capacidade ampliada se convertesse em mais atendimentos, a Fhemig investiu na gestão do leito e do cuidado. A metodologia DRG, implantada e usada desde 2019, passou a identificar internações que ultrapassam o tempo esperado para cada caso. A Medicina Hospitalista, em cooperação com SES e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), foi implantada em 7 hospitais (641 leitos), com acompanhamento contínuo dos pacientes internados e coordenação entre as equipes clínicas e cirúrgicas. A metodologia Lean foi incorporada aos processos da rede por meio da pós-graduação em Lean Six Sigma e do projeto Lean nas Emergências. No HJXXIII, as cirurgias programadas passaram de 160 para 208 por mês e a ocupação do centro cirúrgico subiu de 34% para 62%. No Complexo de Barbacena, as cirurgias aumentaram 51% e as suspensões caíram 56%, e a superlotação das emergências diminuiu 23% no HJXXIII e 38% na MOV.

Resultados. Essas medidas atuaram em conjunto. Com fluxos mais organizados e acompanhamento diário da internação, o paciente passou a ficar internado apenas o tempo necessário. Isso reduziu a permanência média e liberou leitos para novos atendimentos: com a mesma estrutura, a Rede passou a internar e operar mais pacientes. Entre 2018 e 2025:

- as cirurgias passaram de 32.743 para 41.006 (+25%), a maior marca em 20 anos;
- as internações cresceram 11%, de 57.471 para 64.048, com pico de 65.648 em 2024;
- a taxa de ocupação subiu de 76% para 87%, a mais alta da série;
- o tempo médio de permanência caiu de 8,97 para 7,51 dias (−16%), o menor em 20 anos;
    - a ineficiência global do uso do leito, medida pelo DRG, recuou 9,6% entre 2021 e 2025.



- **Valor executado:** Melhorias processuais sem valor diretamente executado. Gastos apenas com educação continuada – R$8.561.648,10
- **Origem dos recursos:** Fonte 68 (Edital de estágios)
- **Data de início e fim:** 2019 – 2026 (PE 2020–2023 e PE 2024–2027).
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento.

2. Recomposição da força de trabalho – concurso público, credenciamento e consórcios

- **Descrição da Entrega:** A contratação de médicos é um desafio comum à gestão hospitalar pública. A concorrência com o mercado privado, a menor flexibilidade das regras do serviço público e a escassez de profissionais em algumas especialidades dificultam a composição das equipes. Para assegurar a continuidade da assistência e manter as escalas nas áreas críticas, a Fhemig adotou uma estratégia combinada, com instrumentos que se complementam, com destaque para a inauguração de credenciamentos como forma de recomposição de escalas médicas, solução essa nunca antes utilizada na Fhemig.

  - **Concurso Público – Edital nº 01/2023:** primeiro concurso da Fhemig em mais de 10 anos, para recompor o quadro efetivo e reduzir a dependência de contratos temporários.
  - **Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas:** editais permanentes de chamamento público para credenciar profissionais médicos (PF) e empresas médicas (PJ) para plantões e procedimentos, com remuneração por plantão efetivamente prestado. O modelo dá agilidade à reposição de profissionais em áreas como terapia intensiva, clínica médica, cirurgia e oncologia.
  - **Credenciamento de consórcio para gestão de escala:** contratação de consórcio público intermunicipal de saúde, por meio de credenciamento, para prestar o serviço de composição de escalas médicas, de forma complementar e subsidiária, quando o processo seletivo simplificado e o credenciamento PJ e PF forem insuficientes para cobrir as escalas. Hoje, o parceiro da Fhemig é o Instituto de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep).
- **Quantidade realizada:** Resultados:
  - Concurso público: 1.801 vagas, 5.201 candidatos aprovados, 3.893 nomeações, 2.491 posses, 2.342 candidatos efetivados e cadastro de reserva ativo com 1.308 candidatos.
    - Importante destacar que apenas 670 médicos foram empossados de um total de 1.284 nomeados. Isso demonstra a dificuldade e limitação deste formato de recrutamento de mão de obra médica.
  - Recomposição das escalas médicas em todos os hospitais da Fhemig. Dentre estes, destacam-se:
    - Complexo Hospitalar de Especialidades (desde jan/2023): escalas de UTI, bloco cirúrgico e ambulatórios recompostas, com mais consultas, cirurgias e internações.
    - Hospital Regional de Barbacena: o consórcio resolveu a falta crônica de anestesistas, com repercussão na mídia antes de 2023. Reduziu a espera por cirurgias, permitiu abrir cirurgias eletivas de quadril, joelho, varizes e hérnia e, principalmente, viabilizou a absorção de uma nova vocação: a neurocirurgia.
- **Valor executado:**
  - O concurso público não tem execução orçamentária própria, porque o custo dos servidores nomeados entra na despesa com pessoal e encargos sociais (Grupo 1) da Fhemig. Entre 2023 e 2026 a despesa de pessoal da Fhemig se deu da seguinte forma:
    - R$ 1,249 bilhão em 2023
    - R$ 1,327 bilhão em 2024
    - R$ 1,371 bilhão em 2025
    - R$ 1,057 bilhão até setembro/2026.
  - Credenciamentos e consórcios: R$ 289.169.186,04, ao longo dos quatro anos em questão.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e recursos SUS (incluindo Valora Minas).
- **Data de início e fim:**
  - Concurso iniciado em 2023. Prazo de finalização por categoria:
    - MED 02/07/2028 (prazo final, já prorrogado)

        - AGAS 29/10/2028 (prazo final, já prorrogado)
        - PENF 08/03/2027
        - TOS 16/05/2027
    - Consórcio:
        - CHE: 23/12/2025 a 22/12/2026 (aditivo de prazo em andamento)
        - MOV: 25/12/2025 a 24/12/2026 (aditivo de prazo em andamento)
        - CHU: 01/01/2026 a 31/12/2026 (nova contratação em andamento)
        - CHB: 03/02/2026 a 02/02/2027
        - CHE (2º contrato): 26/03/2026 a 25/03/2027
        - CHB (2º contrato): 16/09/2026 a 15/09/2027
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento.

3. Recuperação da infraestrutura predial da rede

- **Descrição da Entrega:** Recuperação de edificações antigas, algumas centenárias e tombadas, com passivo histórico de manutenção. Obras em hospitais são especialmente complexas, porque raramente é possível desocupar a área: a intervenção precisa ser feita por etapas, com a assistência funcionando 24 horas. Isso exige remanejamento de leitos e fluxos, controle de poeira, ruído e risco de infecção, manutenção da segurança de pacientes e profissionais e cumprimento das exigências da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e do patrimônio histórico. Por isso, prazos e custos tendem a ser maiores do que em obras comuns. A entrega se apoiou em duas contratações estruturantes:
    - Política Integrada de Manutenção Predial (PIMP): o contrato nº 9404356 (dez/2023), com o Consórcio IGC Cetus, reuniu em um único instrumento mais de 220 contratos descentralizados, no valor de R$ 163 milhões em 36 meses. Aumentou em 86% a força de trabalho de manutenção e implantou sistema informatizado de ordens de serviço, com rotinas preventivas e corretivas. A execução enfrentou desafios, tais como: atrasos na implantação, que geraram notificações formais à contratada; glosas elevadas no Acordo de Nível de Serviço; e execução financeira abaixo do previsto. Diante dessas dificuldades, o contrato, que se encerra em 26/12/2026, não será renovado. Um novo contrato de manutenção predial, que incorpora as lições aprendidas, está em elaboração e será assinado ainda em dezembro de 2026.
    - Engenharia Complementar: o contrato nº 9396589, com o consórcio Systra/Houer/Concremat, ampliou a capacidade técnica da Gerência de Infraestrutura Predial, que possuía apenas 5 engenheiros. Ele permitiu trazer equipes multidisciplinares (arquitetura hospitalar, engenharias, orçamento e regularização imobiliária), um engenheiro civil em cada unidade e softwares de projeto e fiscalização.
- **Quantidade realizada:** Entre 2023 e 2026, foram concluídas 62 intervenções e outras 16 estão em andamento, incluindo a substituição dos telhados do HAC e do HJK. As principais obras da gestão foram:
    - Hospital João XXIII: Melhoria geral da climatização, instalação de CFTV em todo o hospital (mais de 500 câmeras), pintura e

revitalização do Pronto-Socorro para abrir o setor de Baixo Risco (fast track), instalação do tubo pneumático no laboratório, troca e recuperação dos telhados, adaptação e revitalização dos banheiros do 4º, 6º e 7º andares, terminada em maio/2026;
    - Maternidade Odete Valadares: reforma e revitalização do telhado de toda a edificação, tombada pelo patrimônio histórico, e reforma do bloco obstétrico.
    - Hospital Júlia Kubitschek: reforma do bloco cirúrgico, com abertura de mais 3 salas, que deu suporte à ampliação das linhas cirúrgicas da unidade.
    - Complexo Hospitalar de Barbacena: ampliação do CTI de 10 para 20 leitos.
    - Hospital Infantil João Paulo II: novo CTI pediátrico.
- **Valor executado:** R$ 153,9 milhões em intervenções concluídas.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho.
- **Data de início e fim:**
    - PIMP: dez/2023 a dez/2026
    - Engenharia Complementar: out/2023 a out/2027
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento (PIMP em fase de encerramento, com novo contrato em elaboração).

4. Prontuário eletrônico e sistema de gestão hospitalar (Tasy) Plano de governo

- **Descrição da Entrega:** Substituição do antigo sistema SIGH pelo Tasy, sistema integrado de gestão hospitalar com certificação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), acompanhada da modernização do parque tecnológico e da rede de dados das unidades. O novo sistema trouxe ganhos em quatro frentes:
    - Segurança do paciente: prontuário e prescrição eletrônicos, que dispensam o papel e deixam a informação clínica disponível em tempo real para toda a equipe multiprofissional.
    - Rastreabilidade: controle de materiais e medicamentos, da compra à administração ao paciente, com mais controle de estoques e menos perdas.
    - Gestão do fluxo de pacientes: monitoramento dos tempos de espera e automação de rotinas como chamada por painel de senhas, solicitação de dietas e higienização de leitos, o que agiliza o giro de leitos.
    - Gestão baseada em dados: informações padronizadas e integradas entre as unidades, que alimentam os indicadores institucionais, o faturamento SUS e a codificação DRG, dando suporte à tomada de decisão da alta gestão.
- **Quantidade realizada:** Implantação em 11 hospitais da rede, com renovação do parque tecnológico (computadores, leitores e impressoras) e modernização do cabeamento de rede.
- **Valor executado:** R$ 23,6 milhões (valor contratado do sistema) e R$ 16 milhões (cabeamento estruturado).
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho.

- **Data de início e fim:** Ago/2022 (parametrização na MOV) – jan/2028 (término do contrato)
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento: viradas previstas no HIJPII em nov/2026, no HJXXIII em mar/2027 e na CSSFA em jun/2027.

5. Marketplace de compras de insumos hospitalares (Projeto Negócio Mineiro)

- **Descrição da Entrega:** Iniciativa inédita no governo de Minas Gerais planejada e executada pela Fhemig, com apoio da SEPLAG, e considerada um marco na forma de aquisição de bens na administração pública. O modelo responde aos principais gargalos do registro de preços tradicional: demora entre o planejamento da compra e a chegada do insumo, cerca de 20% de itens desertos ou fracassados e baixa execução das atas. Esses gargalos levavam a compras emergenciais descentralizadas nas unidades e ao risco de desabastecimento. No piloto, aplicado à compra de curativos, o tempo médio entre o planejamento e a entrega do insumo caiu cerca de 90%, de 270 para 29 dias. Além disso, as compras passaram a ser feitas com preços mais próximos aos praticados no mercado, o que também reduz o volume de itens fracassados ou desertos. O novo modelo de compra de materiais hospitalares é baseado nos procedimentos de credenciamento e pré-qualificação (arts. 79, III, e 80 da Lei nº 14.133/2021).
- **Quantidade realizada:** o Marketplace está em operação, com 27 empresas credenciadas para o fornecimento e 192 produtos pré-qualificados e aptos à venda na plataforma. Outros 52 produtos estão em análise técnica, o que deve ampliar em breve o catálogo disponível. Já foram feitos 14 pedidos, referentes a 74 itens do catálogo de curativos, que receberam ao todo 163 propostas. Até então foram aproximadamente 7 mil curativos entregues, com uma média de 6 dias para a chegada dos insumos.
- **Valor executado:** R$517,34 mil
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual.
- **Data de início e fim:** 2025 – em andamento (primeira compra em 2026).
- **Status (concluída, em andamento):** Em andamento, com expansão progressiva para outras categorias.

6. Sustentabilidade financeira: contratualização SUS, faturamento e habilitações

- **Descrição da Entrega:** A Fhemig tem diferentes fontes de financiamento. A principal delas é o orçamento estadual: os créditos autorizados foram de R$ 2,23 bilhões em 2023, R$ 2,39 bilhões em 2024 e R$ 2,71 bilhões em 2025, e de R$ 2,24 bilhões em 2026. A segunda mais importante é a receita da produção assistencial como prestadora do SUS: contratualização com os gestores municipais, incentivos e habilitações, via faturamento SUS. No que tange às contratualizações, o projeto Nova Contratualização Fhemig 2026, feito com a SES/MG, reformulou o modelo de repasse. Os recursos federais e estaduais passaram a ir direto para o Fundo Estadual de Saúde, administrado pela SES, e chegam à Fhemig por meio de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO). Antes, esses recursos iam para o Fundo Municipal de Saúde e seu recebimento dependia do repasse dos municípios à Fhemig, com atrasos recorrentes. O novo modelo dá à Fundação previsibilidade e governabilidade sobre os recursos. Este

processo já foi concluído para todas as unidades do interior e está em vias de finalização junto à prefeitura de Belo Horizonte. O valor contratualizado é da ordem de R$ 232 milhões por ano. Na mesma linha, foram obtidas novas habilitações:

- **2019:**
  - 50 leitos na Unidade de Internação em Cuidados Prolongados (UCP) na CSSFA (Portaria GM/MS nº 3.529/2019).
- **2022:**
  - 25 leitos na Unidade de Internação em Cuidados Prolongados (UCP) na CSSI (Portaria GM/MS nº 4.456/2022);
  - Hospital Amigo da Criança no HRJP (Portaria GM/MS nº 603/2022)
  - Unidade Assistencial de Alta Complexidade em Traumato-ortopedia no HRAD (Portaria GM/MS nº 888/2022)
- **2023:**
  - Serviço de Atenção às Doenças Raras do adulto no HJK (Portaria GM/MS nº 1.243/2023);
  - Processo Transexualizador ambulatorial no HEM (Portaria GM/MS nº 404/2023);
  - Vasectomia no HRJP (Portaria GM/MS SS nº 189/2023)
  - Credenciamentos estaduais de Centro de Tratamento de Queimados no HJXXIII, HRB e HRAD;
  - Credenciamentos estaduais de U-AVC estadual no HRB e HRAD;
  - Credenciamentos estaduais de Linha de Cuidado em Doenças Respiratórias Graves no HJK.
- **2024:**
  - 25 leitos na Unidade de Internação em Cuidados Prolongados (UCP) no HCM (Portaria GM/MS nº 5.582/2024);
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) – Componente cirurgias no HJK e HRAD (Portaria SMSA/SUS-BH nº 0352/2024)
- **2025:**
  - 8 leitos de UTI adulto no HRJP (Portaria GM/MS nº 7.750/2025);
  - Alta complexidade em traumato-ortopedia no HRB (Portaria nº 8.666/2025);
  - Centro de AVC Tipo III no HRB (Portaria nº 8.682/2025);
  - 10 leitos de UTI adulto tipo II no HRB (Portaria GM/MS nº 8.681/2025);
  - Hospital Amigo da Criança no HJK e na MOV (Portaria GM/MS nº 8.552/2025);
  - Hospital de Referência à Gestação e ao Puerpério de Alto Risco (HGPAR) no HJK, HRAD, MOV e HRJP (Portaria SAES/MS nº 2.902/2025);
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) – Componente Acesso à Radioterapia (Portaria GM/MS nº 8.516/2025)
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) no HJK, HAC, MOV e HJXXIII (Portaria SMSA/SUS-BH nº 948/2025)

- Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) no HCM (Portaria GM/MS nº 7.266/2025).

- **2026:**
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) no HEM, HRAD e HIJPII (Portaria SMSA/SUS-BH nº 431/2026);
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) no HRJP (Portaria SMSA/SUS nº 751/2026);
  - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) – Componente cirurgias no HJK (Portaria SMSA/SUS nº 539/2026)
- **Em andamento:**
  - 19 leitos de UTI e traumato-ortopedia no HJK;
  - Processo Transexualizador cirúrgico no HEM;
  - Neurocirurgia no HRB.

Os repasses do Valora Minas passaram de R$ 7,4 milhões em 2021 para R$ 48,1 milhões em 2025. Até agosto de 2026, por sua vez, foram repassados R$ 38 milhões. A Fhemig também começou a apurar o Indicador de Sustentabilidade Econômica Assistencial (ISEA). Ele mostra que, embora a Fundação tenha receita vinculada à produção, essa receita está longe de cobrir o custo da rede. Entre 2023 e 2025, o custo assistencial foi, em média, de R$ 2,0 bilhões por ano (R$ 1,5 bilhão até ago/2026). A receita da produção foi, em média, de R$ 231 milhões por ano, o que cobre **cerca de 12% do custo**. Os outros 88% dependem dos recursos do Tesouro Estadual. Isso explica a dependência estrutural da Fhemig do orçamento estadual para manter a operação, sobretudo a folha de pessoal, que responde por mais da metade da despesa. O orçamento autorizado também cobre despesas que não entram no custo, como investimentos e precatórios. As medidas adotadas no período ampliam a previsibilidade e a captação de recursos, mas não eliminam essa dependência. Daí a importância de manter o orçamento estadual em patamar compatível com o porte e a complexidade da rede, e de seguir com as ações de qualificação do faturamento, ampliação de habilitações e gestão de custos.



Figura 3 – Custo operacional da rede e receita da produção, 2023–2025. Fonte: custos – SIGH-Custos (GEOF/Fhemig); receita – Montante Financeiro Distribuível Geral (DPAR/Fhemig, 2026).

- **Quantidade realizada:** Faturamento: R$ 245,2 mi em 2023, R$ 238,4 mi em 2024, R$ 209,9 mi em 2025 e R$ 126,4 mi em 2026 (parcial). Foram mais de 30 novas habilitações federais e estaduais entre 2019 e 2025, e outras 3 estão em andamento. A nova contratualização foi pactuada com os municípios gestores.

- **Valor executado:** Não se aplica, porque a entrega gera receita para a Fundação.
- **Origem dos recursos:** Recursos federais (MAC/FAEC e incentivos), estaduais (Valora Minas) e municipais, repassados via Fundo Estadual de Saúde ou pelos gestores municipais.
- **Data de início e fim:** 2023 – em andamento.
- **Status:** Em andamento

9.2. Outras Entregas Relevantes

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
Laboratório polo (CRILAB) no HJXXIII	Centralização de exames laboratoriais programados da rede no laboratório do HJXXIII, com certificação ISO.	Em andamento (adequações finais)
Dimensionamento de pessoal	Construção do caderno de parâmetros para dimensionamento da força de trabalho por unidade e categoria profissional, usados para planejar recomposições, seja por concurso público e processos seletivos, seja por horas extras e credenciamentos.	Concluído
Edital de estágios e criação da Fonte 68	Chamamento público para selecionar as instituições de ensino que usam os campos de prática da Fhemig. As contrapartidas das instituições privadas passaram a formar a Fonte 68, reinvestida em qualificação, eventos científicos, pesquisa, inovação, nos Núcleos de Ensino e Pesquisa e entre outros investimentos.	Concluída (em execução)
Desinstitucionalização dos pacientes do CHPB	68 altas de moradores de longa permanência entre 2019 e 2025, a maioria para Residências Terapêuticas. Os 14 últimos moradores tiveram alta em 25/05/2026 para uma Residência Terapêutica em Barbacena e neste dia foi comemorado o “Fechamento dos Portões da Loucura”. Cada alta desativou um leito, encerrando o modelo asilar após 123 anos.	Concluída
Resposta à pandemia de Covid-19	Plano de Capacidade Plena Hospitalar (PCPH), lançado em 20/03/2020, com ativação de leitos em fases. O HEM e o HJK foram referências estaduais para adultos e o HIJPII para pediatria. Foram mais de 600 leitos dedicados à Covid-19 em 2020–2021 e 110 chamamentos emergenciais com 750 profissionais contratados. Entre 2020 e 2021, a rede fez 18.850 atendimentos a casos suspeitos, com 7.326 casos confirmados. O protocolo assistencial da Fhemig ficou em 3º lugar no Prêmio Inova 2021. Os leitos foram desmobilizados de forma planejada até meados de 2022.	Concluída
Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL) e Pesquisa de Clima Organizacional	Formação contínua de mais de 450 gestores e líderes da rede pelo PDL, em duas edições: o PDL 1.0, com duração de um ano e voltado a líderes-chave, e o PDL 2.0, com módulos mensais entre set/2025 e fev/2026, que incluiu coordenadores do nível tático-operacional e potenciais líderes. Junto com o PDL, foi realizada pesquisa de clima organizacional, que orientou planos de ação em comunicação, motivação, capacitação, liderança e humanização.	Concluída
Modernização do parque tecnológico e	Entre 2023 e 2026, a Fhemig empenhou R$ 195,1 milhões em investimentos nos hospitais: R$ 64,0 mi em 2023, R$ 35,1 mi em 2024, R$ 68,4 mi em 2025 e R$ 27,6 mi em	Concluída (aquisições em

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
investimentos na rede	2026. Desse total, R$ 91,4 milhões foram para mobiliário e equipamentos entre 2023 e 2025. Os recursos renovaram o parque tecnológico da rede: novos tomógrafos; raio-X fixo e móvel, digitalizadores de imagem e ultrassom digital; ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, desfibriladores e aparelhos de anestesia; equipamentos materno-infantis; microscópio cirúrgico, sistemas de videoendoscopia e instrumentais cirúrgicos; equipamentos para o banco de olhos; e camas Fowler elétricas, cadeiras de rodas e poltronas para acompanhantes.	andamento em 2026)
Vale-alimentação social para os moradores das Casas de Saúde	Implantação do vale-alimentação social para os moradores das Casas de Saúde da Fhemig. O benefício substituiu o fornecimento de cestas básicas e permite que os próprios moradores comprem seus alimentos no comércio local. Com isso, ganham autonomia, poder de escolha e mais dignidade, em linha com a política de reinserção social e de desinstitucionalização.	Processo concluído. Concessão do benefício em andamento.
Fortalecimento da gestão da informação e transparência ativa	O Conselho de Governança de Dados, criado pela Portaria Presidencial nº 3.298/2024, consolidou uma gestão orientada por evidências. Em 01/07/2025, foi lançado o Portal da Informação, aberto ao público no site da Fhemig. Ele reúne os painéis institucionais com dados assistenciais, de custos e de monitoramento das parcerias com OSS. O antigo Boletim Executivo Mensal, feito em PDF estático e com muito trabalho manual, foi substituído pelo Boletim Estratégico, uma plataforma interativa com atualização automática. O boletim é integrado a fontes oficiais (Tasy, SIGH, DataSUS, DRG e SAPT). Em 2025, a Fhemig publicou 19 conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos de Minas Gerais e se tornou a instituição líder em transparência ativa no Estado.	Concluída (atualização contínua)
Redução de carga horária dos servidores	A Portaria Presidencial Fhemig nº 3.401, de 26/03/2025, regulamentou a redução da carga horária de trabalho dos servidores da Fundação e padronizou critérios, documentação e fluxo de análise dos pedidos em todas as unidades. A medida atendeu a uma solicitação antiga dos servidores, dando segurança jurídica às concessões, uniformizando o tratamento entre as unidades e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência dos servidores na rede. Desde a publicação, foram aprovadas 659 solicitações.	Concessões em andamento

10. Políticas Públicas continuadas do Sistema

10.1. Políticas Públicas Prioritárias

1. Descentralização da gestão hospitalar Plano de governo Política avaliada

- **Descrição da Política Pública:** Alinhada aos objetivos de longo prazo do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), a Fhemig tem expandido a adoção de novos modelos de gestão hospitalar baseados em parcerias, todos reconhecidos como válidos pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 1.923/2015). Os modelos mais descentralizados oferecem mais autonomia, agilidade e flexibilidade na gestão. Também facilitam a

incorporação de novas soluções e tecnologias e otimizam o uso dos recursos, superando entraves da administração pública que dificultam respostas rápidas a novas demandas. A política se traduz no objetivo estratégico do Mapa 2024–2027 “Expandir as parcerias como forma de qualificar e simplificar processos”: a Fhemig transfere a gestão operacional ou a execução de projetos a parceiros mais aptos e mantém o planejamento, a regulação e a fiscalização. Os instrumentos em uso são municipalização, contrato de gestão com Organização Social de Saúde (OSS), termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), parceria público-privada (PPP) e cessão de uso de imóveis; outras alternativas como a criação de um Serviço Social Autônomo (SSA) ainda estão em estágio preliminar de implantação.

- **Resultados alcançados:** 1 PPP assinada (Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio - HoPE), 1 contrato de gestão em execução (HRAD), 1 contrato em processo de assinatura (HRJP), 4 municipalizações (CEPAI, CMT, Casa de Saúde Padre Damião e Casa de Saúde Santa Fé), 1 termo de parceria em execução (CHB - Acreditação do Hospital Regional) e 3 termos de cessão/permissão de uso de imóvel vigentes: Consórcio Circuito das Águas (Três Corações), Fundação Cristiano Varella (Ubá) e Santa Casa de Misericórdia (Belo Horizonte)
- **Valor executado:** Detalhado por parceria nos subtópicos abaixo.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual, recursos SUS e Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Muito alto: os contratos em curso têm obrigações e prazos jurídicos, e sua interrupção comprometeria a assistência nas unidades transferidas, os investimentos já feitos e a capacidade da Fhemig de se concentrar na média e alta complexidade.

1.1. PPP – Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (HoPE)

- **Descrição:** Concessão administrativa para construir, equipar, manter e operar os serviços de apoio não assistenciais ("bata cinza") de um novo complexo de saúde 100% SUS no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, no terreno do antigo Hospital Galba Velloso. O complexo reunirá os serviços do HAC, do HEM, do HIJPII e da MOV, nas áreas de oncologia, infectologia, pediatria, hematologia, maternidade e saúde da mulher, além do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MG/Funed). A Fhemig é o Poder Concedente.
    - O projeto começou a ser concebido pela Fhemig em 2022.
    - Em 2023, o CGPPP (Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas) aprovou a estruturação da parceria (deliberação de 21/08/2023) e a Codemge foi autorizada a modelar o projeto (25/09/2023), nos termos do Convênio nº 2271001379/2023. A modelagem começou em nov/2023.
    - A estruturação foi feita em conjunto por SES, Fhemig, Funed, Seinfra e Codemge. Como estruturador externo, a Codemge contratou a International Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco Mundial.
    - O projeto passou por consulta pública (24/12/2024 a 02/02/2025) e por leilão na B3 (17 a 19/09/2025).
- **Resultados alcançados:** Contrato de concessão assinado em 12/06/2026 com a SPE HoPE S.A., formada pelo Consórcio Saúde HoPE (Integra Brasil,

Oncomed e B2U Participações), com vigência de 30 anos. O contrato passou a produzir efeitos em out/2026, depois de cumpridas as condições de eficácia:

(i) unificação das matrículas do terreno e assinatura do Termo de Transferência da Área de Concessão;

(ii) depósitos nas Contas Aporte e Garantia;

(iii) publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

(iv) integralização do capital social da SPE.

O novo complexo terá 532 leitos, 110 deles de UTI, e o novo Lacen-MG. A previsão é de aumento de 40% nas consultas especializadas, que passarão de 200 mil por ano, e de 60% nas internações, que chegarão a 30 mil por ano.

- **Valor executado:** Investimento previsto de R$ 1,8 bilhão para construção e equipagem do complexo (CAPEX) e de R$ 4,5 bilhões em despesas operacionais ao longo dos 30 anos de contrato (OPEX), com data-base em mar/2025.
- **Origem dos recursos:** Os estudos de modelagem foram custeados pela Fhemig e pela Funed, por meio do convênio com a Codemge. A implantação e a operação serão financiadas com recursos do Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho, homologado em juízo, e do Tesouro Estadual.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Muito alto. A interrupção desperdiçaria cerca de quatro anos de trabalho técnico, jurídico e institucional, que envolveu Fhemig, Funed, SES, Seinfra, Codemge e a IFC (Grupo Banco Mundial) e passou por consulta pública e leilão na B3. Também se perderiam os investimentos já feitos. A rede SUS deixaria de ampliar leitos, consultas e cirurgias, e quem mais perde são os usuários, que deixariam de ter mais acesso aos serviços. A oncologia pediátrica não seria implantada, e as linhas de cuidado da mulher, das doenças raras e da infectologia continuariam fragmentadas. HAC, HEM, HIJPII e MOV permaneceriam em prédios antigos, de baixa escala e com restrições estruturais e de patrimônio histórico, que exigem reformas caras e de pouca efetividade.

1.2. OSS – Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), Patos de Minas

- **Descrição:** Primeiro hospital da Fhemig gerido por Organização Social de Saúde: Contrato de Gestão nº 12/2024 com a Faepu, celebrado em 24/05/2024.
- **Resultados alcançados:** Nota de desempenho acima de 9,0. Cirurgias passaram de 556 (mai/2024) para 930 (mai/2026), +60%. Diárias de UTI adulto +49% e de UTI neonatal +35%. Única unidade da rede com eficiência no DRG Brasil e acreditação ONA 2. Contrato renovado por mais 5 anos (3º Termo Aditivo).
- **Valor executado:** R$212.765.576,56 em 28 meses, incluindo custeio mensal e investimentos, que nesse caso são executados diretamente pela OSS.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e recursos SUS repassados via contrato de gestão.

- **Prejuízo de descontinuidade:** Muito alto, e quem mais perde é a população da macrorregião Noroeste. O HRAD é hoje a parceria mais consolidada da Fhemig, e seus avanços só foram possíveis por meio do contrato de gestão. Antes dele, as escalas médicas eram sempre defasadas: foram 464 déficits de plantão só no segundo semestre de 2022. Com a OSS, as escalas estão 100% completas desde 2024, e o hospital passou a oferecer cirurgia pediátrica, urologia, cirurgia vascular, nefrologia, hematologia e cirurgia plástica. As cirurgias cresceram mais de 60%, a unidade obteve a acreditação ONA 2 e é a única da rede com eficiência no DRG. A interrupção exigiria a reestatização imediata da força de trabalho – o que no contexto dos limites da LRF não é possível – e dos contratos, com risco concreto de voltar aos déficits de escala e diminuição drástica dos serviços hoje prestados.

1.3. OSS – Hospital Regional Dr. João Penido (HRJP), Juiz de Fora

- **Descrição:** Segunda parceria com OSS, selecionada pelo Edital Fhemig nº 01/2025 (dez/2025). O estudo de viabilidade passou por controle prévio do TCE-MG. A entidade selecionada é a Fundação Benjamin Guimarães (Hospital da Baleia).
- **Resultados alcançados:** Seleção concluída; alinhamento inicial e inventário em curso. Celebração prevista para 18/11/2026, com transição de 90 dias. Metas: reabrir o Pronto Atendimento, fortalecer a maternidade de alto risco, ampliar as cirurgias, principalmente as cirurgias pediátricas, e implantar o atendimento ao paciente queimado e a radiologia intervencionista.
- **Valor executado:** Ainda não houve execução orçamentária. Valor estimado de R$ 420,4 milhões em 5 anos (R$ 76,5 milhões no 1º ano), com 90% fixos e 10% vinculados a indicadores de desempenho.
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e recursos SUS.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Alto. A parceria é o caminho para o HRJP passar de 139 para 220 leitos e reabrir o Pronto Atendimento, fechado há 12 anos. Sem a parceria com OSS, a ampliação do acesso e reabertura do PA são impossíveis. Também permite implantar a Unidade de Queimados, retomar a cirurgia pediátrica e avançar na radiologia intervencionista; além de ampliar a CPRE, a urologia endoscópica e a maternidade de alto risco. Com a gestão por OSS, ficam mais ágeis as compras, a contratação de profissionais e as obras urgentes, como a troca do telhado e as adequações exigidas pela Vigilância Sanitária. A interrupção ou o atraso do processo adiaria essas entregas essenciais para o aumento e qualificação do acesso à população.

1.4. Municipalização

- **Descrição:** Transferência a municípios da gestão de unidades de atenção psicossocial e de cuidados prolongados, de menor complexidade, que pela lógica de organização do SUS deveriam integrar a rede municipal, fortalecendo a descentralização da atenção à saúde. O objetivo é fortalecer a gestão local, mais próxima da população e mais apta a integrar esses serviços à atenção primária e à rede de atenção psicossocial do território. A transferência é feita de forma planejada e pactuada: cessão de servidores, doação de bens e insumos e manutenção do custeio por um período de

transição. O atendimento continua 100% SUS. Com isso, a Fhemig concentra seus recursos na média e alta complexidade, sua vocação estatutária.

- **Resultados alcançados:** CEPAI e CMT transferidos à Prefeitura de Belo Horizonte, como CAPS AD e CAPS Infantojuvenil (transição concluída em dez/2024). Casa de Saúde Padre Damião transferida à Prefeitura de Ubá (transição até dez/2026). Casa de Saúde Santa Fé transferida à Prefeitura de Três Corações (termo assinado em 08/06/2026, transição até dez/2027). Tratativas iniciadas com a Prefeitura de Bambuí para a Casa de Saúde São Francisco de Assis.
- **Valor executado:** Não se aplica (desoneração do Tesouro Estadual).
- **Origem dos recursos:** Não se aplica (desoneração do Tesouro Estadual).
- **Prejuízo de descontinuidade:** Muito alto, com impacto direto sobre a população atendida nas unidades em transição. Interromper as municipalizações em curso (Padre Damião, em Ubá, e Santa Fé, em Três Corações) deixaria as unidades sob gestão indefinida entre o Estado e os municípios. Isso traria risco de desassistência, de insegurança para os servidores cedidos e de descumprimento dos planos de trabalho e prazos pactuados com as prefeituras, a CIB-SUS e os órgãos de controle.

2. Doação e transplante de órgãos e tecidos (MG Transplantes)

- **Descrição da Política Pública:** Coordenação estadual do processo de doação, captação e distribuição de órgãos e tecidos pela Central Estadual de Transplantes e 7 OPOs regionais, com capacitação em diagnóstico de morte encefálica, comunicação com as famílias e incentivos financeiros à rede.
- **Resultados alcançados:** Entre 2020 e 2025, os doadores efetivos de órgãos e tecidos cresceram 90%, superando a meta de 1.000 doadores do Planejamento Estratégico 2024–2027. No período da gestão, os transplantes de órgãos aumentaram 32%, com destaque para os de rim (+46%), e os transplantes de córnea mais que dobraram desde o mínimo da pandemia. A rede foi fortalecida com o credenciamento de consórcios intermunicipais para exames complementares, a formação de equipes externas de enucleação de córneas, o sistema MGTX e os primeiros transplantes de pulmão no Estado (2025). A governança foi fortalecida com o acompanhamento periódico de indicadores. Também foi criada a Política Continuada de Ampliação à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.330/2023, regulamentada pela Resolução SES/MG nº 8.955/2023), com incentivo financeiro estadual às OPOs e às **Equipes Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos (e-DOT), antigas** CIHDOTTs, para dar mais capilaridade à doação e ao transplante num Estado de grande extensão e ainda com vazios assistenciais. Por fim, o Plano Estadual de Doação e Transplantes 2025–2029 foi aprovado na CIB-SUS.

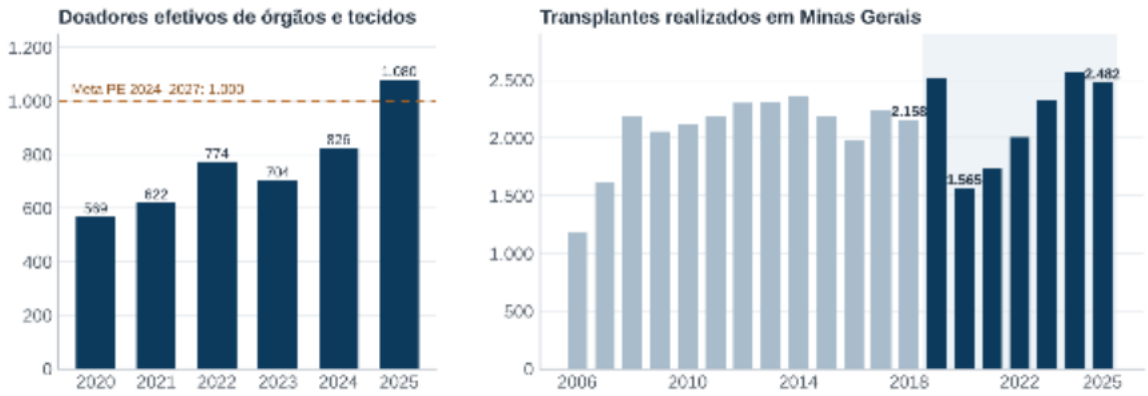


Figura 4 – Doadores efetivos (2020–2025) e transplantes realizados em Minas Gerais (2006–2025). Fonte: MG Transplantes/Fhemig – Balanço de 20 anos (CES-MG, mar/2026).

- **Valor executado:**
  - **2023:** R$ 21.903.024,58
  - **2024:** R$ 27.024.619,91
  - **2025:** R$ 26.163.044,08
  - **2026:** R$ 7.656.126,68 (até o primeiro quadrimestre)
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual e recursos federais do Sistema Nacional de Transplantes.
- **Prejuízo de descontinuidade:** Muito alto: a função é exclusiva da Fhemig no Estado. A interrupção leva à perda completa da política de captação de órgãos e à descontinuidade dos transplantes em MG.

10.2. Outras Políticas Públicas Relevantes

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
Cessão do hospital da Casa de Saúde Santa Fé ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Circuito das Águas	Cessão gratuita de uso do imóvel e doação dos bens móveis do hospital da CSSFé, em Três Corações, ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Circuito das Águas, selecionado pelo Edital nº 06/2024, com termo assinado em jan/2025. O Consórcio implantou o Hospital São José, voltado a cirurgias eletivas, consultas especializadas e exames de média complexidade para a microrregião.	Concluída
Cessão do prédio do Hospital Maria Amélia Lins (HMAL) à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte	Cessão gratuita de uso do imóvel onde funcionava o HMAL à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, selecionada pelo Edital nº 01/2025, com termo assinado em jul/2026. A Santa Casa, em diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte e Secretaria Estadual de Saúde, definiu transformar a unidade no Instituto de Oftalmologia da Santa Casa BH, para realização de cirurgias e atendimento ambulatorial, além de ambulatório de diálise peritoneal. Ela já iniciou o investimento de R$ 5,8 milhões de reais no prédio.	Em andamento
Cessão do hospital da Casa de Saúde Padre Damião À Fundação Cristiano Varella	Cessão gratuita de uso do imóvel da CSPD, em Ubá, à Fundação Cristiano Varella, com termo assinado em ago/2021. A Fundação hoje oferta consultas especializadas, exames, medicamentos e sessões de infusão de quimioterapia para a microrregião. Quando estiver em pleno funcionamento, a expectativa é absorver parte dos atendimentos que eram realizados	Concluída

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
	exclusivamente no Hospital do Câncer de Muriaé, reduzindo o tempo de deslocamento dos pacientes	
Regularização fundiária urbana (REURB) das áreas das antigas colônias	Regularização, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017 e em parceria com os municípios, dos núcleos urbanos que se formaram nas áreas das antigas colônias de hanseníase. A REURB garante aos ocupantes o título de propriedade com matrícula individualizada em cartório e desvincula essas áreas do patrimônio da Fhemig, dando segurança, amparo e dignidade aos antigos internos da Colônias de Hanseníase.	CSSI - Concluída CSPD - Concluída CSSFE – em andamento CSSFA - negociação junto à prefeitura paralisada

11. Pontos de Atenção no fechamento de Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Celebração do contrato de gestão do HRJP	Concluir inventário, memória de cálculo e manifestação do Conselho Estadual de Saúde (Lei nº 23.081/2018), passar pela Procuradoria e pela Seplag e assinar o contrato com a Fundação Benjamin Guimarães.	18/11/2026	Contratual
Descentralização da gestão do HCM	Publicar Edital de Seleção	31/12/2026	sugestão do órgão/entidade
Novo contrato de manutenção predial (substituto do PIMP)	Concluir a contratação que substituirá a CETUS. O contrato nº 9404356, com o Consórcio IGC Cetus, será encerrado antes do fim da vigência (26/12/2026) por causa de problemas reiterados de execução: atrasos, falhas de medição e glosas recorrentes no Acordo de Nível de Serviço. Além disso, o TCE-MG já havia vedado a prorrogação. O novo contrato deve incorporar as lições aprendidas, como fluxo de acionamento centralizado, padronização das medições e indicadores e governança mais forte da gestão central. Também é preciso garantir a transição entre os contratos, sem interromper a manutenção preventiva e corretiva das unidades.	31/12/2026	Contratual
Virada do Tasy no Hospital Infantil João Paulo II	Concluir a operação assistida após a virada recente do Tasy no HIJPII. Isso inclui corrigir falhas e ajustar a parametrização, reforçar o suporte e o treinamento das equipes e monitorar indicadores de segurança do	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
	paciente, faturamento e tempos de atendimento. O sistema precisa estar estável antes do pico da sazonalidade respiratória de 2027.		
PPP HoPE – condições de eficácia	Finalizar a estruturação da equipe de gestão e fiscalização do contrato e contratar o apoio técnico à fiscalização; aprovar indicação de Verificador Independente; acompanhar emissão de licenças de supressão e demolição, finalizar discussão do projeto básico.	31/12/2026	Contratual
Transição do HMAL para a Santa Casa BH	Concluir a transferência patrimonial e documental, encerrar as contas contínuas (Cemig e Copasa)	31/12/2026	Órgão de controle
Municipalização da Casa de Saúde Padre Damião (Ubá)	Encerrar a transição prevista no 3º aditivo do Termo de Cooperação.	31/12/2026	Contratual
Preparação dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para recompor os contratos temporários	Devido às restrições da legislação eleitoral, a Fhemig não pôde renovar nem firmar novos contratos temporários de RH com base na Lei nº 23.750 durante o período eleitoral de 2026, e a restrição vale até dezembro. Com isso, contratos estão se encerrando sem a devida reposição. A Fhemig precisa, portanto, concluir os PSS, para 371 vagas, ainda em 2026, com resultados homologados e listas de classificados prontas, para que as contratações possam ser feitas logo no início de 2027.	31/12/2026	Legal
Nova Contratualização Fhemig 2026 – repasse direto via Fundo Estadual de Saúde para as unidades de BH	Concluir a negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte para que os recursos do PCEP das seis unidades da capital (HJXXIII, HIJPII, MOV, HEM, HJK e HAC) passem a ser repassados direto pelo Fundo Estadual de Saúde à Fhemig, por TDCO.	31/12/2026	Contratual

12. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Convocação e contratação dos aprovados nos PSS	Convocar os classificados nos PSS concluídos em 2026 e formalizar os contratos temporários a partir de 01/01/2027. Assim, a força de trabalho reduzida durante o período eleitoral é recomposta e se evita desassistência ou fechamento de leitos e serviços.	01/01/2027	Legal
Tasy no Complexo Hospitalar de Urgência	Consolidar a implantação do Tasy no Hospital Infantil João Paulo II, que terá acabado de passar pela virada, garantindo estabilidade do sistema, suporte às equipes e segurança do paciente na fase pós-implantação. Preparar e executar a virada no Hospital João XXIII, prevista para março de 2027, com plano de contingência, infraestrutura de rede e equipamentos adequados, e suporte reforçado. É a última unidade da rede a migrar e a de maior complexidade.	09/03/2027	Sugestão do órgão/entidade
Transição do HRJP para a OSS	Dar continuidade ao processo de transição (pessoal, contratos, patrimônio e sistemas)	16/02/2027	Contratual
PPP HoPE – primeiras etapas após a eficácia do contrato	Acompanhar emissão de licenças para início das obras.	31/03/2027	Contratual
Arboviroses	Acompanhar indicadores epidemiológicos para, se necessário, ativar plano de resposta.	28/02/2027	Sugestão do órgão/entidade
Plano de contingência da sazonalidade respiratória 2027	Implantar Plano de Contingência da Sazonalidade garantindo leitos, equipes e insumos, principalmente no HIJPII.	28/02/2027	Sugestão do órgão/entidade
Descentralização da gestão do HCM	Dar prosseguimento à seleção da OSS por meio de Edital.	31/03/2027	Sugestão do órgão/entidade
Validade do Concurso Público Edital nº 01/2023	Decidir sobre a prorrogação da validade e as nomeações remanescentes antes do vencimento.	MED 02/07/2028 (prazo final, já prorrogado) AGAS 29/10/2028 PENF 08/03/2027	Legal

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
		(com possibilidade de prorrogação) TOS 16/05/2027 (com possibilidade de prorrogação)	
Cobrança dos valores devidos à Fhemig pelos gestores do SUS	Manter a cobrança ininterrupta de dívidas remanescentes dos municípios junto à Fhemig e garantir o cumprimento dos encontros de contas e parcelamentos de débitos negociados até então.	31/03/2027	Contratual

ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO – FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – HEMOMINAS

13. Competências da Vinculada

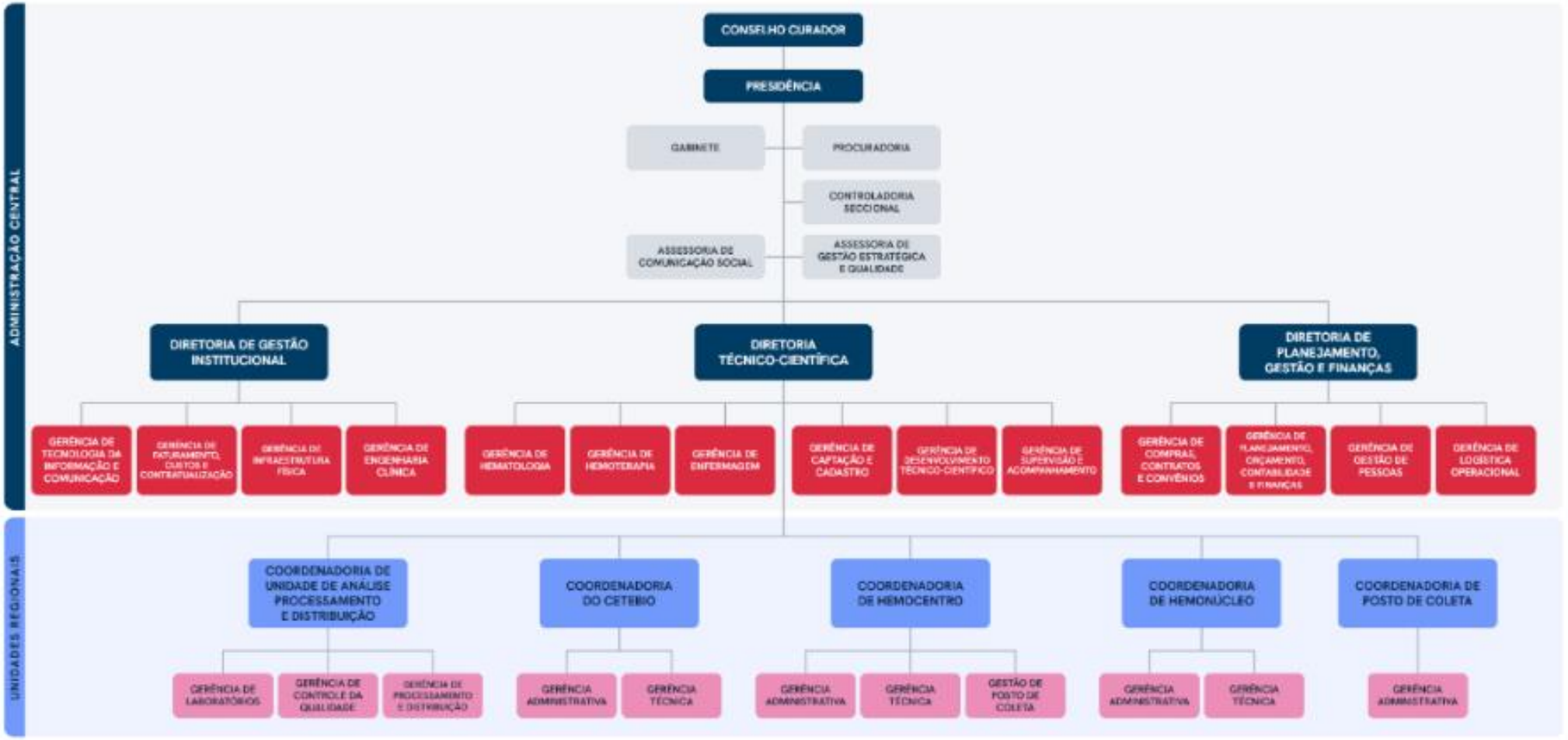
A Hemominas tem como competência garantir à população a oferta de sangue, hemoderivados, células e tecidos, e atendimento a pacientes com hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de saúde, obedecidos os padrões de excelência e qualidade, além das atribuições detalhadas no Decreto nº 49.293, de 1º de outubro de 2026, disponível em https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/49293/2026/. Organograma da Vinculada na página a seguir:

FUNDAÇÃO HEMOMINAS

Estrutura Orgânica da Fundação Hemominas

Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016;
Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023;
Decreto nº 49.293, de 1º de outubro de 2026.

Organograma



Minas em TRANSIÇÃO

14. Caderno de Entregas da Vinculada

14.1. Entregas Prioritárias

Implantação de Postos Avançados de Coleta Externa (PACE)

- **Descrição da Entrega:** A Hemominas tem priorizado a implantação de novos Postos Avançados de Coleta Externa (PACE) nas diversas regiões do estado, o que facilita o acesso dos doadores, proporcionando maior conforto e segurança e potencializando a quantidade de bolsas coletadas pela Hemominas. Os PACEs são implantados por meio de parcerias com os municípios. Funcionam com equipamentos e insumos fornecidos pela Hemominas, em imóvel e com servidores disponibilizados pelo município, que são supervisionados e treinados pela equipe da Hemominas.
- **Quantidade realizada:** Nos últimos quatro anos, foram implantados 12 novos PACEs, sendo em 2024 Itabira, Formiga, Paracatu, Patrocínio, São Sebastião do Paraíso, Nova Lima; em 2025 Além Paraíba, Ituiutaba e em 2026 Coronel Fabriciano, Ipatinga, São Lourenço e Ubá, totalizando 23 PACEs no estado.
- **Valor executado:** R$ 19.616.363,84
- **Origem dos recursos:** Fonte 10 – Recursos Ordinários
- **Data de início e fim:** O primeiro PACE foi inaugurado em 2009 e a estratégia continua em andamento.
- **No Status (concluída, em andamento):** Em andamento – atividade contínua. PACEs em negociação: Araxá, Ouro Preto, Pirapora, Salinas, Teófilo Otoni e Três Corações.

Distribuição dos PACEs implantados no estado de Minas Gerais.



14.2. Outras Entregas Relevantes

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
Implantação da tecnologia Inativação de Patógenos	É uma tecnologia que inibe um amplo espectro de vírus, bactérias e parasitas, tais como: dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela dentre outras, que podem estar presentes livres no sangue ou dentro das células leucocitárias aumentando a segurança transfusional.	Implantada no Hemocentro de Belo Horizonte e no Hemocentro de Uberlândia. Está em estudo a viabilidade de expansão para outras unidades de produção da Hemominas. Do total de plaquetas produzidas no estado mais de 60% são com a tecnologia de inativação de patógenos.
Construção da Nova Sede do Hemonúcleo de Ponte Nova	Construção da Nova Sede da unidade que funcionava em uma estrutura subdimensionada e fora das exigências legais.	Concluída
Ampliação da realização de exames de HLA para transplantes de órgãos sólidos e incorporação da tecnologia de Sequenciamento de Nova Geração (NGS).	Entre 2023 e setembro de 2026, o Laboratório de Histocompatibilidade da Fundação Hemominas avançou na modernização tecnológica, com a implantação do sequenciamento de nova geração (NGS) em 2023, e ampliou sua atuação com a incorporação, em agosto de 2024, dos exames para transplantes de órgãos sólidos, incluindo atendimento a doadores falecidos com cobertura de plantão. Entre 2023 e 2025, houve aumento de 42,5% nos doadores aparentados e de 13,1% nos registros liberados de receptores aparentados. Até agosto de 2026, foram registrados 202 atendimentos a doadores falecidos desde a implantação do novo fluxo, sendo 63 em 2026, dos quais 42 ocorreram no plantão noturno.	Implantado e em funcionamento.
Ampliação do procedimento de Desleucocitação	Consiste na remoção de leucócitos dos componentes sanguíneos celulares, com o objetivo de atender às necessidades transfusionais específicas de determinados pacientes, **aumentando a segurança transfusional e reduzindo o risco de reações adversas associadas à presença de leucócitos**.	Ampliação da desleucocitação de concentrados de hemácias: • **2025:** 36% dos CH desleucocitados • **2026:** 40% dos CH desleucocitados, no período de 01/01 a 01/10

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
Produção de Colírio de Soro Autólogo	O colírio de soro autólogo é um hemoderivado para atender a tratamento personalizado, é produzido a partir do sangue do próprio paciente para tratamento de distúrbios graves da superfície ocular, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).	Implantado. O CETEBIO em parceria com o Hospital das Clínicas está realizando avaliação da efetividade do colírio de soro autólogo, buscando sistematizar evidências sobre os resultados do produto no atendimento aos pacientes. A iniciativa subsidiará futuras discussões quanto à ampliação do acesso à tecnologia e à avaliação de sua possível incorporação ao SUS, por meio da CONITEC. Em 2025 foram atendidos 13 pacientes e em 2026 (até o mês de setembro), 14 pacientes. 27 pacientes no total.
Ampliação da produção de bolsas de plasma para indústria	A Octapharma, empresa contratada pela Hemobrás, é responsável pela produção de medicamentos estratégicos (hemoderivados) a partir do plasma excedente produzido por unidades certificadas pela Octapharma, de acordo com os parâmetros industriais de segurança e qualidade. Foram certificados os Hemocentros de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba e Unidade de Coleta de Poços de Caldas.	Em 2022 foram enviadas 26.258 bolsas de plasma para a indústria, provenientes de três unidades qualificadas da Hemominas: Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora. Em 2023, outras duas unidades foram qualificadas para o envio de plasma industrial: Montes Claros e Governador Valadares. Posteriormente, em 2024, foram qualificadas as unidades de Uberaba e Poços de Caldas. Com isto em 2025, com 7 unidades qualificadas tivemos o envio anual fechado em 127.760 bolsas para indústria.
Modernização do Parque Tecnológico da Fundação Hemominas	Aquisição de equipamentos técnicos e de infraestrutura de informática para substituição de equipamentos obsoletos e/ou acréscimo de novos equipamentos	No quadriênio 2023/2026 foram adquiridos 670 equipamentos técnicos com investimento total de R$ 15.435.000,00 e 1.071 equipamentos de informática com investimento total de R$ 5.448.000,00.
Regionalização da produção	Regionalização do processo produtivo nos Hemocentros, possibilitando melhor qualidade dos produtos, eficiência do processo produtivo, etc. A Hemominas chegou a operar com suas 20 unidades realizando atividades de produção de hemocomponentes. Contudo, em razão de processos de reorganização operacional, adequação da infraestrutura física, disponibilidade de	Concluído. Houve redução de 20 para 7 centros produtores.

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
	recursos humanos especializados e necessidade de concentração da produção em estruturas com maior capacidade técnica e laboratorial, esse quantitativo foi progressivamente reduzido. Em 2023, a hemorrede estadual contava com 12 unidades produtoras e, em 2025, passou a operar com 7 unidades de produção de hemocomponentes	
Certificação Internacional	Certificado de acreditação internacional da *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB) / Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), para serviços de banco de sangue e serviços de transfusão, no hemocentro de Belo Horizonte (HBH),	Concluído 5ª Recertificação junho de 2024 Concluída 6ª Recertificação junho de 2026
Certificação Internacional	Certificado de acreditação internacional da *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB) / Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), para serviços do Centro de Processamento Celular do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio).	Concluído Certificação Dezembro de 2023 Concluído 1ª Recertificação junho de 2026
Realização do Concurso Público (Edital nº 01/2024)	Foi realizado concurso público para provimento aos cargos das carreiras de Analista de Hematologia e Hemoterapia - ANHH, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia - ATHH e Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH, instituídos pela Lei Estadual nº 15.462 de 13 de janeiro de 2005, para substituição de contratos administrativos e vacância de servidores aposentados, falecidos e exonerados.	534 nomeações realizadas 347 nomeações referentes às vagas originalmente previstas no edital. 109 nomeações de reposição de vagas tornadas sem efeito. 82 nomeações adicionais autorizadas pelo Comitê de Orçamento e Finanças - Cofin. 387 servidores empossados Taxa global de posse: 72,47%. Existem 11 vagas que não poderão ser providas pelo concurso, em razão de ausência de candidatos aprovados, esgotamento de cadastro de excedentes ou inexistência da categoria/localidade no certame:

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status (concluída, em andamento)
		• Auxiliar Administrativo - Governador Valadares - 02 vagas • Enfermeiro – Uberaba - 1 vaga • Médico com qualquer especialidade: Patos de Minas – 02 vagas • Médico com qualquer especialidade: Ponte Nova – 01 vaga • Médico com qualquer especialidade: Pouso Alegre – 01 vaga • Médico com qualquer especialidade: Uberaba – 01 vaga • Médico hematologista - Governador Valadares - 01 vagas • Médico hematologista - Pouso Alegre – 01 vaga • Psicólogo - Belo Horizonte – 01 vaga Essas vagas já estão autorizadas pela Cofin e o Processo Seletivo Simplificado (PSS) está em elaboração para garantir a continuidade dos serviços essenciais

15. Políticas Públicas continuadas do Sistema

15.1. Políticas Públicas Prioritárias

Hemoterapia e Hematologia

- **Descrição da Política Pública :** A hemoterapia trata da cadeia produtiva do ciclo do sangue, ou seja, envolve atividades de captação de doadores de sangue; triagem clínica; coleta de sangue do doador apto clínico (sangue total e aférese); aférese terapêutica; testes laboratoriais imuno-hematológicos, sorológicos e moleculares do sangue coletado; fracionamento e produção, provas laboratoriais pré-transfusionais; diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência, transfusão de hemocomponentes e hemoderivados. Atualmente, a Fundação fornece hemocomponentes para 532 estabelecimentos de saúde (EAS) públicos e privados e possui atuação em praticamente todo o Estado. Na área de hematologia, a Hemominas atua para o diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, hemoglobinopatias e aqueles que necessitem de transfusões ou sangrias terapêuticas em todo o estado.

- **Resultados alcançados:** Em relação à hemoterapia, a Hemominas coletou 234.211 bolsas de sangue em 2023, 290.480 bolsas de sangue em 2024, 291.881 bolsas de sangue em 2025 e 191.322[1] bolsas de sangue em 2026 (até 30 de setembro). Além disso, produziu 698.433 hemocomponentes em 2024, 686.610 hemocomponentes em 2025 e 336.522 [2]hemocomponentes em 2026 (até 30 de setembro). Em relação à hematologia, a Hemominas realizou 69.396 atendimentos a pacientes em 2023, 70.743 atendimentos em 2024, 56.715 atendimentos em 2025 e 40.652 atendimentos até 30 de setembro de 2026.
- **Valor executado:**

Código da Ação Orçamentária	Descrição da Ação Orçamentária	Ano	Crédito Autorizado	Empenhado/Realizado	% Execução
4540	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS	2023	R$ 154.541.896,09	R$ 144.478.735,37	93,49
4341	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2023	R$ 29.817.940,50	R$ 22.361.629,55	74,99
4212	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS	2024	R$ 173.142.022,01	R$ 172.826.634,30	99,82
4222	MODERNIZACAO E/OU MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E/OU TECNOLOGICA DA INFRAESTRUTURA	2024	R$ 29.627.502,33	R$ 22.984.342,17	77,58
4212	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS	2025	R$ 175.490.741,86	R$ 173.168.374,10	98,68
4222	MODERNIZACAO E/OU MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E/OU TECNOLOGICA DA INFRAESTRUTURA	2025	R$ 29.151.323,84	R$ 20.897.759,18	71,69
4212	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS	2026 (14/10/2026)	R$ 174.029.031,00	R$ 151.716.418,07	87,18
4222	MODERNIZACAO E/OU MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E/OU TECNOLOGICA DA INFRAESTRUTURA	2026 (14/10/2026)	R$ 32.329.326,77	9.646.907,02	29,84

OBS: 1 - em 2023 e 2024 a despesa de pessoal era descentralizada nas ações orçamentárias 4540 e 4212

- **Origem dos recursos:** Fonte 10 – Recursos Ordinários
- **Prejuízo de descontinuidade:** Na hemoterapia, a descontinuidade afetaria a cadeia assistencial do SUS e da rede privada em Minas Gerais com interrupção ou redução da disponibilidade de sangue e hemocomponentes para transfusões, que impacta na realização de diversos procedimentos cirúrgicos, tratamentos oncológicos, transplantes e demais procedimentos que necessitam de sangue. Além do impacto assistencial, também poderia haver perda da capacidade de coordenação da política estadual de sangue e hemocomponentes. Na hematologia, as coagulopatias hereditárias e

hemoglobinopatias são doenças de evolução crônica, por isso a suspensão do atendimento afeta diretamente a qualidade de vida e eficiência do tratamento dos pacientes.

Terapia Celular

- **Descrição da Política Pública :** O Centro de Processamento de Células do Centro de Tecidos Biológicos - Cetebio tem por finalidade desenvolver, executar e acompanhar as atividades de processamento, armazenamento e distribuição das unidades de células progenitoras hematopoiéticas e de concentrado de linfócitos do doador para imunoterapia após transplante alogênico, assegurando a qualidade, a viabilidade, a segurança e a disponibilidade dos produtos celulares para utilização terapêutica, em suporte aos transplantes realizados nos Centros Transplantadores de Minas Gerais.
- **Resultados alcançados:** Em 2025 foram realizados 387 processamentos. Em 2026 foram realizados 309 processamentos até o mês de setembro.
- **Valor executado:**

Código da Ação Orçamentária	Descrição da Ação Orçamentária	Ano	Crédito Autorizado	Empenhado/Realizado	% Execução
4405	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	2023	R$ 5.357.129,96	R$ 5.332.847,42	99,55
4237	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	2024	R$ 4.956.790,75	R$ 4.956.739,07	99,99
4237	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	2025	R$ 5.140.641,37	R$ 4.979.681,81	96,87
4237	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	2026 (14/10/2026)	R$ 6.384.890,00	R$ 3.672.226,25	57,51

OBS: 1 - em 2023 e 2024 a despesa de pessoal era descentralizada nas ações orçamentárias 4405 e 4237

- **Origem dos recursos :** Fonte 10 – Recursos Ordinários
- **Prejuízo de descontinuidade:** A descontinuidade do serviço de terapia celular compromete a disponibilidade de produtos celulares essenciais à realização de transplantes, podendo ocasionar atrasos ou inviabilização de procedimentos terapêuticos, com impacto direto na continuidade da assistência aos pacientes do SUS.

15.2. Outras Políticas Públicas Relevantes

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
Plasmaférese terapêutica	A SES e a Hemominas criaram a política de plasmaférese terapêutica, que é um procedimento complexo e de alto custo. Consiste na	Foram implantadas duas políticas. A política de plasmaférese no âmbito dos transplantes e a de doenças raras. A dos transplantes foi implantada em setembro de 2025 e

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
	remoção do plasma através de equipamento automatizado com finalidade terapêutica e é indicado para pacientes que sofrem rejeições e intercorrências em razão de transplante de órgãos. A política estabeleceu o ressarcimento pela SES diretamente aos Estabelecimentos de Saúde habilitados em valor custo efetivo, sendo orientado e autorizado pela Fundação Hemominas.	a de doenças raras em abril de 2026. Foram realizadas 94 sessões para plasmaférese.
Projeto de Modernização da infraestrutura e logística da cadeia produtiva de hemocomponentes	Estão sendo realizados estudos para a modernização da infraestrutura, da logística e do modelo de gestão e governança da cadeia produtiva de hemocomponentes da Hemominas, abrangendo de forma integrada os pontos de coleta, processamento e produção, armazenamento, distribuição e utilização dos hemocomponentes. A iniciativa deverá avaliar alternativas para ampliar a coleta de sangue e a diversidade fenotípica da base de doadores, bem como analisar o grau adequado de centralização ou descentralização do processamento e da produção de hemocomponentes, considerando critérios de escala, eficiência, segurança, qualidade e resiliência. O estudo deverá ainda propor soluções para otimizar os fluxos logísticos e assegurar a produção e distribuição tempestivas dos hemocomponentes, compatibilizando capacidade produtiva, localização das unidades, estoques e demanda da rede assistencial.	Foi elaborada Nota Técnica com diagnóstico detalhado do cenário atual da cadeia produtiva da Hemominas. Como próxima etapa, está prevista a contratação de consultoria especializada para modelagem e definição da alternativa mais adequada de organização e governança da cadeia produtiva.

16. Pontos de Atenção no fechamento de Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão / implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Seminário Hispano-Brasileiro sobre a Cadeia Produtiva de Hemocomponentes	O seminário está previsto para dezembro, com o objetivo de promover a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas, contribuindo para subsidiar o Projeto de Modernização da Cadeia Produtiva do Ciclo do Sangue. No momento, aguarda-se retorno da Embaixada Espanhola para o prosseguimento da iniciativa.	Decisão: outubro de 2026.	Sugestão do órgão/entidade
Processos de Seleção de chefias via Transforma Minas	Seleção de profissionais para ocupar cargos de liderança de equipes da Hemominas por meio do processo Transforma Minas tendo em vista a reestruturação da Hemominas conforme decreto.	Implantação: dezembro de 2026.	Sugestão do órgão/entidade
Licitação da Construção da nova sede do Hemonúcleo de São João del Rei	Os projetos executivos estão concluídos, restando pendente a finalização da planilha orçamentária, que está em fase de revisão pela SEINFRA. Aguardamos a conclusão desta etapa para publicação do edital de licitação da obra	Decisão 31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade

17. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Automação da Produção de Hemocomponentes.	Está em andamento na Fundação Hemominas um estudo de viabilidade para implantação de equipamentos com modernas tecnologias para produção automatizada de hemocomponentes com o objetivo de otimizar a estrutura física, garantindo maior rigor na rastreabilidade e padronização de todas as etapas dos procedimentos executados na produção de hemocomponentes.	Decisão: 31/03/2027 Implantação: até 31/12/2027	Orçamentária - Sugestão do órgão/entidade.

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Posto Avançado de Coleta Externa em Teófilo Otoni	Com a implantação do Hospital Regional de Teófilo Otoni, há necessidade de implantação deste Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) para atendimento da demanda transfusional. Há possibilidade de implantação deste Posto no próprio hospital.	Decisão: até 31/01/2027 Implantação do PACE deverá ocorrer até 30/06/2027.	Orçamentária / Sugestão do órgão/entidade.
Impactos da Reforma Tributária nos contratos da Hemominas	A Reforma Tributária aprovada no Brasil (Emenda Constitucional nº 132/2023 e suas leis complementares) muda a cobrança de impostos sobre o consumo, simplificando o sistema atual com o fim de cinco tributos e a criação de dois novos tributos: CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): de competência federal (substitui PIS e Cofins). IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): de competência compartilhada entre Estados e Municípios (substitui ICMS e ISS).	Decisão: 31/01/2027	Reunião com a SEPLAG e com a SEF para discussão dos impactos financeiros da Reforma Tributária nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Contratos com pagamentos prioritários, conforme detalhamento em planilha (https://saudemg-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/clara_diniz_saude_mg_gov_br/IQD2pFvRhuiZRIirciYFaHQBAQKTH9KB6NSiPTElqy-Hthc?e=Udifkb&ovuser=0b1425d6-74c3-4378-8a72-de5bac0a82c3%2Cthais.maia%40hemominas.mg.gov.br&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24i	Pagamento de fornecedores de insumos críticos, transporte de materiais biológicos, locação de mão de obra: Fresenius – bolsa de sangue Cerus - kits de inativação de patógenos por importação direta. MGS - Serviço de Limpeza, asseio e conservação, controle de entrada e saída de bens e pessoas, apoio administrativo e operacional Sofis Informática Ltda - Manutenção e suporte técnico dos Sistemas Gerenciamento do Ciclo do Sangue, Hemote Plus Biologística Soluções em Logística e Serviços Ltda - Serviço de Transporte de Material Biológico de Origem Humana ou Animal, por via Aérea e Rodoviária. Cab Tecnologia e Sistemas Comércio Ltda - Contratação de serviços de outsourcing de impressão	O pagamento aos fornecedores segue o padrão da Hemominas e as especificidades de cada contrato. A regra é a seguinte: Liquidação - 10 dias a contar da data do recebimento definitivo Pagamento – 30 dias a contar da data da liquidação.	Contratual Legal

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
OiI0OS8yNjA5MTcxMjIyMiIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D)			
Mudança da sede da Administração Central para sede própria	A Fundação Hemominas ocupa um imóvel alugado para funcionamento da Administração Central. A Fundação João Pinheiro cedeu o imóvel, identificado pelo código nº 012759-7, localizado na Avenida Brasil, nº 674, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Este imóvel já foi reformado e está parcialmente ocupado por setores da Administração, no entanto este imóvel consta na lista de imóvel disponibilizado no PROPAG, para abatimento da dívida do estado. Estamos aguardando a definição se este imóvel será disponibilizado para o governo federal. Foi realizada uma consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) quanto à possibilidade de exclusão deste imóvel das negociações do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), no âmbito do processo SEI 2320.01.0008255/2025-15. Esclarecemos que a cessão do imóvel à Fundação Hemominas tem como finalidade abrigar sua Administração Central, atualmente instalada em imóvel alugado. O prédio já se encontra parcialmente ocupado e foi submetido a obras de reforma, com investimentos no valor de R$ 1.039.657,95, além de aquisição de mobiliários.	Decisão 31/01/2027	Legal, orçamentária, sugestão do órgão/entidade
PBM - Manejo do Sangue do Paciente	Resumo: O PBM consiste em diretivas para gerenciamento do sangue do próprio paciente, estimulando a preservação e uso racional do sangue, o tratamento de anemias pré-operatórias e alternativas à transfusão alogênica.	Decisão 31/01/2027	Legal

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
	A partir de sua implementação observa-se a diminuição dos riscos transfusionais, melhora na evolução do paciente e desfechos, priorizando a saúde do sangue e atendendo às melhores práticas hemoterápicas, proporcionando o fortalecimento das ações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG). Etapas: A política de PBM para o Estado de Minas Gerais encontra-se em fase de minuta, tendo sido aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde. Próximas etapas: - Submissão ao procedimento de aprovação na SES para encaminhamento à Câmara Técnica -Aprovação na câmara Técnica -Deliberação em CIB -Desenvolvimento de Estudos Técnicos Preliminares para contratação dos serviços -Lançamento de Edital para Contratações para operacionalização da política -Efetivação das contratações e início da implementação		

ANEXO IV
RELATÓRIO DE GESTÃO – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

18. Competências da Vinculada

A Fundação Ezequiel Dias – Funed tem como competência realizar pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública, pesquisar e produzir medicamentos, bem como realizar análises laboratoriais relacionadas aos agravos à saúde coletiva, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de saúde.

A Funed é regida pelo Decreto nº 47.910, de 7 de abril de 2020. A legislação vigente pode ser consultada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/DEC/47910/2020/.

A Funed é composta por 4 (quatro) diretorias, cujas competências estão apresentadas a seguir:

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF: tem como competência garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento administrativo, em consonância com as diretrizes estratégicas da Funed.

Diretoria do Instituto Octávio Magalhães – DIOM: é o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais – Lacen-MG e tem como competência prevenir e controlar riscos à saúde pública por meio da realização de análises laboratoriais, pesquisas, desenvolvimento, inovação e produção de conhecimento, fortalecendo as ações de vigilância em saúde e contribuindo para a promoção e proteção da saúde pública.

Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento – DPD: tem como competência planejar, coordenar e executar pesquisas científicas e tecnológicas da Funed.

Diretoria Industrial – DI: tem como competência desenvolver, aperfeiçoar, produzir e distribuir medicamentos, soros e vacinas, visando atender prioritariamente ao Sistema Único de Saúde – SUS.

19. Organograma da Vinculada

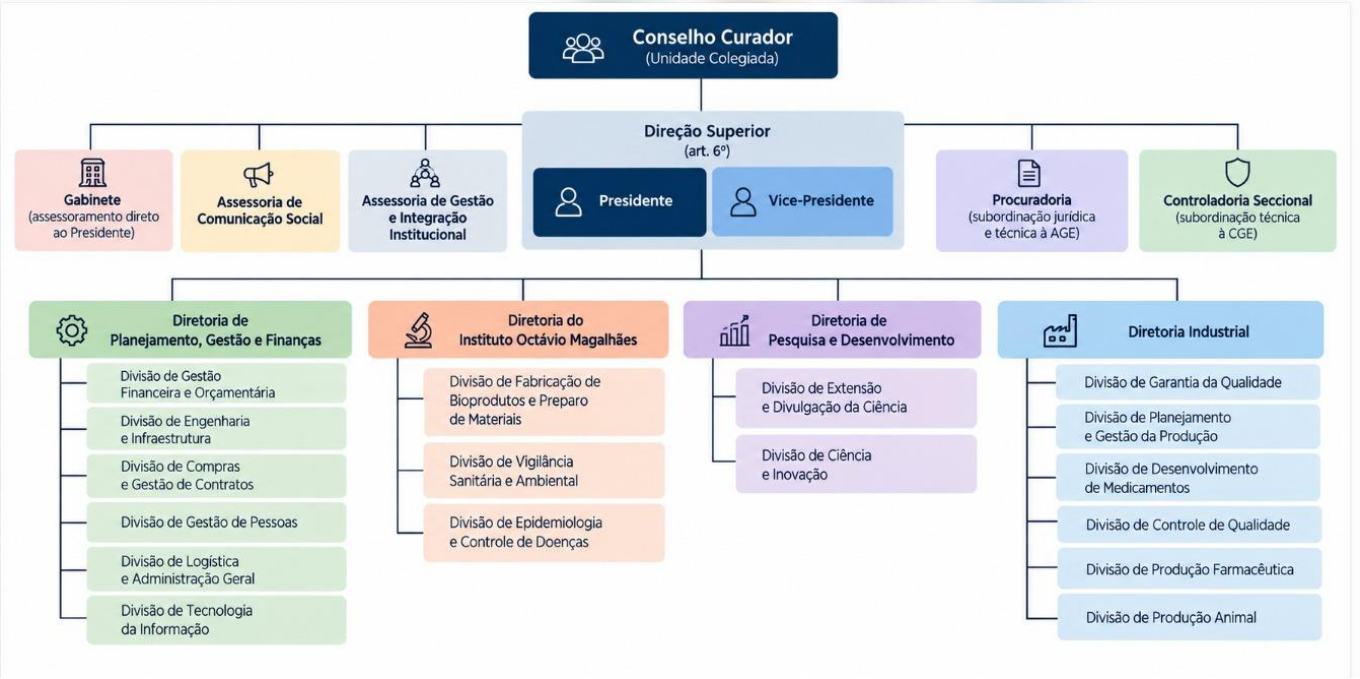


Figura 1 – Representação do Organograma da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), considerando as relações funcionais previstas no Decreto nº 47.910, de 7 de abril de 2020, que contém seu Estatuto.

20. Caderno de Entregas da Vinculada

20.1. Entregas Prioritárias

Produção de medicamentos

- **Descrição da Entrega:** A Fundação Ezequiel Dias (Funed) desempenha papel estratégico no fornecimento de medicamentos e imunobiológicos ao Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a implementação de políticas públicas nacionais de saúde, especialmente no âmbito da Assistência Farmacêutica e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

  A Diretoria Industrial é responsável pela gestão das unidades fabris e pela condução dos processos de produção de medicamentos sintéticos e biológicos e de soros heterólogos, observados os requisitos regulatórios e as normas de qualidade aplicáveis. Sua atuação envolve a manutenção das condições operacionais necessárias à produção, o atendimento aos requisitos sanitários e a execução dos contratos de fornecimento pactuados com o Ministério da Saúde (MS).

  Os produtos fornecidos pela Funed estão associados a diferentes políticas públicas e estratégias nacionais de saúde. O Entecavir e a Talidomida integram o conjunto de medicamentos utilizados no âmbito da assistência farmacêutica do SUS, relacionados, respectivamente, ao tratamento da hepatite B e às estratégias de enfrentamento da hanseníase. A Insulina Humana contribui para a assistência às pessoas com diabetes mellitus. As vacinas meningocócicas C e ACWY integraram as estratégias de prevenção de doenças imunopreveníveis, enquanto os soros hiperimunes estão

associados à prevenção e ao tratamento de agravos específicos, conforme as indicações de cada produto.

Importa mencionar, com a devida transparência, que a Funed não dispõe, nas condições atuais, de capacidade técnica, estrutural ou operacional para produzir integralmente, em todas as etapas produtivas, tanto a vacina MenC quanto a MenACWY, sequer em escala laboratorial. Nesse contexto, estão em fase final o processo de accountability da transferência de tecnologia da vacina MenC e a formalização do distrato da transferência de tecnologia da vacina MenACWY.

- **Quantidade realizada:** No período de 2023 a agosto de 2026, a Funed realizou entregas de medicamentos e imunobiológicos ao Ministério da Saúde, conforme os contratos vigentes. Os quantitativos registrados por produto e exercício são apresentados na Tabela 1, permitindo acompanhar a evolução das entregas e a participação institucional no atendimento às demandas nacionais do SUS.

Tabela 1 – Entrega de medicamentos e imunobiológicos ao Ministério da Saúde, por produto e ano, 2023 a agosto de 2026.

PRODUTO	QUANTITATIVOS ENTREGUES				Total no período
	2023	2024	2025	2026 (Até ago)	
Entecavir	5.440.000 comprimidos	5.162.430 comprimidos	2.009.700 comprimidos	1.990.350 comprimidos	**14.602.480 comprimidos**
Talidomida	2.774.220 comprimidos	3.192.000 comprimidos	4.709.000 comprimidos	3.354.510 comprimidos	**14.029.730 comprimidos**
Insulina Humana (NPH e Regular) *	0	0	1.224.315 unidades	6.762.964 unidades	**7.987.279 unidades**
Vacina Meningocócica C	2.715.480 doses	5.505.620 doses	5.694.990 doses	1.177.860 doses	**15.094.950 doses**
Vacina Meningocócica ACWY*	0	0	2.257.770 doses	554.730 doses	**2.812.500 doses**

* Fornecimento iniciado em 2025.

As entregas possuem caráter contínuo e são realizadas de acordo com os instrumentos contratuais formalizados e os respectivos cronogramas de fornecimento pactuados. Dessa forma, os quantitativos apresentados refletem as entregas efetivamente realizadas em cada período, considerando as demandas do Ministério da Saúde.

Os dados de 2026 são parciais e correspondem ao período de janeiro a agosto.

- **Valor executado:** A Tabela 2 apresenta os valores orçamentários relacionados à produção de medicamentos sintéticos e biológicos, de 2023 a agosto de 2026, enquanto a Tabela 3 apresenta os valores financeiros associados ao fornecimento de medicamentos e imunobiológicos ao Ministério da Saúde, conforme os registros disponíveis para o período de 2023 a agosto de 2026. Os valores demonstram a dimensão financeira da atuação institucional no fornecimento desses produtos durante o período analisado.

Tabela 2 – Valores orçamentários relacionados à produção de medicamentos sintéticos e biológicos, de 2023 a agosto de 2026.

AÇÃO	VALORES ORÇAMENTÁRIOS				Total no período
	2023	2024	2025	2026 (Até ago)	
Medicamentos Sintéticos	R$ 28.727.323,71	R$ 40.674.289,74	R$ 31.498.563,34	R$ 27.609.171,04	**R$ 128.509.347,83**
Medicamentos Biológicos	R$ 189.213.793,32	R$ 409.477.771,72	R$ 321.465.883,99	R$ 87.148.652,46	**R$ 1.007.306.101,49**

Tabela 3 – Receita arrecadada com o fornecimento de medicamentos ao Ministério da Saúde, de 2023 a agosto de 2026.

PRODUTO	Valores Arrecadados				Total no período
	2023	2024	2025	2026 (Até ago)	
Entecavir	R$ 50.220.750,00	R$ 31.345.440,00	R$ 20.281.056,00	R$ 28.359.552,00	**R$ 130.206.798,00**
Talidomida	R$ 4.743.616,20	R$ 8.456.960,30	R$ 10.444.055,00	R$ 7.547.647,50	**R$ 31.192.279,00**
Insulina Humana (NPH e Regular)*	0	0	R$ 17.015.130,05	R$ 125.064.369,95	**R$ 142.079.500,00**
Vacina Meningocócica C	R$ 135.162.636,40	R$ 329.797.568,20	R$ 266.445.129,60	R$ 105.238.598,40	**R$ 836.643.932,60**
Vacina Meningocócica ACWY*	0	0	R$ 178.162.626,60	R$ 103.284.248,40	**R$ 281.446.875,00**
TOTAL	**R$ 190.127.002,60**	**R$ 369.599.968,50**	**R$ 492.347.997,25**	**R$ 369.494.416,25**	**R$ 1.421.569.384,60**

* Fornecimento iniciado em 2025.

- **Origem dos recursos:** Os recursos orçamentários destinados à execução das atividades da Fundação Ezequiel Dias são provenientes do orçamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), à qual a Fundação está vinculada.
- **Data de início e fim:** Janeiro/2023 a Agosto/2026
- **No Status (concluída, em andamento):** Em andamento – atividade contínua realizada de acordo com os instrumentos contratuais formalizados e os respectivos cronogramas de fornecimento pactuados junto ao Ministério da Saúde

Pesquisa e Popularização da Ciência

- **Descrição da Entrega:** A Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da Fundação Ezequiel Dias (Funed) desenvolve atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação, formação de recursos humanos e difusão do conhecimento, orientadas às necessidades da saúde pública e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde. As pesquisas abrangem áreas como doenças infecciosas, resistência antimicrobiana, oncologia, vigilância epidemiológica e ambiental, venenos e toxinas animais, métodos laboratoriais e produtos biotecnológicos.

  Entre 2022 e 2026, a Funed registrou produtos científicos e pedidos de patente e de registro de software, conforme apresentado nas Figuras 1 e 2.



Figura 1 – Produtos Científicos Gerados, 2022 a setembro de 2026.

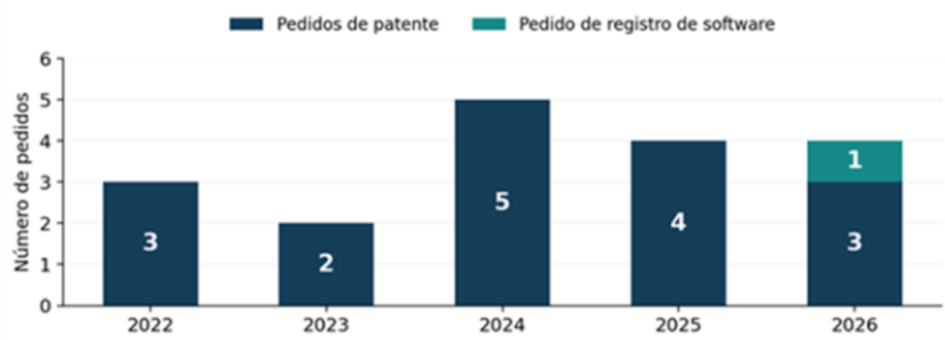


Figura 2 – Pedidos de patente e de registro de software realizados pela Funed, 2022 a 2026.

A DPD também promove a popularização da ciência e a educação em saúde por meio de programas como Ciência em Movimento, Funed na Escola, Quero Ser um

Cientista e Com Escorpião Não se Brinca, além de visitas institucionais, participação em eventos científicos, premiações, treinamentos e atividades de divulgação e formação. Essas iniciativas buscam ampliar o acesso ao conhecimento científico e aproximar a Instituição da sociedade, alcançando diferentes públicos e municípios mineiros.

- **Quantidade realizada:** Em 2026, a DPD registra os seguintes indicadores de pesquisa e formação de recursos humanos:
    - 84 projetos de pesquisa em andamento;
    - 31 parcerias de pesquisa;
    - 151 orientações de iniciação científica;
    - 70 mestres formados no acumulado do programa;
    - 11 grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

    Esses indicadores demonstram a abrangência das atividades de pesquisa e formação de recursos humanos desenvolvidas pela Instituição.

    A produção científica e as iniciativas de proteção à propriedade intelectual também integram os resultados institucionais. A Figura 1 apresenta os produtos científicos gerados entre 2022 e 2026, enquanto a Figura 2 apresenta os pedidos de patente e de registro de software realizados no mesmo período.

- **Valor executado:** A execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento envolve recursos orçamentários destinados à manutenção e ao desenvolvimento das ações institucionais.

  A Tabela 4 apresenta os valores orçamentários referentes à ação de Pesquisa e Desenvolvimento entre 2023 e agosto de 2026, permitindo acompanhar a dimensão orçamentária dessas atividades.

Tabela 4 – Valores Orçamentários relacionados à ação de Pesquisa e Desenvolvimento, de 2023 a agosto de 2026.

AÇÃO	VALORES ORÇAMENTÁRIOS				Total no período
	2023	2024	2025	2026 (Até ago)	
Pesquisa e Desenvolvimento	R$ 26.438.868,38	R$ 28.766.214,01	R$ 21.460.814,81	R$ 8.719.766,23	**R$ 85.385.663,43**

- **Origem dos recursos:** Fonte 10
- **Data de início e fim:** Período de 2022 a agosto de 2026, sendo:

- Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, produção científica e propriedade intelectual: período de 2022 a 2026, conforme os dados apresentados nas Figuras 1 e 2.
- Execução orçamentária da ação de Pesquisa e Desenvolvimento: período de 2023 a agosto de 2026, conforme a Tabela 4.
- Indicadores de pesquisa e formação de recursos humanos: dados registrados em 2026.
- Programa Quero Ser um Cientista: criado em 2023.
- Programa Com Escorpião Não se Brinca: lançado em 2026.

- **No Status (concluída, em andamento):** Em andamento, considerando a natureza das iniciativas informadas.

20.2. Outras Entregas Relevantes

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status
Modernização laboratorial e de gestão - Sistemas ERP, LIS e LIMS	Implantação de sistemas para integrar a gestão industrial, administrativa e financeira e aprimorar o controle e a rastreabilidade laboratorial. • ERP com 20% de execução; • LIS implantado em 2025, com simplificação dos fluxos e redução do tempo de liberação de laudos e resultados de exames; • LIMS com 93,08% de implantação e conclusão prevista para dezembro de 2026.	Em andamento, com LIS implantado.
Retomada da produção de soros hiperimunes	Reinauguração da fábrica em março de 2025 e retomada da produção, com transferência gradativa para a Unidade V. Lotes produzidos ou em conclusão correspondem a 32.584 ampolas, com fornecimento ao Ministério da Saúde previsto para novembro e dezembro de 2026, condicionado à formalização contratual.	Em andamento, com fábrica reinaugurada, produção retomada e contrato de fornecimento em formalização.
Planejamento e reposicionamento institucional – FGV	Elaboração de estudos de modelagem de negócio para subsidiar decisões sobre a estrutura jurídica e organizacional, o posicionamento estratégico, a governança e a sustentabilidade econômico-financeira da FUNED, em alinhamento às necessidades do SUS.	Em andamento, com conclusão prevista para dezembro de 2026.

Políticas Públicas continuadas do Sistema

20.3. Políticas Públicas Prioritárias

4.1.1. Vigilância Laboratorial em Saúde Pública

- **Descrição da política:** A FUNED, por meio da Diretoria do Instituto Octávio Magalhães (DIOM), atua como Laboratório Central de Saúde Pública de

Minas Gerais (Lacen-MG), exercendo papel estratégico na vigilância laboratorial e na coordenação técnica da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (RESLP-MG), composta por 38 laboratórios. Sua atuação subsidia a vigilância, a prevenção e o controle de doenças e agravos, a investigação de surtos e a resposta a eventos relevantes para a saúde pública. As atividades abrangem a vigilância epidemiológica, com participação em resistência antimicrobiana; a vigilância sanitária e ambiental, incluindo o monitoramento da qualidade da água, de produtos, de resíduos de agrotóxicos e de riscos à saúde; e a articulação internacional, por meio da participação em iniciativas da OPAS, da OMS e da FAO, incluindo análises físico-químicas e microbiológicas de medicamentos sob demanda da OMS.

- **Resultados alcançados:** A atuação do Lacen-MG ultrapassa a realização de análises de rotina. Sua relevância institucional decorre também da coordenação técnica da rede estadual, da participação em redes de referência e da geração de informações que apoiam decisões de vigilância e regulação sanitária e ambiental. Para dimensionar a entrega no relatório de transição, recomenda-se consolidar os seguintes indicadores, para cada ano de 2023 a 2026, com dados de 2026 acumulados até agosto:

Produção Analítica IOM	2023	2024	2025	2026 (até setembro)	Total no período
Amostras recebidas	260.387	422.474	249.291	210.856	**1.142.008**
Análises realizadas	1.016.308	1.701.986	1.600.826	1.255.088	**5.574.208**

- **Valores executados:** Seguem valores orçamentários executados.

AÇÃO	VALORES ORÇAMENTÁRIOS				Total no período
	2023	2024	2025	2026 (Até ago)	
Atendimento de análises laboratoriais de interesse da saúde pública	R$ 54.334.138,98	R$ 63.308.939,10	R$ 31.671.961,21	R$ 15.924.605,55	**R$ 165.239.644,84**

- **Origem dos recursos:** Orçamento estadual, Ministério da Saúde e SES/MG.
- **Prejuízo de descontinuidade:** A interrupção ou redução da capacidade operacional do Lacen-MG pode comprometer o diagnóstico laboratorial, a coordenação técnica da rede estadual e a resposta às demandas de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Nesse sentido, sugere-se à próxima gestão assegurar a continuidade da capacidade analítica, da infraestrutura laboratorial, das equipes técnicas, dos insumos e dos recursos necessários ao cumprimento das atribuições do Lacen-MG.

21. Pontos de Atenção no fechamento de Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão / implantação	Causa da Urgência
Fornecimento de medicamentos ao Ministério da Saúde	Cumprir as parcelas de entecavir e insulinas previstas para 2026 e preparar a remessa de talidomida reagendada para janeiro de 2027, assegurando produção, liberação e logística.	31/10/2026, bem como observar as datas de cada parcela.	Contratual
Formalização e fornecimento de soros hiperimunes	Concluir a formalização do contrato com o MS e viabilizar as entregas previstas para novembro e dezembro, observadas a conclusão dos lotes e as condições regulatórias.	30/10/2026, sugerido para formalização; fornecimento conforme cronograma contratual.	Sugestão do órgão/entidade
Conclusão do estudo de modelagem – FGV	Concluir os ajustes, a avaliação e o aceite dos produtos contratados, organizando os estudos e as recomendações para a nova gestão.	18/12/2026, conforme término contratual informado.	Contratual
Preparação para o GRP Minas e continuidade do ERP	Preparar a FUNED para a entrada em operação do GRP em janeiro de 2027 e consolidar as etapas, integrações e responsabilidades do ERP para continuidade da implantação.	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade
Manutenção, infraestrutura e segurança da informação	Concluir as contratações prioritárias de manutenção e calibração, as adequações dos Biotérios e da DIVISA e as aquisições de proteção e armazenamento de dados.	31/12/2026, observar vencimentos e cronogramas específicos.	Sugestão do órgão/entidade
Planejamento orçamentário e de compras de 2027	Consolidar contratações, despesas e necessidades financeiras de 2027, priorizando insumos, serviços essenciais e obrigações de fornecimento ao SUS.	31/12/2026	Contratual
Fundação de apoio e continuidade da pesquisa	Concluir a instrução da contratação da fundação de apoio para os projetos de pesquisa e consolidar pendências de bolsas, parcerias e infraestrutura científica.	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade
Continuidade da vigilância laboratorial	Assegurar o processamento das amostras e a emissão dos laudos pactuados, preservando insumos, capacidade operacional e programas de monitoramento sanitário e ambiental.	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade
Instruir o processo de conclusão da Transferência de Tecnologia da	Concluir a elaboração da minuta de formalização do encerramento da Transferência de Tecnologia da vacina MenACWY e realizar o accountability, especialmente,	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão / implantação	Causa da Urgência
Vacina MenACWY e *Accountability* da Vacina MenC	obrigacional e regulatório, da vacina MenC		

22. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência
Continuidade das autorizações e da execução financeira	Assegurar a designação dos ordenadores de despesa e do responsável legal, com acessos aos sistemas, evitando interrupções em pagamentos, contratações e obrigações institucionais.	Dependente da alteração ou manutenção na designação dos responsáveis assim como da disponibilidade para a execução das atividades legais	Sugestão do órgão/entidade
Fornecimento de medicamentos e biológicos ao SUS	Acompanhar contratos, produção, estoques e entregas de entecavir, insulinas e soros, incluindo cadeia de frio e parceria com Farmanguinhos. Buscar a continuidade do contrato/aditivo de talidomida.	Jan/2027	Contratual
Operação do GRP Minas e continuidade do ERP	Acompanhar a entrada em operação do GRP Minas, definir suporte e responsáveis e compatibilizar sua utilização com a implantação do ERP e as rotinas financeiras.	Jan/2027	Sugestão do órgão/entidade
Disponibilidade orçamentária e financeira	Acompanhar o carregamento do orçamento e priorizar recursos para contratos, insumos e serviços essenciais, considerando as obrigações de fornecimento e as receitas previstas.	Jan/2027	Sugestão do órgão/entidade
Resposta laboratorial a surtos e emergências	Confirmar insumos, pessoal, manutenção e protocolos de contingência do Lacen-MG para responder às arboviroses e demais emergências, preservando os programas sanitários e ambientais.	Jan/2027	Sugestão do órgão/entidade
Contratos e suprimentos essenciais	Revisar contratos com vencimento no trimestre e priorizar renovação ou nova contratação de manutenção, calibração, segurança, insumos e	Jan/2027, com antecedência aos vencimentos específicos.	Contratual

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão / implantação	Causa da Urgência
	serviços necessários às atividades finalísticas.		
Regularização das instalações e condições operacionais	Priorizar pendências de regularização relacionadas à segurança contra incêndio, Biotérios, efluentes, refeitório e armazenamento de inflamáveis, além de eventuais exigências decorrentes da inspeção de Boas Práticas de Fabricação.	Jan/2027, sem prejuízo dos prazos das exigências específicas	Sugestão do órgão/entidade
Avaliação das recomendações da FGV	Apresentar os estudos à nova gestão e definir prioridades e responsáveis para avaliar as alternativas de possível reposicionamento institucional e adotar os encaminhamentos viáveis.	Mar/2027	Sugestão do órgão/entidade

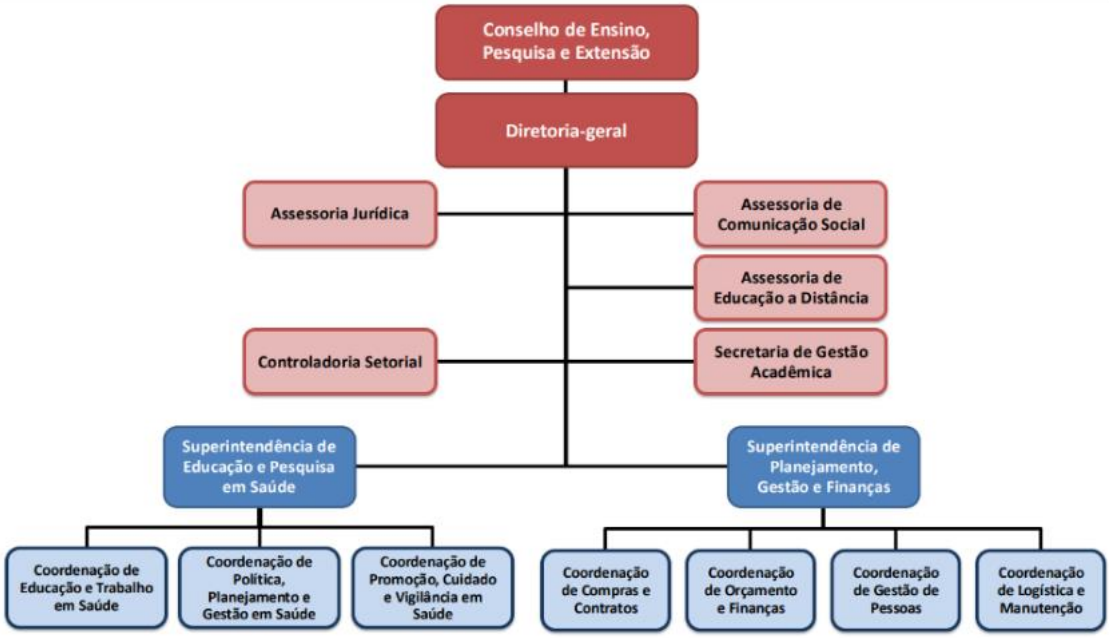
ANEXO V
RELATÓRIO DE GESTÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ESP-MG)

23. Competências da Vinculada

Em seus 80 anos de trajetória, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG) consolidou-se como uma instituição de referência nacional na formação de profissionais, na produção de conhecimento e no fortalecimento das políticas públicas de saúde, contribuindo de forma estratégica para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais. Nesse contexto, compete à ESP-MG planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas ao ensino, à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento institucional e de recursos humanos no âmbito do SUS. São suas atribuições: I. promover a qualificação dos profissionais do SUS, por meio de ações educacionais de pós-graduação, formação técnica, cursos livres, seminários, dentre outros, tendo como referencial a educação permanente em saúde; II. desenvolver ações de educação na modalidade a distância, com o uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação; III. desenvolver ações de pesquisa, no âmbito do SUS, visando à produção de conhecimentos que tenham aplicação no sistema de saúde; IV. desenvolver projetos de cooperação para apoio técnico e institucional junto a entes governamentais e instituições, no âmbito do SUS e; V. produzir materiais técnicos, científicos e pedagógicos de interesse do SUS e voltados à propagação e difusão do conhecimento em saúde pública.

Decreto N.º 48.711, de 26/10/2023: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48711/2023/

24. Organograma da Vinculada



25. Caderno de Entregas da Vinculada

25.1. Entregas Prioritárias

Ciclos de Formação do Projeto Saúde Em Rede

- **Descrição da Entrega:** O Projeto Estratégico "Saúde em Rede" reorganizou a Rede de Atenção à Saúde em Minas Gerais, por meio da readequação de processos de trabalho no âmbito da Atenção Primária à Saúde e dos serviços de referência da Atenção Ambulatorial Especializada. A ESP-MG foi responsável pelo desenvolvimento dos ciclos de formação do projeto de expansão, que compreenderam a oferta do Curso de Formação Inicial na modalidade de Educação à distância, a formação dos analistas regionais, o acompanhamento da formação dos tutores e o monitoramento das oficinas tutoriais nos municípios. O protagonismo da ESP-MG foi fundamental para a implantação desse Projeto Estratégico, que tinha como estratégia a mudança das práticas e da gestão do cuidado em saúde, em todo o estado.
- **Quantidade realizada:** Cerca de 51 mil profissionais de saúde participantes
- **Valor executado**: R$1.414.000,00
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual
- **Data de início e fim:** 2021 a 2025
- Status: Concluída

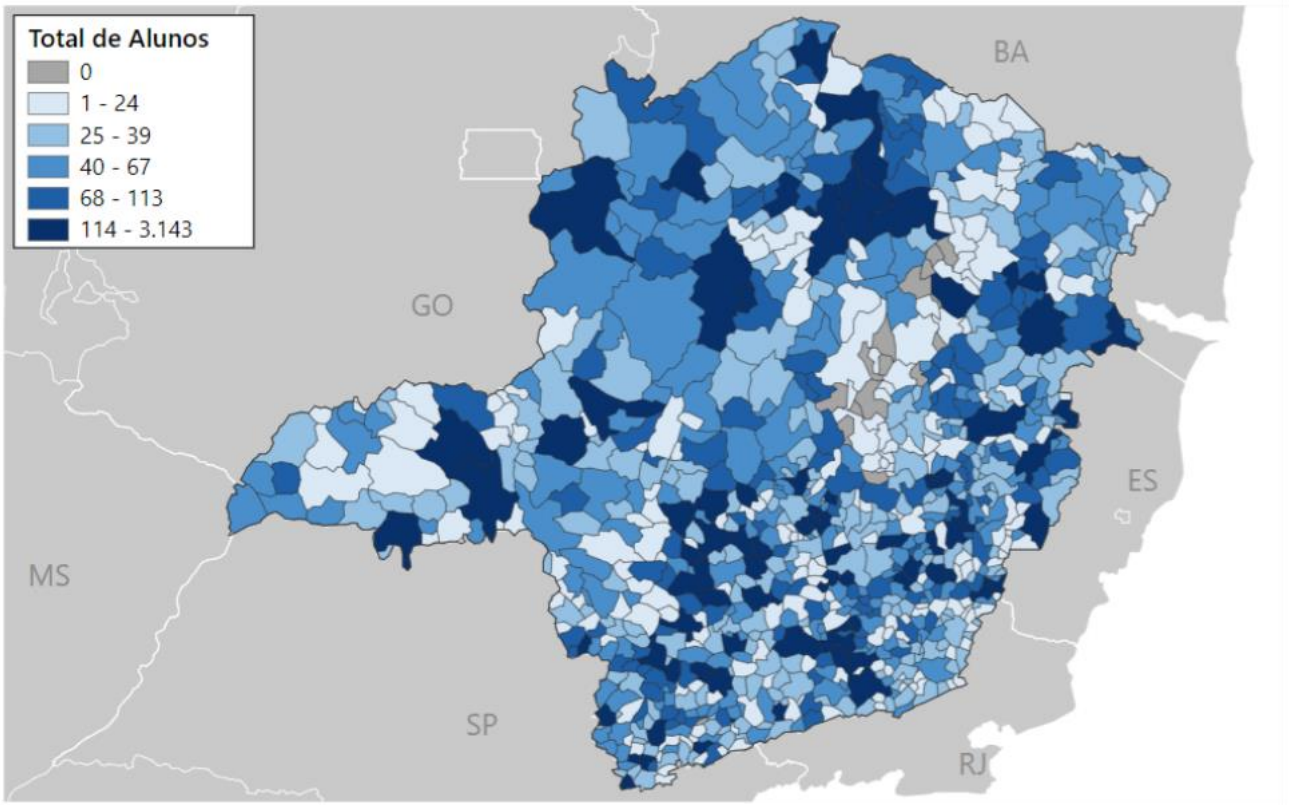
Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) - Nível Fundamental

- **Descrição da Entrega:** A ação educacional Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) - Nível Fundamental é uma iniciativa do Ministério da Saúde, realizada pela ESP-MG, em parceria com a SES/MG. Trata-se de uma formação inicial e continuada prevista no Plano Estadual de Saúde 2024/2027, cuja

implantação foi aprovada pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.589/2024. É um curso presencial que visa qualificar os trabalhadores do SUS que atuam direta ou indiretamente nos diferentes setores da Vigilância em Saúde e Atenção à Saúde, por meio de reflexões e análises críticas sobre as práticas nos serviços de saúde no campo da Vigilância em Saúde em suas múltiplas dimensões e interfaces. Esse projeto ganha especial relevância no contexto de Minas Gerais, em função das experiências aqui vivenciadas no âmbito das emergências em saúde pública nos últimos anos.

- **Quantidade realizada:** 11 turmas em 2025 e 2026 (Macrorregiões de saúde: Centro, Sul; Centro Sul; Sudeste; Extremo Sul; Nordeste; Sudoeste; Triângulo Norte; Oeste; Norte e Leste Sul), totalizando 255 profissionais de saúde egressos
- **Status:** Em andamento, com previsão de realização de seis turmas em 2027.
- **Valor executado**: R$ 431.710,00
- **Origem dos recursos:** TDCO 008/2024 - SES/SUBGF-SPF-DCR-CFC (Fonte 92)
- **Data de início e fim:** Junho/2025 a dezembro/2027
- **Status:** Em andamento, com previsão de realização de seis turmas em 2027.

Abrangência municipal das ações educacionais do Projeto Saúde em Rede



25.2. Outras Entregas Relevantes

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status
	Especialização em Saúde Pública - 2024	Concluída

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status
Cursos de Pós-graduação *lato sensu* (Especialização)	Especialização em Saúde Pública - 2026	Concluída
	Especialização em Direito Sanitário - 2023 (duas turmas)	Concluída
	Especialização em Direito Sanitário - 2026	Concluída
	Especialização em Gestão do SUS - 2027	Em andamento
	Especialização em Saúde Pública - Saúde no Sistema Prisional - 2026	Concluída
	Especialização em Políticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial - 2023	Concluída
	Especialização em Políticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial - 2025	Concluída
	Especialização em Políticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial - 2027	Em andamento
	Especialização em Vigilância em Saúde	Concluída
Curso Técnico	Curso Técnico em Saúde Bucal	Em andamento
Cursos de Qualificação na área de Política, Planejamento e Gestão	Curso Introdutório de Gestão de Políticas Públicas do SUS - 8 ofertas de cursos	Concluído
	Formação de Pessoas Ativadoras do Controle Social no SUS em Minas Gerais - 3 ofertas	Concluída
	Oficina Minas Mostra o SUS – 3 ofertas	Concluída
	Série de webinários “Perspectivas em Regionalização do SUS”	Concluída
	Série de webinários “Controle Social do SUS em MG”;	Em andamento
Cursos de Qualificação na Área de Saúde Mental	Oficina de Aprofundamento em Saúde Mental: Infância e Adolescência hoje	Concluída
	Qualificação da Atenção em Leitos de Saúde Mental na RAPS-MG (EaD) - 2 ofertas	Concluída
	Saúde Mental na Atenção Primária: construindo parcerias para o cuidado (EaD) - 9 ofertas	Concluída
	Projeto Nós na Rede: Formação em Atenção Psicossocial, Desinstitucionalização e Redução de Danos	Concluído
Cursos de Qualificação na Área de Educação e Trabalho em Saúde	Curso Introdutório em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	Concluído
	Curso "Práticas Corporais nos Polos de Academias da Saúde de Minas Gerais: formação de instrutores de Tai Chi Chuan (Taiji Quan) e Qi Gong" - 3 ofertas	Concluído
	Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde - 11 ofertas	Concluída
	Capacitação pedagógica dos docentes do Curso de Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde - 2 ofertas	Concluída

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status
	Oficina Macrorregional de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador: Controle Social e discussões no SUS - 4 ofertas	Concluída
	Curso de Educação em Saúde nas Práticas do ACS (EaD) - 22 ofertas	Concluído
	Curso de Gestão da saúde no Sistema Prisional (EaD) - 2 ofertas	Concluído
	Curso Trabalho e Saúde Mental no Sistema Prisional (EaD) - 3 ofertas	Concluído
	Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde (ACS) (EaD) - 11 ofertas	Concluído
Cursos de Qualificação na Área da Promoção, Cuidado e Vigilância em Saúde	Capacitação para Administração da Vacina BCG (EaD) - 3 ofertas	Concluída
	Percurso Formativo do Fiscal de Vigilância Sanitária (EaD) - "Conhecimentos Introdutórios para atuação em Vigilância Sanitária", "Fiscalização Sanitária" e "Vigilância Sanitária: conhecendo as áreas de atuação" (EaD)	Concluído
	Percurso Formativo Introdução ao Direito Sanitário (Curso “Introdução ao Direito Sanitário", “Direito Sanitário Aplicado às Políticas Públicas de Saúde” e “Judicialização e Litigância na Saúde” (EaD))	Concluído
	Curso Acolhimento e Aconselhamento para Testagem Rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (EaD) - 6 ofertas	Concluído
	Curso Básico de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho (CBVAPT) (EaD) - 6 ofertas	Concluído
	Curso Básico de Vigilância em Saúde (EaD) - 7 ofertas	Concluído
	Curso Básico de Vigilância em Saúde Ambiental (EaD) - 2 ofertas	Concluído
	Curso Introdutório para Agente de Combate a Endemias (ACE) (EaD) - 3 ofertas	Concluído
	Curso Promoção da Saúde no SUS-MG: Políticas e possibilidades de intervenção (EaD) - 8 ofertas	Concluído
	Curso Registro Hospitalar de Câncer (EaD)	Concluído
	Curso Território na Saúde: Construindo saberes com os agentes de saúde do SUS (EaD) - 4 ofertas	Concluído
	Curso Tratamento para Cessação do Tabagismo (EaD) - 4 ofertas	Concluído
	Qualificação em vacinação para trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) (EaD) - 30 ofertas	Concluída

Nome da entrega	Descrição da entrega	Status
	Qualificação Profissional para Trabalhadores de Salas de Vacina (EaD) - 36 ofertas	Concluída
	Curso Conhecer para cuidar: Introdução à saúde LGBTQIAPN+ - 3 ofertas	Concluído
	Curso Conhecer para Cuidar: Integralidade do cuidado e a população LGBTQIAPN+ - 2 ofertas	Concluído
	Curso Conhecer para cuidar: Diversidade no cuidado da população LGBTQIAPN+ na APS – 2 ofertas	Concluída

26. Políticas Públicas continuadas do Sistema

26.1. Políticas Públicas Prioritárias

Desenvolvimento de Ações Educacionais na área da Saúde

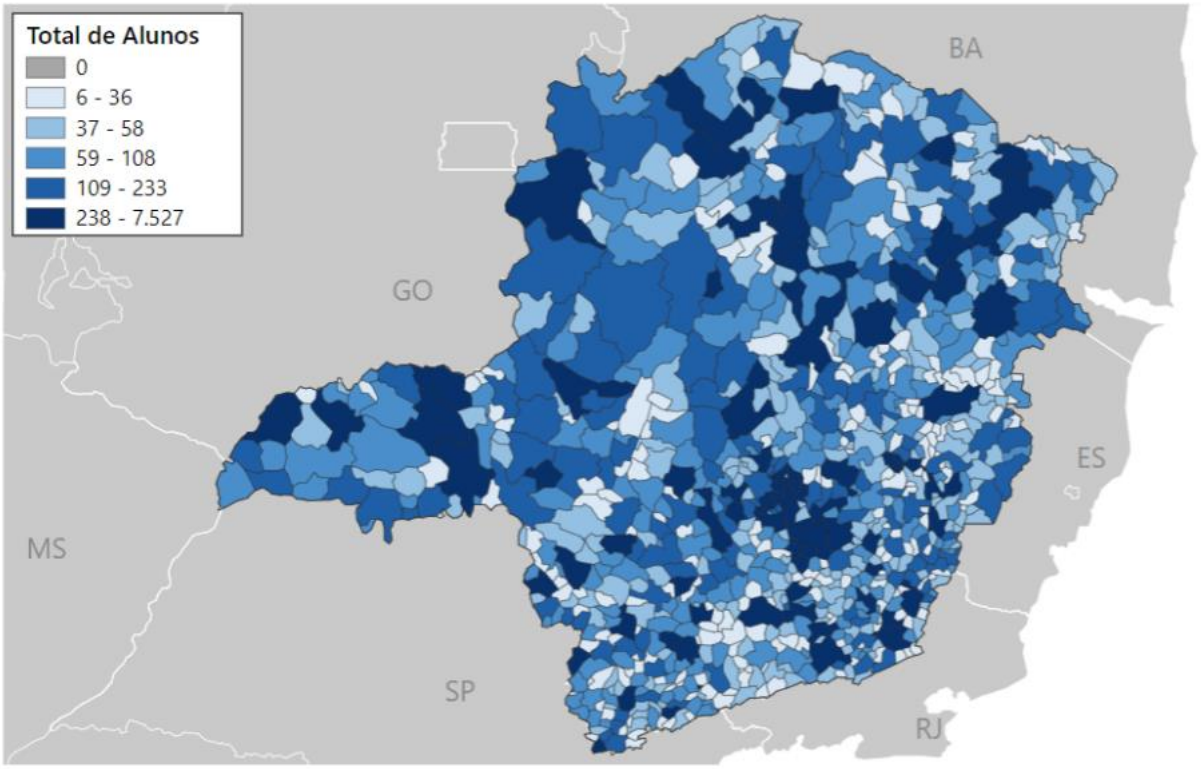
- **Descrição da Política Pública:** Essa Política constitui uma estratégia estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, voltada à qualificação contínua dos trabalhadores, gestores, conselheiros e demais atores envolvidos na formulação, gestão e execução das políticas públicas de saúde. Sua execução ocorre por meio da oferta de ações educacionais em diferentes modalidades e formatos, incluindo cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de qualificação e atualização profissional, cursos técnicos e pós-técnicos e seminários, desenvolvidos em consonância com as prioridades da política estadual de saúde e as necessidades identificadas nos territórios. Trata-se de uma política transversal que apoia diretamente a implementação das diversas políticas, programas e redes de atenção à saúde do Estado, contribuindo para o fortalecimento da atenção primária, da vigilância em saúde, da assistência especializada, da gestão do SUS e do controle social, conforme descrito no tópico 3.2.
- **Resultados alcançados:** Qualificação de **mais de 100 mil trabalhadores, em 77 ações educacionais realizadas**, no período de 2023 a agosto/2026, ampliando a capacidade técnica das equipes de saúde em **todos os municípios mineiros**, contribuindo para a implementação das políticas públicas prioritárias do Estado.
- **Valor executado**: R$ 9.200.000,00
- **Origem dos recursos:** Tesouro Estadual
- **Prejuízo de descontinuidade:** A eventual descontinuidade desta política acarretará impactos significativos para a capacidade do Estado de implementar, sustentar e aprimorar suas políticas públicas de saúde. A interrupção dos processos formativos comprometerá a qualificação permanente dos profissionais do SUS, reduzindo a capacidade de resposta dos serviços de saúde às demandas da população e dificultando a incorporação de protocolos, diretrizes e inovações necessárias ao aperfeiçoamento das ações de saúde. Destaca-se que se encontram em andamento hoje diversas ações educacionais, contemplando o Curso Técnico de Saúde Bucal e as especializações em Saúde Pública, Direito Sanitário, Gestão do SUS e Políticas de Saúde Mental e Atenção

Psicossocial. Além disso, a descontinuidade enfraquecerá a execução de programas estratégicos do Governo de Minas Gerais, uma vez que a formação e o desenvolvimento de recursos humanos constituem condição essencial para a efetividade das políticas de atenção à saúde, vigilância, gestão e regionalização do SUS. Em razão de seu caráter estruturante, esta política não se limita à oferta de ações educacionais, mas representa um investimento contínuo na sustentabilidade, na qualidade e na capacidade de inovação do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. Em última instância, a descontinuidade impactará a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, com prejuízos, portanto, para o cidadão mineiro, destinatário das políticas do SUS.

Gráfico de Ações Educacionais desenvolvidas, no período de 2023 a agosto/2026



Abrangência das Ações Educacionais – 2023 a agosto/2026



26.2. Outras Políticas Públicas Relevantes

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
Produção de Conhecimento em Saúde Coletiva	Tem como objetivo produzir, sistematizar e disseminar conhecimentos técnicos, científicos e educacionais que contribuam para o fortalecimento do SUS/MG. Abrange a realização de pesquisas, elaboração de materiais técnicos e educacionais, publicação de livros e artigos científicos, apresentação de trabalhos em eventos científicos, orientação de trabalhos, dentre outros, promovendo a qualificação da gestão, da formação e das práticas de cuidado no âmbito do SUS.	No período, destacam-se: - Projetos de pesquisa em desenvolvimento: - Atenção Ambulatorial Especializada em Minas Gerais: análise de processos de implementação e de funcionamento dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE); - Tai Chi Chuan e Qi Gong: experimentações corporais em um processo formativo e práticas nos polos das Academias da Saúde - Formação de profissionais de nível médio pela ESP-MG: trajetórias e implicações no mundo do trabalho - Publicação de livros: - Escritas e vivências nos Centros Estaduais de Atenção Especializada de Minas Gerais - Nada será como antes: invenções cotidianas para o cuidado em liberdade nas redes de atenção psicossocial; - Saúde e trabalho no sistema prisional; - Caminhando contra o vento: cuidado e cidadania na atenção aos usuários de drogas no SUS; - Ela/Dela: vida e saúde de mulheres trans e travestis de Minas Gerais - 15 artigos publicados em diversas áreas da saúde coletiva; - 14 capítulos de livros - 92 trabalhos aprovados ou apresentados em eventos científicos.
Dimensionamento da força de trabalho da ESP-MG (MAP)	Realização do dimensionamento da força de trabalho da ESP-MG, utilizando a metodologia de Mapa de Atribuição por Produto (MAP), em atendimento à iniciativa conduzida pela SEPLAG junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. O estudo permitiu sistematizar informações sobre	Conclusão do estudo de dimensionamento da força de trabalho da ESP-MG, com identificação de déficit de pessoal de 30 postos de trabalho. Os resultados subsidiaram o planejamento da recomposição do quadro permanente e apontam para a necessidade de realização de

Nome da Política Pública	Descrição da Política Pública	Resultados alcançados
	a força de trabalho, as atribuições e os processos institucionais, subsidiando o planejamento institucional e o aprimoramento da gestão de pessoas na Escola.	concurso público ou processo seletivo simplificado.

27. Pontos de Atenção no fechamento de Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Preparação para o GRP Minas (Gestão de recursos e processos) e continuidade do ERP	Garantir a preparação da ESP-MG para a entrada em operação do GRP em janeiro de 2027, consolidando etapas, integrações e responsabilidades relacionadas ao ERP para assegurar a continuidade da sua implantação.	31/12/2026	Sugestão do órgão/entidade
Planejamento orçamentário e de compras de 2027	Estruturar e consolidar as demandas de contratação e o planejamento financeiro de 2027, assegurando recursos para insumos, serviços essenciais e demais compromissos relacionados ao atendimento das responsabilidades institucionais.	31/12/2026	Contratual

28. Pontos de Atenção nos meses iniciais do novo Governo

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
Continuidade da Obra de Reforma e Modernização da Sede da ESP-MG	Acompanhar e garantir a continuidade da execução da obra de reforma e modernização da sede da ESP-MG, assegurando os recursos financeiros e as providências administrativas necessárias para sua conclusão. A intervenção	Janeiro/2027	Orçamentário / Contratual

Nome da iniciativa	Descrição da iniciativa	Prazo máximo sugerido para decisão/implantação	Causa da Urgência (legal, contratual, órgão de controle, orçamentária, sugestão do órgão/entidade)
	visa adequar a infraestrutura física da Escola às necessidades de ensino, pesquisa, inovação e desenvolvimento institucional, ampliando a capacidade de atendimento das ações educacionais e técnico-científicas vinculadas ao SUS.		
Continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Gestão Acadêmica da ESP-MG	Indisponibilidade ou insuficiência de recursos financeiros e/ou de ordenador de despesas para assegurar a continuidade da execução do Contrato Montreal, podendo ocasionar atrasos no desenvolvimento e na implementação do novo sistema, comprometendo o cronograma de entregas e a modernização dos processos de trabalho da instituição.	Janeiro/2027	Contratual
Continuidade das autorizações e da execução financeira	Assegurar a designação dos ordenadores de despesa e do responsável legal, com acessos aos sistemas, evitando interrupções em pagamentos, contratações e obrigações institucionais.	Dependente da alteração ou manutenção na designação dos responsáveis assim como à disponibilidade para a execução das atividades legais	Sugestão do órgão/entidade
Disponibilidade orçamentária e financeira	Acompanhar a disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros, priorizando a cobertura de contratos, insumos e serviços essenciais, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações institucionais e a continuidade das atividades planejadas para 2027.	Jan/2027	Sugestão do órgão/entidade